

GUIA CLÍNICO E TERAPÊUTICO AVANÇADO • EDIÇÃO 2026

TRATADO DE FARMACOTERAPIA E PROTOCOLOS DE CONDUTA EM PEDIATRIA E EMERGÊNCIA

*Arsenal Consolidado de 142 Entidades Diagnósticas Pediátricas e de Urgência:
Diretrizes Clínicas, Dosagens Ponderais Detalhadas, Apresentações Comerciais Brasileiras
(RMBH/MG), Medidas Não Farmacológicas, Sinais de Alarme e Checagem Reversa*

Belo Horizonte / Betim / Região Metropolitana de Minas Gerais

Diretrizes Integradas: SBP • SES-MG • Ministério da Saúde • ANVISA • AHA (PALS)

Compêndio Paginado e Estruturado para Prática Clínica

1. APRESENTAÇÃO EXECUTIVA E DIRETRIZES DE SEGURANÇA

O presente compêndio consolida a expansão integral do acervo clínico e farmacológico pediátrico e de emergência, abrangendo 142 monografias diagnósticas estruturadas. O documento foi desenhado para atuar como ferramenta de apoio à decisão médica e à prescrição segura em unidades de Pronto-Atendimento (PA), enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e Neonatal.

Tripla Checagem Obrigatória de Doses:

- Conferência Matemática:** cálculo por peso (mg/kg/dose e mg/kg/dia), conversão em volume (mL) e gotas conforme bula oficial brasileira.
- Conferência Farmacêutica:** apresentações comerciais disponíveis no mercado brasileiro e na RMBH, concentrações de frascos e ampolas.
- Conferência Clínica:** estratificação de gravidade, doses máximas absolutas, intervalos, duração, sinais de alarme e checagem reversa.

2. ÍNDICE GERAL DOS 142 DIAGNÓSTICOS POR MÓDULO

MÓDULO 01: VIAS AÉREAS E PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

- **Diag 001:** Rinofaringite Viral Aguda (Resfriado Comum) (CID-10: J00) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 002:** Rinossinusite Bacteriana Aguda (CID-10: J01.9) — *Pré-escolares e escolares (> 1–2 anos)*
- **Diag 003:** Faringoamigdalite Bacteriana Estreptocócica (CID-10: J02.0) — *>= 3 anos (pico 5 a 15 anos)*
- **Diag 004:** Crupe Viral Agudo / Laringite Estridulosa (Leve a Moderada) (CID-10: J05.0) — *6 meses a 3 anos*
- **Diag 005:** Crupe Viral Grave / Laringite com Estridor em Repouso (CID-10: J05.0) — *6 meses a 6 anos*
- **Diag 006:** Epiglote Aguda (CID-10: J05.1) — *2 a 7 anos (ou qualquer idade não vacinada)*
- **Diag 007:** Traqueíte Bacteriana Aguda (CID-10: J04.1) — *1 a 8 anos*
- **Diag 008:** Bronquiolite Viral Aguda (BVA) - Manejo de Suporte (CID-10: J21.0) — *Lactentes < 2 anos (pico < 6 meses)*
- **Diag 009:** Bronquite Aguda e Hiperreatividade Brônquica Pós-Viral (CID-10: J20.9) — *Pré-escolares e escolares*
- **Diag 010:** Crise de Asma / Broncoespasmo Agudo (Leve a Moderada) (CID-10: J45.9) — *>= 2 anos (ou sibilante recorrente)*
- **Diag 011:** Crise de Asma Grave / Ameaçadora à Vida (Manejo de Emergência) (CID-10: J45.9) — *>= 2 anos*
- **Diag 012:** Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) Típica (CID-10: J18.9) — *Todas as idades (> 2 meses)*
- **Diag 013:** Pneumonia Atípica Pediátrica (CID-10: J15.7) — *>= 5 anos (escolares e adolescentes; ocasional em pré-escolares)*
- **Diag 014:** Derrame Pleural Parapneumônico e Empiema Pleural (CID-10: J90 / J86.9) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 015:** Coqueluche / Síndrome Coqueluchoide (Bordetella pertussis) (CID-10: A37.0) — *Lactentes e crianças (maior gravidade em < 6 meses)*

MÓDULO 02: GASTROENTEROLOGIA E NUTRIÇÃO PEDIÁTRICA

- **Diag 016:** Gastroenterite Aguda Viral - Plano A de Reidratação (CID-10: A08.4) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 017:** Gastroenterite com Desidratação Leve a Moderada - Plano B (CID-10: A09 / E86) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 018:** Gastroenterite Invasiva / Disenteria Bacteriana Aguda (CID-10: A03.9 / A04.9) — *Lactentes, pré-escolares e escolares*
- **Diag 019:** Desidratação Grave com Choque Hipovolêmico - Plano C (CID-10: E86 / R57.1) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 020:** Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) Pediátrica (CID-10: K21.0 / K21.9) — *Lactentes, pré-escolares e escolares*
- **Diag 021:** Refluxo Gastroesofágico Fisiológico ('Golfador Feliz') (CID-10: K21.9) — *Lactentes saudáveis (pico entre 2 e 4 meses)*
- **Diag 022:** Constipação Intestinal Funcional Crônica e Impactação Fecal (CID-10: K59.0) — *Todas as idades (> 6 meses)*
- **Diag 023:** Fissura Anal Aguda Pediátrica (CID-10: K60.0) — *Lactentes e pré-escolares*
- **Diag 024:** Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) - Forma Gastrointestinal (CID-10: K52.2) — *Lactentes (< 1 ano)*
- **Diag 025:** Esofagite Eosinofílica (EoE) Pediátrica (CID-10: K20.0) — *Crianças e adolescentes*
- **Diag 026:** Apendicite Aguda Pediátrica (Suspeita e Conduta Inicial) (CID-10: K35.8) — *Escolares e adolescentes (possível em qualquer idade)*
- **Diag 027:** Intussuscepção / Invaginação Intestinal Aguda (CID-10: K56.1) — *3 meses a 3 anos (pico 6 a 12 meses)*
- **Diag 028:** Giardíase Intestinal (Giardia lamblia) (CID-10: A07.1) — *Lactentes, pré-escolares e escolares*
- **Diag 029:** Helmintíases Intestinais Comuns (Ascariíase, Enterobiíase, Tricuríase, Ancilostomíase) (CID-10: B77.9 / B80 / B79 / B76.9) — *Todas as idades (> 1–2 anos)*
- **Diag 030:** Estrongiloidíase Pediátrica (Strongyloides stercoralis) (CID-10: B78.9) — *Crianças > 15 kg ou > 2–5 anos*

MÓDULO 03: DOENÇAS INFECCIOSAS, EXANTEMÁTICAS E SEPSE

- **Diag 031:** Exantema Súbito / Roséola Infantil (Herpesvírus Humano 6 e 7) (CID-10: B08.2) — *6 meses a 2 anos (pico 9 a 12 meses)*
- **Diag 032:** Eritema Infeccioso / Quinta Doença (Parvovírus B19) (CID-10: B08.3) — *5 a 15 anos (escolares)*
- **Diag 033:** Doença Mão-Pé-Boca (Coxsackievírus A16 / Enterovírus A71) (CID-10: B08.4) — *< 5 anos (especialmente < 3 anos)*
- **Diag 034:** Varicela Não Complicada (Catapora) (CID-10: B01.9) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 035:** Varicela com Infecção Bacteriana Secundária (Impetiginização e Celulite) (CID-10: B01.8) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 036:** Herpes Zoster Pediátrico (CID-10: B02.9) — *Crianças que tiveram varicela no 1º ano de vida ou imunodeprimidos*
- **Diag 037:** Escarlatina (CID-10: A38) — *3 a 12 anos (escolares)*
- **Diag 038:** Mononucleose Infecciosa (Vírus Epstein-Barr) (CID-10: B27.0) — *Pré-escolares, escolares e adolescentes*
- **Diag 039:** Dengue Pediátrica - Grupo A e B (Manejo Ambulatorial) (CID-10: A90) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 040:** Dengue Pediátrica - Grupo C e D (Sinais de Alarme e Choque por Dengue) (CID-10: A91) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 041:** Chikungunya Aguda Pediátrica (CID-10: A92.0) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 042:** Infecção pelo Vírus Zika Pediátrica (CID-10: A92.8) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 043:** Febre Maculosa Brasileira (Rickettsia rickettsii) (CID-10: A77.0) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 044:** Leptospirose Pediátrica Aguda (CID-10: A27.9) — *Pré-escolares, escolares e adolescentes*

- **Diag 045:** Sepsé Pediátrica e Choque Séptico (Protocolo de 1ª Hora) (CID-10: A41.9 / R57.2) — *Todas as idades pediátricas*

MÓDULO 04: NEUROLOGIA E EMERGÊNCIAS NEUROCRÍTICAS

- **Diag 046:** Crise Convulsiva Febril Simples (CID-10: R56.0) — *6 meses a 5 anos (pico 18 meses)*
- **Diag 047:** Crise Convulsiva Febril Complexa (CID-10: R56.0) — *6 meses a 5 anos*
- **Diag 048:** Estado de Mal Epiléptico Pediátrico (Status Epilepticus) (CID-10: G41.9) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 049:** Cefaleia Primária Tensional na Infância (CID-10: G44.2) — *Escolares e adolescentes*
- **Diag 050:** Enxaqueca Pediátrica (Crise Aguda e Profilaxia) (CID-10: G43.9) — *Escolares e adolescentes*
- **Diag 051:** Meningite Bacteriana Aguda Pediátrica (CID-10: G00.9) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 052:** Meningoencefalite Viral (Herpes Simplex e Enterovírus) (CID-10: G04.0 / B00.4) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 053:** Hipertensão Intracraniana Aguda no PA / UTI Pediátrica (CID-10: G93.2) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 054:** Traumatismo Cranioencefálico (TCE) Leve - Protocolo PECARN (CID-10: S06.0) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 055:** Traumatismo Cranioencefálico (TCE) Moderado a Grave (CID-10: S06.9) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 056:** Síndrome de Guillain-Barré Pediátrica (CID-10: G61.0) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 057:** Paralisia Facial Periférica Aguda (Paralisia de Bell) (CID-10: G51.0) — *Todas as idades pediátricas*

MÓDULO 05: DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA E ALERGOLOGIA

- **Diag 058:** Dermatite Atópica Leve (Cuidados de Barreira e Hidratação) (CID-10: L20.9) — *Todas as idades (início comum no 1º ano)*
- **Diag 059:** Dermatite Atópica Moderada a Grave (CID-10: L20.9) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 060:** Dermatite de Contato (Iritativa e Alérgica) (CID-10: L24.9 / L23.9) — *Todas as idades*
- **Diag 061:** Dermatite Seborreica do Lactente / Crosta Láctea (CID-10: L21.0) — *Primeiros 3 meses de vida (até 6 a 12 meses)*
- **Diag 062:** Dermatite das Fraldas Irritativa Simples (CID-10: L22) — *Lactentes (fase de uso de fraldas)*
- **Diag 063:** Dermatite das Fraldas com Candidíase Secundária (CID-10: B37.2) — *Lactentes em uso de fraldas (frequente pós-antibioticoterapia)*
- **Diag 064:** Urticária Aguda e Angioedema Não Anafilático (CID-10: L50.0 / T78.3) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 065:** Anafilaxia Pediátrica e Choque Anafilático (CID-10: T78.2) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 066:** Impetigo Crostoso e Bolhoso (*S. aureus* e *S. pyogenes*) (CID-10: L01.0 / L01.1) — *2 a 6 anos (frequente em climas quentes/úmidos)*
- **Diag 067:** Celulite e Erisipela Pediátrica (CID-10: L03.9 / A46) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 068:** Foliculite, Furunculose e Abscessos Cutâneos (CID-10: L73.9 / L02.9) — *Crianças e adolescentes*
- **Diag 069:** Escabiose Pediátrica (*Sarna Humana - Sarcoptes scabiei*) (CID-10: B86) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 070:** Pediculose do Couro Cabeludo (Piolho - *Pediculus humanus capitis*) (CID-10: B85.0) — *Escolares e pré-escolares*
- **Diag 071:** Molusco Contagioso Pediátrico (Poxvírus) (CID-10: B08.1) — *1 a 10 anos*
- **Diag 072:** Queimaduras Térmicas Ambulatoriais (1º Grau e 2º Grau Superficial < 10% SCQ) (CID-10: T30.0) — *Todas as idades pediátricas*

MÓDULO 06: NEFROLOGIA E UROLOGIA PEDIÁTRICA

- **Diag 073:** Infecção do Trato Urinário Baixa / Cistite Aguda (CID-10: N30.0) — *Pré-escolares, escolares e adolescentes*
- **Diag 074:** Pielonefrite Aguda Pediátrica (CID-10: N10) — *Lactentes, pré-escolares e escolares*
- **Diag 075:** Glomerulonefrite Difusa Aguda Pós-Estreptocócica (GNDA / Síndrome Nefrítica) (CID-10: N00.9) — *5 a 12 anos (rara em < 2 anos)*
- **Diag 076:** Síndrome Nefrótica Idiopática (Lesão Renal Mínima) (CID-10: N04.0) — *2 a 8 anos (pico 3 a 5 anos)*
- **Diag 077:** Injúria Renal Aguda (IRA) Pré-Renal e Distúrbios Eletrolíticos (CID-10: N17.9) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 078:** Balanopostite Aguda Pediátrica (CID-10: N48.1) — *Meninos de 1 a 6 anos*
- **Diag 079:** Fimose Fisiológica vs. Fimose Verdadeira e Parafimose Aguda (CID-10: N47) — *Meninos de todas as idades*
- **Diag 080:** Vulvovaginite Inespecífica da Infância (CID-10: N76.0) — *Meninas na fase pré-puberal (2 a 8 anos)*
- **Diag 081:** Enurese Noturna Monossintomática Primária (CID-10: F98.0) — *>= 5 anos de idade*
- **Diag 082:** Orquiepididimite Aguda vs. Torção Testicular Aguda (CID-10: N45.9 / N44) — *Adolescentes e escolares (torção tem picos no período neonatal e na puberdade)*

MÓDULO 07: CARDIOLOGIA E EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES

- **Diag 083:** Parada Cardiorrespiratória Pediátrica - Ritmos Chocáveis (FV / TV sem Pulso) (CID-10: I46.9) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 084:** Parada Cardiorrespiratória Pediátrica - Ritmos Não Chocáveis (Assistolia e AESP) (CID-10: I46.9) — *Todas as idades pediátricas (ritmo mais frequente em crianças)*
- **Diag 085:** Taquicardia Supraventricular (TSV) Pediátrica (CID-10: I47.1) — *Lactentes e crianças*
- **Diag 086:** Bradiarritmias Sintomáticas e Bloqueio Atrioventricular (BAV) (CID-10: I44.2 / R00.1) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 087:** Choque Cardiogênico Pediátrico e Disfunção Miocárdica Aguda (CID-10: R57.0) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 088:** Choque Obstrutivo (Tamponamento Cardíaco e Pneumotórax Hipertensivo) (CID-10: R57.8 / I31.9 / J93.0) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 089:** Doença de Kawasaki Aguda (Vasculite Sistêmica) (CID-10: M30.3) — *6 meses a 5 anos (pico 1 a 2 anos)*
- **Diag 090:** Miocardite Aguda Pediátrica (CID-10: I40.9) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 091:** Febre Reumática Aguda (Critérios de Jones / Febre Reumática Pós-Estreptocócica) (CID-10: I00) — *5 a 15 anos*
- **Diag 092:** Crise de Hipóxia / Cianose na Tetralogia de Fallot ("Spell") (CID-10: Q21.3) — *Lactentes com Tetralogia de Fallot (pico 2 a 6 meses)*
- **Diag 093:** Coarctação de Aorta Descompensada no Neonato / Cardiopatia Canal-Dependente (CID-10: Q25.1) — *Neonatos nos primeiros 7 a 14 dias de vida*
- **Diag 094:** Crise Hipertensiva Pediátrica (Emergência vs. Urgência Hipertensiva) (CID-10: I10 / I15.9) — *Todas as idades pediátricas*

MÓDULO 08: OTORRINOLARINGOLOGIA E OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

- **Diag 095:** Otite Média Aguda (OMA) Não Supurada (CID-10: H66.0) — *6 meses a 3 anos (pico 6 a 12 meses)*
- **Diag 096:** Otite Média Aguda Supurada / Perfurada (CID-10: H66.0) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 097:** Mastoidite Aguda Pediátrica (CID-10: H70.0) — *Lactentes e pré-escolares (< 2 a 4 anos)*
- **Diag 098:** Otite Externa Difusa Aguda ("Ouvido de Nadador") (CID-10: H60.8) — *Crianças maiores, escolares e adolescentes (frequente no verão)*
- **Diag 099:** Celulite Pré-Septal (Periorbitária) (CID-10: L03.2) — *< 5 anos (frequente associada a picadas de inseto, trauma ou sinusite etmoidal)*
- **Diag 100:** Celulite Pós-Septal (Orbitária Verdadeira) (CID-10: H05.0) — *Todas as idades (frequente complicação de sinusite etmoidal bacteriana)*
- **Diag 101:** Conjuntivite Bacteriana Aguda Pediátrica (CID-10: H10.0) — *Todas as idades (> período neonatal)*
- **Diag 102:** Conjuntivite Viral e Alérgica Pediátrica (CID-10: H10.1 / H10.2) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 103:** Obstrução Congênita do Duto Nasolacrimal / Dacriocistite Aguda (CID-10: Q10.5 / H04.3) — *Lactentes nos primeiros meses de vida*

- **Diag 104:** Epistaxe Anterior Aguda na Infância (CID-10: R04.0) — *Pré-escolares, escolares e adolescentes*

MÓDULO 09: DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS E ENDOCRINOLOGIA

- **Diag 105:** Cetoacidose Diabética (CAD) Leve a Moderada (CID-10: E10.1) — *Crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1*
- **Diag 106:** Cetoacidose Diabética (CAD) Grave (CID-10: E10.1) — *Crianças e adolescentes*
- **Diag 107:** Hipoglicemia Pediátrica Sintomática (CID-10: E16.2) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 108:** Hiponatremia Aguda Sintomática (Correção com NaCl 3%) (CID-10: E87.1) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 109:** Hipernatremia Grave Pediátrica (CID-10: E87.0) — *Lactentes (frequente pós-gastroenterite com SRO mal diluído ou erro de preparo de fórmulas)*
- **Diag 110:** Hipocalcemia Aguda e Reposição de Potássio (KCl) (CID-10: E87.6) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 111:** Hipercalemia com Alterações Eletrocardiográficas (CID-10: E87.5) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 112:** Hipocalcemia Aguda Sintomática (Tetania e Convulsão) (CID-10: E83.5) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 113:** Insuficiência Adrenal Aguda / Crise Addisoniana (CID-10: E27.2) — *Todas as idades pediátricas (pico neonatal na Hiperplasia Adrenal Congênita)*
- **Diag 114:** Hipotireoidismo Congênito no Lactente (CID-10: E03.1) — *Recém-nascidos e lactentes jovens*

MÓDULO 10: ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA E TRAUMATOLOGIA

- **Diag 115:** Artrite Séptica Pediátrica (CID-10: M00.9) — *Todas as idades (frequente em < 3 anos)*
- **Diag 116:** Osteomielite Hematogênica Aguda (CID-10: M86.1) — *Todas as idades pediátricas (metáfise de ossos longos: fêmur, tíbia, úmero)*
- **Diag 117:** Sinovite Transitória do Quadril (CID-10: M67.3) — *3 a 8 anos (pico 4 a 6 anos; predomínio masculino)*
- **Diag 118:** Epifisiólise Proximal da Cabeça Femoral (SCFE) (CID-10: M93.0) — *Adolescentes em estirão puberal (10 a 16 anos; associada a sobrepeso/obesidade)*
- **Diag 119:** Pronação Dolorosa da Cabeça do Rádio (Subluxação do Rádio) (CID-10: S53.0) — *1 a 4 anos (pico 2 a 3 anos)*
- **Diag 120:** Fraturas Pediátricas Incompletas (Galho Verde e Deformidade Plástica) (CID-10: S52.9) — *Lactentes, pré-escolares e escolares*
- **Diag 121:** Entorse Aguda de Tornozelo e Joelho na Infância (CID-10: S93.4 / S83.5) — *Escolares e adolescentes*
- **Diag 122:** Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) - Forma Sistêmica e Oligoarticular (CID-10: M08.0 / M08.2) — *< 16 anos (início frequente entre 1 e 6 anos)*
- **Diag 123:** Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculite por IgA) (CID-10: D69.0) — *3 a 10 anos (pico 4 a 6 anos)*
- **Diag 124:** Miosite Aguda Pós-Viral (Gastrocnêmios) (CID-10: M60.9) — *3 a 10 anos (predomínio masculino; clássica pós-Influenza B e A)*

MÓDULO 11: TOXICOLOGIA E ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

- **Diag 125:** Intoxicação Aguda por Paracetamol (Acetaminofeno) (CID-10: T39.1) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 126:** Intoxicação Aguda por Salicilatos (Ácido Acetilsalicílico - AAS) (CID-10: T39.0) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 127:** Intoxicação por Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs) (CID-10: T39.3) — *Lactentes e crianças (muito frequente por ingestão accidental de Ibuprofeno/Cetoprofeno)*
- **Diag 128:** Intoxicação por Opioides e Uso de Naloxona (CID-10: T40.2) — *Todas as idades pediátricas*
- **Diag 129:** Intoxicação por Benzodiazepínicos e Uso Cauteloso de Flumazenil (CID-10: T42.4) — *Lactentes, pré-escolares e adolescentes (tentativa de autoextermínio)*
- **Diag 130:** Ingestão de Bateria Tipo Botão e Múltiplos Ímãs (Corpos Estranhos de Alto Risco) (CID-10: T18.9) — *Lactentes e pré-escolares (pico 1 a 4 anos)*
- **Diag 131:** Ingestão de Substâncias Cáusticas (Ácidos e Álcalis Fortes) (CID-10: T54.9) — *1 a 5 anos (ingestão accidental de saneantes/limpeza doméstica)*
- **Diag 132:** Acidente Escorpiónico Pediátrico (*Tityus serrulatus*) (CID-10: T63.2) — *Todas as idades pediátricas (altíssima gravidade e mortalidade em < 5 a 7 anos)*
- **Diag 133:** Acidente Ofídico Botrópico (Jararaca - *Bothrops* spp.) (CID-10: T63.0) — *Todas as idades pediátricas (responsável por > 85-90% dos acidentes ofídicos no Brasil)*
- **Diag 134:** Acidente Ofídico Crotálico (Cascavel - *Crotalus durissus*) (CID-10: T63.0) — *Todas as idades pediátricas*

MÓDULO 12: NEONATOLOGIA E CUIDADOS IMEDIATOS

- **Diag 135:** Icterícia Neonatal Hiperbilirrubinemia Indireta / Fototerapia (CID-10: P59.9) — *Recém-nascidos nos primeiros 28 dias de vida*
- **Diag 136:** Icterícia por Incompatibilidade Rh / ABO e Exsanguinotransusão (CID-10: P55.0 / P55.1) — *Recém-nascidos*
- **Diag 137:** Seps Neonatal Precoce (< 72 Horas de Vida) (CID-10: P36.9) — *Recém-nascidos nas primeiras 72 horas de vida*
- **Diag 138:** Seps Neonatal Tardia (> 72 Horas de Vida) (CID-10: P36.9) — *Neonatos com > 72 horas de vida (hospitalizados ou comunitários)*
- **Diag 139:** Síndrome do Desconforto Respiratório Neonatal (SDR / Doença da Membrana Hialina) (CID-10: P22.0) — *Recém-nascidos prematuros (< 34-37 semanas de idade gestacional)*
- **Diag 140:** Taquipneia Transitória do Recém-Nascido (TTRN / Pulmão Úmido) (CID-10: P22.1) — *Recém-nascidos a termo ou pré-termos tardios nascidos de PARTO CESÁREO ELETIVO SEM TRABALHO DE PARTO*
- **Diag 141:** Apneia da Prematuridade e Citrato de Cafeína (CID-10: P28.4) — *Recém-nascidos prematuros (< 34 semanas de gestação)*
- **Diag 142:** Hipotermia Neonatal e Reaquecimento Controlado (CID-10: P80.9) — *Recém-nascidos (maior suscetibilidade em prematuros e PIG)*

MÓDULO 01: VIAS AÉREAS E PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

Diagnóstico 001: Rinofaringite Viral Aguda (Resfriado Comum)

CID-10: J00 | **Faixa Etária:** Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Coriza hialina/mucosa, obstrução nasal, espirros, tosse seca/produzida leve e febre baixa/moderada nas primeiras 48-72h. Ausência de taquipneia, esforço respiratório ou toxemia.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Lavagem Nasal com Solução Fisiológica 0,9%	Lactentes: 1 a 3 mL por narina; Crianças: 5 a 10 mL por narina com seringa ou dispositivo de alto fluxo, 4 a 8x/dia antes de mamar/dormir.	Livre	Criança com tronco elevado; nunca em decúbito dorsal plano.
Dipirona gotas 500 mg/mL (20 gts/mL)	10 a 25 mg/kg/dose (aprox. 1/2 a 1 gota/kg/dose) VO a cada 6h se dor ou febre com desconforto.	1 g/dose (40 gotas) ou 4 g/dia	Uso estritamente sintomático.
Paracetamol gotas 200 mg/mL (20 gts/mL)	10 a 15 mg/kg/dose (1 gota/kg/dose) VO a cada 6h se febre/dor.	1 g/dose ou 75 mg/kg/dia	Conferir concentração do frasco.

2ª Linha / Resgate: Anti-histamínicos de 2ª geração apenas se rinite alérgica associada. Descongestionantes tópicos/orais CONTRAINDICADOS em < 6 anos.

Medidas Não Farmacológicas: • Hidratação oral fracionada para fluidificação fisiológica de secreções. • Ambiente arejado e livre de tabagismo passivo. • Manter aleitamento materno e alimentação habitual.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Tiragem intercostal/subcostal, gemência ou taquipneia. ■■ Febre persistente > 72h ou recrudescência térmica. ■■ Sonolência excessiva ou recusa de líquidos.

Retorno / Reavaliação: Retorno se febre > 72h, piora após 10 dias ou sinais de esforço respiratório.

Diagnóstico 002: Rinossinusite Bacteriana Aguda

CID-10: J01.9 | **Faixa Etária:** Pré-escolares e escolares (> 1–2 anos)

Crítérios Clínicos: Sintomas persistentes sem melhora > 10 dias; OU início severo (febre >= 39°C com secreção purulenta >= 3 dias); OU piora após melhora inicial ('duplo pico').

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Amoxicilina suspensão oral 250 mg/5 mL ou 400 mg/5 mL	50 mg/kg/dia VO dividido a cada 8h (se 250mg) ou a cada 12h (se 400mg) por 7 a 10 dias.	1,5 g/dia	Se risco de pneumococo resistente (creche, ATB < 30 dias, < 2 anos), utilizar 80-90 mg/kg/dia.
Lavagem Nasal de Alto Volume com SF 0,9%	10 a 20 mL por narina 4 a 6 vezes ao dia.	Livre	Desobstrui o complexo osteomeatal.

2ª Linha / Resgate: Amoxicilina + Clavulanato (80-90 mg/kg/dia de amoxicilina) se falha em 48-72h; Cefuroxima axetil (30 mg/kg/dia) ou Claritromicina (15 mg/kg/dia) em alérgicos a penicilinas.

Medidas Não Farmacológicas: • Inalação com SF 0,9% para umidificação. • Compressas mornas faciais. • Hidratação oral.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Edema, eritema ou dor periorbitária. ■■ Cefaleia refratária, vômitos em jato ou rigidez de nuca. ■■ Sinais neurológicos focais.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação obrigatória em 48-72h se persistência da febre ou piora.

Diagnóstico 003: Faringoamigdalite Bacteriana Estreptocócica

CID-10: J02.0 | Faixa Etária: >= 3 anos (pico 5 a 15 anos)

Crítérios Clínicos: Início súbito de odinofagia intensa, febre alta, exsudato amigdaliano purulento, petéquias em palato, adenomegalia cervical dolorosa anterior, sem coriza/tosse.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Benzilpenicilina Benzatina suspensão injetável IM profunda	< 27 kg: 600.000 UI IM dose única; >= 27 kg: 1.200.000 UI IM dose única.	1.200.000 UI	Garante adesão e previne febre reumática.
Amoxicilina suspensão oral 250 mg/5 mL ou 500 mg	50 mg/kg/dia VO dividido a cada 8h (ou dose única de 50 mg/kg/dia até 1g) por 10 dias.	1 g/dia	Completar rigorosamente 10 dias.

2ª Linha / Resgate: Azitromicina 12 mg/kg/dia VO 1x/dia por 5 dias (máx 500 mg) ou Claritromicina 15 mg/kg/dia por 10 dias em alérgicos.

Medidas Não Farmacológicas: • Gargarejos mornos com sal em crianças maiores. • Alimentação pastosa fria/morna. • Hidratação abundante.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Trismo, assimetria amigdaliana ou desvio da úvula (abscesso periamigdaliano). ■■ Disfagia grave com sialorreia. ■■ Estridor ou dispneia.

Retorno / Reavaliação: Retorno se persistência de febre após 48h de antibiótico.

Diagnóstico 004: Crupe Viral Agudo / Laringite Estridulosa (Leve a Moderada)

CID-10: J05.0 | Faixa Etária: 6 meses a 3 anos

Crítérios Clínicos: Tosse metálica/ladrante ('tosse de cachorro'), rouquidão e estridor inspiratório ao esforço/choro, sem estridor acentuado em repouso.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Dexametasona elixir 0,1 mg/mL ou comprimido	0,15 a 0,6 mg/kg VO em dose única.	10 a 16 mg	Início de ação em 1 a 2 horas; reduz taxa de retorno e internação.
Prednisolona solução oral 3 mg/mL	1 a 2 mg/kg VO dose única (alternativa se indisponibilidade de dexametasona).	40 mg	Uso em dose única.

2ª Linha / Resgate: Se piora para estridor em repouso: nebulização com Adrenalina 1:1000 pura.

Medidas Não Farmacológicas: • Manter a criança calma no colo dos cuidadores (agitação piora o estridor). • Evitar exames/procedimentos estressantes desnecessários. • Umidificação do ambiente.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Estridor inspiratório audível em repouso. ■■ Tiragem de fúrcula ou subcostal. ■■ Cianose, palidez intensa ou sonolência.

Retorno / Reavaliação: Observação mínima de 2h após corticoide antes da alta.

Diagnóstico 005: Crupe Viral Grave / Laringite com Estridor em Repouso

CID-10: J05.0 | Faixa Etária: 6 meses a 6 anos

Crítérios Clínicos: Estridor inspiratório evidente em repouso, retração de fúrcula esternal, tiragem intercostal, batimento de asa de nariz, agitação/letargia e SpO2 limítrofe.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Adrenalina (Epinefrina) 1 mg/mL (1:1000) Inalatória	0,5 mL/kg de solução 1:1000 (máx 5 mL = 5 mg) pura em nebulização com O2 a 6-8 L/min.	5 mL (5 ampolas)	Efeito rápido em 10-30 min; duração de 2h. Risco de efeito rebote; observação mínima de 3-4 horas.
Dexametasona 4 mg/mL IV/IM ou 0,1 mg/mL VO	0,6 mg/kg IV/IM/VO em dose única.	16 mg	Administrar concomitantemente à nebulização.

2ª Linha / Resgate: Repetir Adrenalina inalatória após 30-60 min se persistência. Se exaustão: IOT com tubo 0,5 a 1,0 mm menor.

Medidas Não Farmacológicas: • Oxigenioterapia para manter SpO2 >= 94%. • Posição ereta ou semi-sentada no colo materno. • Monitorização contínua de oximetria e FC.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Silenciamento do estridor com fadiga respiratória e sonolência. ■■ Cianose central. ■■ Sialorreia ou postura de tripé.

Retorno / Reavaliação: Internação se necessidade de >= 2 nebulizações de adrenalina ou estridor persistente após 4h.

Diagnóstico 006: Epiglotite Aguda

CID-10: J05.1 | Faixa Etária: 2 a 7 anos (ou qualquer idade não vacinada)

Crítérios Clínicos: Início fulminante de febre alta, toxemia, odinofagia grave, disfagia com sialorreia importante, voz abafada ('batata quente') e postura em tripé. Ausência de tosse ladrante.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Ceftriaxona pó liofilizado injetável IV	100 mg/kg/dia IV 1x/dia (ou a cada 12h) por 7 a 10 dias.	2 g a 4 g/dia	Cobertura para H. influenzae b, S. pneumoniae e S. pyogenes.
Oxacilina 500 mg frasco-ampola IV	150 a 200 mg/kg/dia IV dividido a cada 6h.	12 g/dia	Associar se suspeita de S. aureus.

2ª Linha / Resgate: Vancomicina (40-60 mg/kg/dia) se prevalência de MRSA. Corticoterapia (Dexametasona 0,15-0,3 mg/kg IV) como adjuvante após via aérea garantida.

Medidas Não Farmacológicas: • NUNCA examinar a orofaringe com abaixador de língua ou estressar a criança antes de garantir via aérea. • Intubação traqueal em ambiente cirúrgico / UTI por profissional experiente. • Oxigênio inalatório passivo sem máscara forçada.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Emergência médica absoluta com risco iminente de oclusão total de via aérea.

Retorno / Reavaliação: Internação imediata em UTI Pediátrica.

Diagnóstico 007: Traqueíte Bacteriana Aguda

CID-10: J04.1 | Faixa Etária: 1 a 8 anos

Crítérios Clínicos: Quadro inicial semelhante ao crupe viral que evolui com febre alta persistente, toxemia, secreção purulenta traqueobrônquica densa e ausência de resposta à adrenalina inalatória.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Ceftriaxona IV + Oxacilina IV	Ceftriaxona 100 mg/kg/dia IV 1x/dia + Oxacilina 150-200 mg/kg/dia dividido a cada 6h por 10 a 14 dias.	Ceftriaxona 2g; Oxacilina 12g/dia	Cobertura para S. aureus, S. pneumoniae, S. pyogenes e H. influenzae.

2ª Linha / Resgate: Substituir Oxacilina por Vancomicina (40-60 mg/kg/dia IV a cada 6h) ou Clindamicina (40 mg/kg/dia a cada 6h) se suspeita de MRSA.

Medidas Não Farmacológicas: • Suporte ventilatório e aspiração frequente de secreções espessas sob cânula traqueal. • Umidificação do circuito ventilatório.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Obstrução de tubo/cânula traqueal por tampão mucoso espesso. ■■ Pneumotórax ou choque séptico.

Retorno / Reavaliação: Tratamento estritamente em UTI Pediátrica.

Diagnóstico 008: Bronquiolite Viral Aguda (BVA) - Manejo de Suporte

CID-10: J21.0 | Faixa Etária: Lactentes < 2 anos (pico < 6 meses)

Crítérios Clínicos: Primeiro episódio de sibilância/estertores subcrepitantes precedido por pródromo gripal (coriza, tosse, febre baixa), associado a taquipneia e tiragens.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Lavagem Nasal frequente com SF 0,9%	2 a 5 mL em cada narina antes das mamadas, antes de dormir e se obstrução nasal.	Livre	A desobstrução nasal reduz significativamente o trabalho respiratório em lactentes.
Antitérmicos se febre com desconforto (Dipirona ou Paracetamol)	Dipirona 10-25 mg/kg ou Paracetamol 10-15 mg/kg VO a cada 6h se dor/febre.	Dose habitual	Uso parcimonioso.

2ª Linha / Resgate: Broncodilatadores, corticoides sistêmicos, fisioterapia respiratória convencional e antibióticos NÃO SÃO RECOMENDADOS de rotina. Salbutamol inalatório apenas como teste terapêutico único em > 6 meses com história de atopia; suspender se ausência de resposta objetiva.

Medidas Não Farmacológicas: • Oxigenioterapia umidificada por cânula nasal para manter SpO2 >= 90-92%. • CNAF (Cânula Nasal de Alto Fluxo) se desconforto moderado a grave. • Nutrição e hidratação fracionadas (sonda nasogástrica se FR > 60-70 irpm para evitar broncoaspiração). • Posição elevada da cabeceira (30 graus).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Apneias (especialmente em < 2 meses ou prematuros). ■■ Batimento de asa de nariz, gemência, tiragem de fúrcula ou cianose. ■■ Queda de saturação (< 90%) ou recusa alimentar > 50%.

Retorno / Reavaliação: Monitorização rigorosa nas primeiras 48-72h (pico clínico entre o 3º e 5º dia de doença).

Diagnóstico 009: Bronquite Aguda e Hiperreatividade Brônquica Pós-Viral

CID-10: J20.9 | Faixa Etária: Pré-escolares e escolares

Crítérios Clínicos: Tosse produtiva ou seca persistente por 1 a 3 semanas após infecção viral de vias aéreas superiores, sem sinais de consolidação parenquimatosa ou broncoespasmo fixo.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Lavagem Nasal com SF 0,9%	5 a 10 mL por narina 3 a 5 vezes ao dia.	Livre	Trata gotejamento pós-nasal que perpetua a tosse.
Mel puro (em crianças > 1 ano de idade)	2,5 a 5 mL VO à noite antes de dormir.	5 mL/dose	CONTRAINDICADO em menores de 1 ano pelo risco de botulismo.

2ª Linha / Resgate: Se componente espasmódico leve associado: Salbutamol spray 100 mcg (2 jatos a cada 6-8h por 3-5 dias se sibilos).

Medidas Não Farmacológicas: • Hidratação oral vigorosa para fluidificação do muco. • Evitar exposição à fumaça de cigarro e poluentes. • Não usar xaropes antitussígenos ou mucolíticos sem indicação médica.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Tosse com duração > 4 semanas (investigar tosse crônica/asma/corpo estranho). ■■ Taquipneia, tiragens ou dor torácica pleurítica. ■■ Febre alta tardia.

Retorno / Reavaliação: Retorno se tosse persistente além de 3 semanas ou surgimento de sinais de alerta.

Diagnóstico 010: Crise de Asma / Broncoespasmo Agudo (Leve a Moderada)

CID-10: J45.9 | Faixa Etária: >= 2 anos (ou sibilante recorrente)

Crítérios Clínicos: Episódio agudo ou subagudo de tosse, dispneia, sibilância e aperto torácico. Na crise leve/moderada: fala frases, SpO2 92-95%, tiragem intercostal leve a moderada.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Salbutamol spray dosimetrado 100 mcg/jato (com espaçador valvulado)	2 a 4 jatos (crise leve) ou 4 a 8 jatos (crise moderada) a cada 20 minutos na primeira hora (3 ciclos).	8 jatos/ciclo	Uso com espaçador e máscara facial ajustada; aguardar 6 a 8 incursões por jato com intervalo de 30-60s entre jatos.
Prednisolona solução oral 3 mg/mL ou 1 mg/mL	1 a 2 mg/kg/dia VO em dose única matinal (ou dividido em 2 tomadas) por 3 a 5 dias.	40 mg/dia (< 12 anos) ou 60 mg/dia (>= 12 anos)	Cursos curtos de até 5 dias não exigem desmame gradual.

2ª Linha / Resgate: Brometo de Ipratrópio spray (2 a 4 jatos) ou gotas inalatórias (20 a 40 gotas) associado ao salbutamol na 1ª hora em crises moderadas.

Medidas Não Farmacológicas: • Oxigenioterapia para manter SpO2 >= 94%. • Posição confortável e tranquilização da criança e família.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Incapacidade de completar frases ou falar palavras isoladas. ■■ Uso de musculatura acessória intensa, batimento de asa nasal e tiragem de fúrcula. ■■ Sonolência, exaustão, confusão ou SpO2 < 92%.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação imediatamente após cada ciclo da primeira hora; manutenção com salbutamol espaçado a cada 4-6h por 3-5 dias.

Diagnóstico 011: Crise de Asma Grave / Ameaçadora à Vida (Manejo de Emergência)

CID-10: J45.9 | Faixa Etária: >= 2 anos

Críticos Clínicos: Dispneia intensa, incapacidade de falar, tórax silencioso à ausculta, sudorese profusa, SpO2 < 90-92%, exaustão, bradicardia ou confusão mental.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Salbutamol spray 100 mcg (8 a 10 jatos a cada 20 min) + Brometo de Ipratrópio (4 a 8 jatos)	Inalações contínuas ou a cada 20 minutos com espaçador acoplado a O2 a 6-8 L/min.	10 jatos de cada por ciclo	Tratamento de ataque agressivo na primeira hora.
Metilprednisolona IV ou Hidrocortisona IV	Metilprednisolona: 1 a 2 mg/kg/dose IV a cada 6h; OU Hidrocortisona: 5 a 10 mg/kg/dose IV a cada 6h.	Metilprednisolona 60 mg/dose; Hidrocortisona 250 mg/dose	Início rápido por via parenteral na crise grave.
Sulfato de Magnésio 50% solução injetável IV	25 a 50 mg/kg IV (máx 2 g) diluído em SF 0,9% ou SG 5% infundido em 20 a 30 minutos.	2 g	Monitorar pressão arterial e reflexos profundos durante a infusão.

2ª Linha / Resgate: Beta-2 agonista parenteral (Terbutalina IV ou Adrenalina IM/SC 0,01 mg/kg se indisponibilidade de via aérea/inalação); VNI (CPAP/BiPAP); se intubação: sedação com cetamina e ventilação protetora com tempo expiratório prolongado.

Medidas Não Farmacológicas: • Oxigênio sob máscara com reservatório (alvo SpO2 94-98%). • Monitorização multiparamétrica contínua (ECG, SpO2, PNI). • Acesso venoso periférico calibroso.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Tórax silencioso com diminuição dos sibilos por ausência de fluxo aéreo. ■■ Pneumotórax / pneumomediastino hipertensivo. ■■ Parada cardiorrespiratória por asfixia.

Retorno / Reavaliação: Internação mandatória em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.

Diagnóstico 012: Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) Típica

CID-10: J18.9 | Faixa Etária: Todas as idades (> 2 meses)

Críticos Clínicos: Febre alta de início agudo, tosse produtiva, taquipneia conforme faixa etária (OMS), tiragem subcostal, estertores crepitantes focais e consolidação lobar no RX de tórax.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Amoxicilina suspensão oral 250 mg/5 mL ou 500 mg	80 a 90 mg/kg/dia VO dividido a cada 8h ou 12h por 7 a 10 dias (ambulatorial).	2 g a 3 g/dia	Dose alta para cobertura eficaz de pneumococo com sensibilidade intermediária.
Ampicilina sódica frasco-ampola IV (se internação hospitalar)	150 a 200 mg/kg/dia IV dividido a cada 6h por 7 a 10 dias.	12 g/dia	Primeira escolha para pneumonia bacteriana internada sem gravidade extrema.

2ª Linha / Resgate: Amoxicilina + Clavulanato (90 mg/kg/dia de amoxicilina) ou Ceftriaxona (50-100 mg/kg/dia IV) se falha após 48-72h ou pneumonia complicada; Oxacilina se suspeita de estafilococo.

Medidas Não Farmacológicas: • Hidratação e nutrição adequadas. • Oxigenioterapia se SpO2 < 92%. • Fisioterapia respiratória apenas se atelectasia ou hipersecreção consolidada.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Desconforto respiratório progressivo ou gemência. ■■ Queda de SpO2 < 92% em ar ambiente. ■■ Persistência da febre > 48-72h após início do antibiótico (investigar derrame pleural).

Retorno / Reavaliação: Reavaliação clínica obrigatória em 48 horas no tratamento ambulatorial.

Diagnóstico 013: Pneumonia Atípica Pediátrica

CID-10: J15.7 | **Faixa Etária:** >= 5 anos (escolares e adolescentes; ocasional em pré-escolares)

Crítérios Clínicos: Início insidioso de febre moderada, tosse seca irritativa persistente ('em acessos'), cefaleia, mialgia, dor de garganta, ausculta com estertores difusos e infiltrado intersticial/broncopneumônico no RX.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Azitromicina suspensão oral 200 mg/5 mL ou comprimido 500 mg	10 mg/kg/dia VO 1x/dia no D1 (máx 500 mg) seguido de 5 mg/kg/dia do D2 ao D5 (ou 10 mg/kg/dia por 3 a 5 dias).	500 mg/dia	Excelente cobertura para Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae.
Claritromicina suspensão oral 125 mg/5 mL ou 250 mg/5 mL	15 mg/kg/dia VO dividido a cada 12h por 7 a 10 dias.	1 g/dia (500 mg a cada 12h)	Alternativa com posologia a cada 12h.

2ª Linha / Resgate: Doxiciclina (2 a 4 mg/kg/dia VO a cada 12h) em crianças >= 8 anos ou casos refratários a macrolídeos.

Medidas Não Farmacológicas: • Hidratação oral e repouso. • Tratamento sintomático da febre e cefaleia.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Aparecimento de esforço respiratório ou taquipneia importante. ■■ Manifestações extrapulmonares graves (anemia hemolítica, eritema multiforme, encefalite).

Retorno / Reavaliação: Retorno se ausência de melhora após 72h de macrolídeo.

Diagnóstico 014: Derrame Pleural Parapneumônico e Empiema Pleural

CID-10: J90 / J86.9 | **Faixa Etária:** Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Persistência de febre alta e toxemia após 48-72h de antibioticoterapia para pneumonia, macicez à percussão, abolição do murmúrio vesicular e opacidade pleural com nível/loculação ao RX e USG torácico.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Ceftriaxona IV + Oxacilina IV (ou Clindamicina IV)	Ceftriaxona 100 mg/kg/dia 1x/dia + Oxacilina 150-200 mg/kg/dia a cada 6h (ou Clindamicina 40 mg/kg/dia a cada 6h) por 14 a 21 dias.	Ceftriaxona 4g; Oxacilina 12g; Clindamicina 2,4g/dia	Tratamento parenteral associado obrigatoriamente à abordagem cirúrgica/drenagem pleural.

2ª Linha / Resgate: Vancomicina (40-60 mg/kg/dia) se MRSA confirmado; Drenagem pleural em selo d'água + Fibrinolítico intrapleural (Alteplase/Uoquinase) ou Videotoracoscopia (VATS) para debridamento de loculações.

Medidas Não Farmacológicas: • Drenagem torácica tubular fechada sob selo d'água. • Fisioterapia respiratória após controle do dreno. • Suporte nutricional e calórico.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Desvio de mediastino com instabilidade hemodinâmica (tamponamento gasoso/líquido). ■■ Mau funcionamento ou obstrução do dreno torácico.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento diário com RX/USG torácico e internação em enfermaria/UTI.

Diagnóstico 015: Coqueluche / Síndrome Coqueluchoide (Bordetella pertussis)

CID-10: A37.0 | Faixa Etária: Lactentes e crianças (maior gravidade em < 6 meses)

Critérios Clínicos: Tosse paroxística ('em salvas') seguida de guincho inspiratório e vômitos pós-tosse; cianose ou apneia durante os acessos em lactentes jovens, com ausência de febre alta e leucocitose com linfocitose marcante.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Azitromicina suspensão oral 200 mg/5 mL	< 6 meses: 10 mg/kg/dia VO 1x/dia por 5 dias; >= 6 meses: 10 mg/kg (máx 500 mg) no D1, seguido de 5 mg/kg/dia (máx 250 mg) do D2 ao D5.	500 mg no D1, 250 mg/dia do D2-D5	Primeira escolha para todas as faixas etárias, incluindo neonatos (menor risco de estenose hipertrófica do piloro que eritromicina).
Claritromicina suspensão oral 125 mg/5 mL ou 250 mg/5 mL	15 mg/kg/dia VO dividido a cada 12h por 7 dias (em >= 1 mês de idade).	1 g/dia	Alternativa eficaz à azitromicina.

2ª Linha / Resgate: Sulfametoxazol + Trimetoprima (40 mg/kg/dia de SMX + 8 mg/kg/dia de TMP a cada 12h por 14 dias) em crianças > 2 meses alérgicas a macrolídeos.

Medidas Não Farmacológicas: • Isolamento respiratório por gotículas por 5 dias após início do macrolídeo. • Profilaxia de comunicantes domiciliares e contatos próximos com Azitromicina. • Monitorização contínua de apneia e saturação em lactentes < 6 meses.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Apneias repetidas, bradicardia durante acessos de tosse ou convulsões. ■■ Hiperleucocitose extrema (> 50.000 a 100.000/mm³) com risco de hipertensão pulmonar. ■■ Insuficiência respiratória.

Retorno / Reavaliação: Internação mandatória para lactentes < 3-6 meses e monitorização cardiorrespiratória.

MÓDULO 02: GASTROENTEROLOGIA E NUTRIÇÃO PEDIÁTRICA

Diagnóstico 016: Gastroenterite Aguda Viral - Plano A de Reidratação

CID-10: A08.4 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Diarreia aguda líquida/pastosa e vômitos sem sinais de desidratação (olhos normais, lágrimas presentes, boca úmida, sede normal, sinal da prega desaparece imediatamente).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Soro de Reidratação Oral (SRO) 75 mOsm/L (pó para diluição em 1L)	< 1 ano: 50 a 100 mL após cada evacuação líquida; >= 1 ano: 100 a 200 mL após cada evacuação líquida; Crianças maiores: volume conforme aceitação.	Livre	Diluir exatamente em 1 litro de água filtrada/fervida; oferecer com colher ou copo, em pequenas quantidades frequentes.
Sulfato de Zinco solução oral 2 mg/mL ou 4 mg/mL	< 6 meses: 10 mg de zinco elementar VO 1x/dia por 10 a 14 dias; >= 6 meses: 20 mg de zinco elementar VO 1x/dia por 10 a 14 dias.	20 mg/dia	Reduz duração e gravidade da diarreia e previne novos episódios nos 3 meses seguintes.

2ª Linha / Resgate: Racecadotril (1,5 mg/kg/dose VO a cada 8h por até 5 dias) como adjuvante antissecretor em > 3 meses; Probióticos (Saccharomyces boulardii ou L. reuteri) para encurtar tempo de diarreia.

Medidas Não Farmacológicas: • Manter aleitamento materno em livre demanda. • Manter alimentação habitual adequada para a idade (não suspender leite nem prescrever dietas restritivas hipocalóricas). • Evitar sucos industrializados, refrigerantes e alimentos ricos em açúcares simples.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Sinais de desidratação (olhos fundos, boca seca, ausência de lágrimas, sede excessiva). ■■ Vômitos incoercíveis que impedem a hidratação oral. ■■ Presença de sangue nas fezes ou prostração intensa.

Retorno / Reavaliação: Retorno se persistência da diarreia após 7-14 dias ou sinais de desidratação.

Diagnóstico 017: Gastroenterite com Desidratação Leve a Moderada - Plano B

CID-10: A09 / E86 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Presença de 2 ou mais sinais: irritabilidade/inquietação, olhos fundos, lágrimas ausentes, boca seca, sede ávida (bebe com sofreguidão), sinal da prega desaparece lentamente (< 2s).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Terapia de Reidratação Oral (TRO) com SRO em Unidade de Saúde	50 a 100 mL/kg de SRO administrados por via oral com colher/copo ao longo de 4 a 6 horas em observação.	100 mL/kg no período	Administrar 1 colher a cada 1-2 minutos; se vômitos, aguardar 10 min e reiniciar mais lentamente.
Ondansetrona solução oral 2 mg/5 mL (0,4 mg/mL) ou comprimido orodispersível 4 mg	Dose única VO: 8 a 15 kg: 2 mg; 15 a 30 kg: 4 mg; > 30 kg: 8 mg (ou 0,15 mg/kg/dose).	8 mg	Facilita o sucesso da TRO em vômitos persistentes; evitar doses repetidas de rotina.

2ª Linha / Resgate: Se falha da TRO por vômitos incoercíveis, recusa persistente ou distensão abdominal: Gastroclise com SRO via SNG (20 mL/kg/hora) ou transição para Plano C intravenoso.

Medidas Não Farmacológicas: • Reavaliação contínua do estado de hidratação a cada 1-2 horas na unidade de saúde. • Após reidratação completa, reiniciar alimentação habitual e liberar para domicílio no Plano A.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Evolução para letargia, perda de consciência ou choque circulatório. ■■ Piora das perdas diarreicas ultrapassando a reposição oral. ■■ Anúria por > 6-8 horas.

Retorno / Reavaliação: Alta somente após hidratação completa comprovada e tolerância alimentar confirmada.

Diagnóstico 018: Gastroenterite Invasiva / Disenteria Bacteriana Aguda

CID-10: A03.9 / A04.9 | Faixa Etária: Lactentes, pré-escolares e escolares

Critérios Clínicos: Fezes com muco, pus e sangue visível (disenteria), febre alta, dor abdominal em cólica e tenesmo (Shigella, Campylobacter, Salmonella, E. coli enteroinvasiva).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Azitromicina suspensão oral 200 mg/5 mL ou 500 mg	10 a 12 mg/kg/dia VO em dose única diária por 3 a 5 dias.	500 mg/dia	Primeira escolha para shigelose e campilobacteriose no Brasil.
Ceftriaxona pó liofilizado injetável IV/IM (se internação/toxemia)	50 a 100 mg/kg/dia IV ou IM 1x/dia por 3 a 5 dias.	2 g/dia	Indicado se sepse, impossibilidade de via oral ou desnutrição grave.

2ª Linha / Resgate: Sulfametoxazol + Trimetoprima e Ciprofloxacino (se guiado por antibiograma e resistência a macrolídeos). NÃO USAR antiespasmódicos/antidiarreicos (risco de megacólon tóxico).

Medidas Não Farmacológicas: • Hidratação rigorosa com SRO (Plano A ou B). • Zinco por 10-14 dias. • Higiene rigorosa das mãos e manipulação de alimentos para evitar transmissão.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Palidez intensa, oligúria/anúria e petéquias (suspeita de Síndrome Hemolítico-Urêmica - SHU associada à Shiga-toxina). ■■ Convulsões febris ou toxemia grave. ■■ Distensão abdominal severa.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação em 48 horas para verificar resposta clínica e hemograma/função renal se toxemia.

Diagnóstico 019: Desidratação Grave com Choque Hipovolêmico - Plano C

CID-10: E86 / R57.1 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Letargia ou inconsciência, olhos muito fundos, ausência total de lágrimas, boca muito seca, incapacidade de beber, sinal da prega muito lento (> 2s), pulso fino/ausente, enchimento capilar > 3s, extremidades frias.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Fase de Expansão Rápida: Solução Fisiológica 0,9% ou Ringer Lactato IV	< 1 ano: 30 mL/kg em 30 min + 70 mL/kg em 5h30min (total 100 mL/kg em 6h); >= 1 ano: 30 mL/kg em 30 min + 70 mL/kg em 2h30min (total 100 mL/kg em 3h). Se choque: bolus inicial de 20 mL/kg em 10-20 min, repetindo se necessário.	Conforme resposta hemodinâmica	Acesso venoso periférico calibroso ou punção intraóssea imediata se > 2 tentativas falhas em 90 segundos.

2ª Linha / Resgate: Iniciar SRO via oral ou SNG (5 mL/kg/h) assim que o paciente recuperar a consciência, mantendo a infusão venosa até estabilização completa.

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização contínua de FC, PA, oximetria e tempo de enchimento capilar. • Avaliação da diurese e eletrólitos (Na+, K+, gasometria). • Aquecimento térmico passivo.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Persistência de hipotensão ou má perfusão após 40-60 mL/kg de cristaloides (choque refratário a volume; considerar drogas vasoativas). ■■ Sinais de sobrecarga hídrica (crepitações pulmonares, hepatomegalia).

Retorno / Reavaliação: Avaliação clínica a cada 15-30 minutos durante a expansão rápida.

Diagnóstico 020: Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE) Pediátrica

CID-10: K21.0 / K21.9 | Faixa Etária: Lactentes, pré-escolares e escolares

Crítérios Clínicos: Regurgitações associadas a complicações: baixo ganho ponderal, irritabilidade excessiva durante/após mamadas, recusa alimentar, postura de Sandifer, esofagite erosiva ou sintomas respiratórios crônicos.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Esomeprazol ou Omeprazol suspensão/grânulos gastro-resistentes	Lactentes e crianças: 1 a 2 mg/kg/dia VO em dose única matinal 30 min antes da refeição por 4 a 8 semanas.	40 mg/dia	Não mastigar nem triturar os microgrânulos; primeira linha para esofagite comprovada ou sintomas típicos refratários às medidas posturais.
Fórmulas Antirregurgitação (AR) ou Espessantes alimentares	Para lactentes alimentados com fórmula: espessamento com goma de alfarroba ou amido de milho.	Conforme fabricante	Não aplicar em lactentes em aleitamento materno exclusivo.

2ª Linha / Resgate: Ranitidina está descontinuada. Procinéticos (Domperidona/Bromoprida) NÃO SÃO RECOMENDADOS de rotina pelo perfil desfavorável de risco-benefício.

Medidas Não Farmacológicas: • Manutenção do decúbito elevado após as mamadas (não usar decúbito ventral sem vigilância pelo risco de SIDS). • Fracionamento das mamadas/refeições, evitando volumes excessivos. • Teste de exclusão de leite de vaca por 2 a 4 semanas em lactentes com suspeita de APLV associada.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Vômitos biliosos (verde-escuros), vômitos em jato em < 3 meses (estenose hipertrófica do piloro) ou hematêmese. ■■ Perda de peso ponderal importante. ■■ Disfagia ou engasgos recorrentes com cianose.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação após 4 a 8 semanas para tentativa de desmame do IBP.

Diagnóstico 021: Refluxo Gastroesofágico Fisiológico ('Golfador Feliz')

CID-10: K21.9 | Faixa Etária: Lactentes saudáveis (pico entre 2 e 4 meses)

Critérios Clínicos: Regurgitações frequentes sem esforço após as mamadas em lactente que mantém excelente ganho ponderal, sorriso social, sono tranquilo e desenvolvimento normal, sem sinais de alarme ou irritabilidade excessiva.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
NENHUM MEDICAMENTO INDICADO	Tratamento não medicamentoso exclusivo. Evitar antiácidos, IBPs ou procinéticos.	N/A	Explicar a fisiopatologia aos pais: imaturidade transitória do esfíncter esofágico inferior, com resolução espontânea em 90% dos casos até 12-14 meses.

2ª Linha / Resgate: Espessamento da fórmula apenas se regurgitações muito volumosas e angústia familiar extrema, sem uso de fármacos.

Medidas Não Farmacológicas: • Manter a criança em posição vertical no colo por 20 a 30 minutos após as mamadas. • Evitar pressão excessiva sobre o abdome (fraldas muito apertadas ou trocas de fralda imediatamente após mamar). • Evitar superalimentação e respeitar os sinais de saciedade do bebê. • Manter o aleitamento materno exclusivo.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Parada de ganho de peso ou perda ponderal. ■■ Choro inconsolável com arqueamento do tronco após mamar. ■■ Vômitos em jato, biliosos ou sanguinolentos.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento no puericério de rotina e monitorização da curva de crescimento (escore-z).

Diagnóstico 022: Constipação Intestinal Funcional Crônica e Impactação Fecal

CID-10: K59.0 | Faixa Etária: Todas as idades (> 6 meses)

Critérios Clínicos: Critérios de Roma IV: <= 2 evacuações/semana, histórico de retenção fecal excessiva, evacuações dolorosas/duras, fezes de grande calibre, presença de grande massa fecal no reto e episódios de escape fecal (incontinência retentiva/soiling).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Macrogol 3350 ou 4000 sem eletrólitos (PEG) em pó para solução oral	Desimpactação (1 a 3 dias): 1 a 1,5 g/kg/dia VO diluído em água/suco; Manutenção (longo prazo): 0,4 a 0,8 g/kg/dia VO (titular para 1-2 fezes pastosas sem dor ao dia).	Desimpactação até 100g/dia; Manutenção até 40-50g/dia	Primeira linha absoluta; seguro para uso prolongado por meses; não causa dependência ou 'intestino preguiçoso'.
Lactulose xarope 667 mg/mL (0,66 g/mL)	1 a 2 mL/kg/dia (aprox. 1 a 3 mL/kg) VO dividido em 1 a 2 tomadas (alternativa se indisponibilidade de PEG).	60 mL/dia	Pode causar flatulência e cólicas nos primeiros dias.

2ª Linha / Resgate: Enema com solução glicerinada ou fosfatada (1 a 2 mL/kg) apenas se falha na desimpactação oral ou dor refratária imediata. Bisacodil (5 a 10 mg) como resgate em > 2 anos.

Medidas Não Farmacológicas: • Aumento da ingestão hídrica e oferta regular de fibras solúveis e insolúveis (frutas com casca, legumes, aveia). • Treinamento de toalete: sentar no vaso por 5-10 min após as principais refeições aproveitando o reflexo gastrocólico. • Uso de apoio para os pés no vaso sanitário para manter os joelhos acima do nível do quadril (retificação do ângulo anorretal).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Constipação de início neonatal (< 1 mês de vida) ou atraso na eliminação de mecônio > 48h (investigar Doença de Hirschsprung). ■■ Fezes em fita, vômitos biliosos, distensão abdominal grave ou ausência de reflexo anocutâneo. ■■ Alterações anatômicas da coluna sacral/lombossacra.

Retorno / Reavaliação: Manter a dose de manutenção por no mínimo 2 a 6 meses antes de qualquer tentativa de desmame gradual.

Diagnóstico 023: Fissura Anal Aguda Pediátrica

CID-10: K60.0 | Faixa Etária: Lactentes e pré-escolares

Critérios Clínicos: Dor intensa ao evacuar ('choro durante e após a defecação'), fezes duras com estrias de sangue vivo vermelho-brilhante na superfície e visualização direta de laceração linear na margem anal (geralmente linha média posterior/anterior).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Laxante osmótico (PEG 4000 ou Lactulose) em dose de amolecimento	PEG 4000: 0,5 a 0,8 g/kg/dia VO para garantir fezes permanentemente pastosas.	30 a 40 g/dia	Fundamental para interromper o ciclo 'dor -> retenção -> fezes duras -> piora da fissura'.
Pomada de Dexpantenol + Óxido de Zinco ou Vaselina pura	Aplicar camada fina sobre a fissura anal a cada troca de fraldas ou após cada evacuação por 2 a 4 semanas.	Livre	Promove barreira protetora e cicatrização.

2ª Linha / Resgate: Pomada de Diltiazem 2% manipulada ou Nitroglicerina 0,2% tópica em fissuras crônicas refratárias (> 6-8 semanas) em crianças maiores sob supervisão especializada.

Medidas Não Farmacológicas: • Banhos de assento com água morna por 10 a 15 minutos 2 a 3 vezes ao dia (promove relaxamento do esfíncter anal interno e alívio da dor). • Higiene perianal com água morna e algodão; evitar lenços umedecidos com álcool ou fragrâncias. • Tratamento rigoroso da constipação de base.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Fissuras múltiplas, atípicas fora da linha média ou associadas a fístulas (investigar Doença de Crohn, abuso sexual ou infecções). ■■ Sangramento retal abundante com coágulos.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação em 2 a 4 semanas para confirmar cicatrização.

Diagnóstico 024: Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) - Forma Gastrointestinal

CID-10: K52.2 | Faixa Etária: Lactentes (< 1 ano)

Critérios Clínicos: Quadro não-IgE mediado de proctocolite alérgica (fezes com rajas de sangue e muco em lactente em bom estado geral) ou enteropatia/FPIES (vômitos profusos, diarreia crônica, má absorção e baixo ganho ponderal).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Dieta de Exclusão Estrita de Leite de Vaca e Derivados	Se aleitamento materno: dieta de exclusão de PLV para a nutriz com suplementação de Cálcio (1.000 mg/dia) e Vitamina D para a mãe. Se fórmula infantil: Fórmula extensamente hidrolisada (eHF) como primeira escolha.	N/A	Manter por 2 a 4 semanas para avaliação de resposta clínica (teste de desencadeamento após remissão para confirmação diagnóstica).

2ª Linha / Resgate: Fórmula à base de Aminoácidos Livres (AAF) se anafilaxia prévia, FPIES grave com choque, esofagite eosinofílica severa ou falha da fórmula extensamente hidrolisada.

Medidas Não Farmacológicas: • Orientação nutricional completa para leitura de rótulos e prevenção de contaminação cruzada. • Apoio e estímulo à manutenção do aleitamento materno. • Bebidas vegetais de arroz/aveia/amêndoas e leite de outros mamíferos (cabra/ovelha) são CONTRAINDICADOS como substitutos no primeiro ano.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Desidratação grave, acidose metabólica e hipotensão após ingestão acidental (FPIES agudo). ■■ Presença de sintomas respiratórios agudos ou angioedema (reação IgE mediada grave).

Retorno / Reavaliação: Teste de provocação oral programado após 6 a 12 meses de exclusão para avaliar desenvolvimento de tolerância imunológica.

Diagnóstico 025: Esofagite Eosinofílica (EoE) Pediátrica

CID-10: K20.0 | Faixa Etária: Crianças e adolescentes

Crítérios Clínicos: Sintomas de disfunção esofágica (recusa alimentar, engasgos, impacto alimentar, vômitos, dor retroesternal) associados a biópsia esofágica demonstrando >= 15 eosinófilos por campo de grande aumento (CGA).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Inibidor de Bomba de Prótons (Esomeprazol ou Omeprazol)	1 a 2 mg/kg/dia VO dividido a cada 12h (máx 40 mg 2x/dia) por 8 a 12 semanas antes da biópsia de controle.	80 mg/dia	Primeira linha clínica; cerca de 50% dos pacientes respondem ao IBP (EoE responsiva a IBP).
Corticoide Tópico Deglutido (Fluticasona ou Budesonida viscosa)	Fluticasona spray oral deglutido: 440 a 880 mcg/dia divididos 2x/dia; OU Budesonida viscosa (misturada a sucralose/néctar): 1 a 2 mg/dia VO.	2 mg/dia	Não comer ou beber por 30 minutos após a deglutição; enxaguar a boca sem engolir água para evitar candidíase oral.

2ª Linha / Resgate: Dieta empírica de eliminação alimentar (2, 4 ou 6 alimentos mais alergênicos: leite, trigo, ovo, soja, amendoim/castanhas, frutos do mar) sob supervisão de gastropediatra/nutricionista.

Medidas Não Farmacológicas: • Mastigação lenta e ingestão cuidadosa de alimentos sólidos. • Evitar alimentos de consistência fibrosa ou pedaços grandes em crianças com disfasia.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Impactação alimentar aguda com incapacidade de deglutir a própria saliva (emergência endoscópica). ■■ Dor torácica súbita intensa após vômito (risco de perfuração esofágica / Síndrome de Boerhaave).

Retorno / Reavaliação: Endoscopia digestiva alta com biópsia após 8-12 semanas de cada intervenção terapêutica.

Diagnóstico 026: Apendicite Aguda Pediátrica (Suspeita e Conduta Inicial)

CID-10: K35.8 | Faixa Etária: Escolares e adolescentes (possível em qualquer idade)

Crítérios Clínicos: Dor abdominal periumbilical que migra para fossa ilíaca direita (FID), febre baixa, anorexia, vômitos após início da dor, descompressão dolorosa positiva em FID (Sinal de Blumberg) e sinal do Psoas/Obturador.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Jejum Absoluto + Hidratação Venosa Imediata	SF 0,9% ou SG 5% + eletrólitos em taxa de manutenção (Holliday-Segar) + reposição de perdas.	Individualizada	Avaliação cirúrgica pediátrica imediata antes de qualquer outra medida.
Ceftriaxona IV + Metronidazol IV (Antibioticoterapia pré-operatória)	Ceftriaxona: 100 mg/kg/dia IV dose única + Metronidazol: 30 mg/kg/dia IV dividido a cada 8h.	Ceftriaxona 2g; Metronidazol 1,5g/dia	Iniciar após indicação cirúrgica ou suspeita forte confirmada por imagem (USG/TC).

2ª Linha / Resgate: Ciprofloxacino + Metronidazol ou Piperacilina + Tazobactam (100 mg/kg/dose a cada 6-8h) em apendicite complicada perfurada com sepse/peritonite difusa.

Medidas Não Farmacológicas: • Analgesia venosa titulada (Dipirona IV ou Morfina IV 0,05-0,1 mg/kg); o controle adequado da dor NÃO mascara o exame físico do abdome agudo cirúrgico. • Evitar aplicação de calor local ou laxantes/enemas.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Melhora súbita transitória da dor seguida de piora rápida com febre alta e abdome em tábua (sinal de perfuração com peritonite). ■■ Choque séptico com taquicardia e hipotensão.

Retorno / Reavaliação: Encaminhamento cirúrgico de urgência para apendicectomia.

Diagnóstico 027: Intussuscepção / Invaginação Intestinal Aguda

CID-10: K56.1 | Faixa Etária: 3 meses a 3 anos (pico 6 a 12 meses)

Crítérios Clínicos: Tríade clássica: dor abdominal paroxística em cólica intensa (lactente flete as pernas e chora inconsolável, intercalado com letargia), vômitos e fezes em 'geleia de morango' (sangue + muco), associados a massa palpável em forma de salsicha em QSD.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Estabilização Hemodinâmica + Jejum Absoluto	Expansão venosa com SF 0,9% 20 mL/kg se choque/desidratação.	Conforme necessidade	Sonda nasogástrica aberta para descompressão.
Redução por Enema Hidrostático ou Pneumático sob Fluoroscopia/USG	Procedimento radiológico de primeira escolha na ausência de perfuração ou peritonite.	Até 3 tentativas	Realizado em centro hospitalar com equipe cirúrgica de prontidão.

2ª Linha / Resgate: Cirurgia de urgência (laparotomia/laparoscopia com redução manual ou enterectomia) se falha do enema, sinais de peritonite, pneumoperitônio ou choque refratário.

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização multiparamétrica e analgesia venosa. • Radiografia de abdome agudo e Ultrassonografia abdominal (sinal do alvo / pseudorrim).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Pneumoperitônio no RX de abdome (perfuração intestinal). ■■ Peritonite difusa com rigidez abdominal. ■■ Choque séptico/hipovolêmico.

Retorno / Reavaliação: Internação e observação por 24-48 horas após redução radiológica pelo risco de recorrência (cerca de 10%).

Diagnóstico 028: Giardíase Intestinal (Giardia lamblia)

CID-10: A07.1 | Faixa Etária: Lactentes, pré-escolares e escolares

Crítérios Clínicos: Diarreia crônica ou recorrente com fezes amareladas, espumosas, fétidas e gordurosas (esteatorreia), distensão abdominal importante, flatulência fétida, dor periumbilical e déficit de ganho ponderal.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Nitazoxanida suspensão oral 20 mg/mL (100 mg/5 mL) ou comprimido 500 mg	1 a 3 anos: 100 mg (5 mL) VO a cada 12h por 3 dias; 4 a 11 anos: 200 mg (10 mL) VO a cada 12h por 3 dias; >= 12 anos: 500 mg VO a cada 12h por 3 dias.	500 mg a cada 12h	Administrar junto com as refeições para aumentar absorção e reduzir intolerância gástrica.
Metronidazol suspensão oral 40 mg/mL (como benzoilmetronidazol)	15 a 20 mg/kg/dia VO dividido a cada 8h por 5 a 7 dias.	750 mg/dia (250 mg 3x/dia)	Alternativa clássica altamente eficaz.

2ª Linha / Resgate: Tinidazol (50 mg/kg/dia VO dose única - máx 2 g) ou Secnidazol (30 mg/kg/dia VO dose única - máx 2 g) em crianças > 2 anos.

Medidas Não Farmacológicas: • Higiene rigorosa das mãos, corte de unhas e lavagem de frutas e vegetais crus. • Consumo exclusivo de água filtrada ou fervida. • Tratamento de contactantes domiciliares sintomáticos.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Desidratação com vômitos profusos. ■■ Desnutrição grave com atraso de desenvolvimento.

Retorno / Reavaliação: Repetir exame parasitológico de fezes (EPF em 3 amostras) após 2 a 4 semanas se persistência de sintomas.

Diagnóstico 029: Helmintíases Intestinais Comuns (Ascaridíase, Enterobíase, Tricuríase, Ancilostomíase)

CID-10: B77.9 / B80 / B79 / B76.9 | Faixa Etária: Todas as idades (> 1–2 anos)

Critérios Clínicos: Ascaridíase: dor abdominal, eliminação de vermes, desnutrição; Enterobíase: prurido anal noturno intenso e vulvovaginite; Tricuríase/Ancilostomíase: dor em cólica, anemia ferropriva crônica.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Albendazol suspensão oral 40 mg/mL (frasco 10 mL = 400 mg) ou comprimido mastigável	Crianças > 2 anos: 400 mg VO em dose única. (Na Enterobíase: 400 mg dose única, REPETIR obrigatoriamente após 14 dias. Na Estrongiloidíase/Necatoríase: 400 mg 1x/dia por 3 dias).	400 mg/dose	Crianças de 1 a 2 anos: 200 mg (5 mL) dose única. Contraindicado em < 1 ano.
Mebendazol suspensão oral 20 mg/mL (100 mg/5 mL) ou comprimido 100 mg	100 mg VO a cada 12h por 3 dias consecutivos (qualquer peso/idade > 2 anos).	200 mg/dia	Alternativa de amplo espectro; na enterobíase: 100 mg dose única, repetir em 2 semanas.

2ª Linha / Resgate: Pamoato de Pirantel (11 mg/kg dose única - máx 1 g) como alternativa para enterobíase e ascaridíase.

Medidas Não Farmacológicas: • Tratamento simultâneo de todos os membros da família na enterobíase. • Troca e lavagem com água quente de roupas de cama e toalhas sem sacudi-las. • Higiene sanitária, água tratada e uso de calçados.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Obstrução intestinal mecânica por bolo de Ascaris (dor intensa, vômitos biliosos, parada de eliminação de gases e fezes). ■■ Anemia grave sintomática na ancilostomíase.

Retorno / Reavaliação: Avaliação clínica e repetição de dose após 14 dias se enterobíase.

Diagnóstico 030: Estrongiloidíase Pediátrica (Strongyloides stercoralis)

CID-10: B78.9 | Faixa Etária: Crianças > 15 kg ou > 2–5 anos

Critérios Clínicos: Dor abdominal epigástrica/cólica, diarreia aquosa crônica, lesões cutâneas serpiginosas migratórias pruriginosas (larva currens), sintomas respiratórios (tosse, sibilância - Síndrome de Löffler) e eosinofilia sanguínea importante.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Ivermectina gotas 6 mg/mL (ou comprimido 6 mg)	200 mcg/kg (0,2 mg/kg) VO em dose única diária por 1 a 2 dias consecutivos.	12 a 15 mg/dose	Primeira linha absoluta com taxa de cura > 90%; administrar com água em jejum de 2 horas. Evitar em < 15 kg.
Albendazol suspensão oral 40 mg/mL ou comprimido 400 mg	400 mg VO 1x/dia por 3 a 7 dias consecutivos.	400 mg/dia	Segunda linha (menor eficácia que ivermectina).

2ª Linha / Resgate: Na Síndrome de Hiperinfecção / Estrongiloidíase Disseminada (em imunossuprimidos): Ivermectina diária prolongada até erradicação parasitária nas fezes + antibioticoterapia de amplo espectro para sepse por enterobactérias.

Medidas Não Farmacológicas: • Rastreamento e tratamento prévio obrigatório de estrongiloidíase antes de iniciar corticoterapia sistêmica prolongada ou imunossupressores. • Uso de calçados para evitar penetração transcutânea de larvas filarioides.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Febre alta, dor abdominal aguda, hemorragia digestiva, insuficiência respiratória e sepse por Gram-negativos em imunocomprometidos.

Retorno / Reavaliação: Exame parasitológico de fezes pelo método de Baermann-Moraes após 2 a 4 semanas para confirmação de cura.

MÓDULO 03: DOENÇAS INFECCIOSAS, EXANTEMÁTICAS E SEPSE

Diagnóstico 031: Exantema Súbito / Roséola Infantil (Herpesvírus Humano 6 e 7)

CID-10: B08.2 | Faixa Etária: 6 meses a 2 anos (pico 9 a 12 meses)

Critérios Clínicos: Febre alta contínua ($\geq 39\text{-}40^{\circ}\text{C}$) por 3 a 5 dias em lactente em relativo bom estado geral. Desaparecimento súbito da febre (em crise) coincidente com o surgimento de exantema maculopapular róseo não pruriginoso, iniciando no tronco e disseminando para face e membros.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Antitérmicos e Analgésicos (Dipirona ou Paracetamol)	Dipirona 10-25 mg/kg ou Paracetamol 10-15 mg/kg VO a cada 6h se febre com desconforto.	Doses padrão	Tratamento estritamente sintomático. Não há indicação de antivirais ou antibióticos em imunocompetentes.

2ª Linha / Resgate: Ganciclovir ou Foscarnet apenas em imunossuprimidos graves com meningoencefalite por HHV-6.

Medidas Não Farmacológicas: • Hidratação oral fracionada durante o período febril. • Tranquilização dos pais quanto ao curso benigno e aparecimento esperado do exantema após a queda da febre. • Roupas leves e ambiente ventilado.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Crise convulsiva febril durante a elevação rápida da temperatura (ocorre em 10-15% dos casos). ■■ Prostração intensa que persiste mesmo nos períodos afebris. ■■ Aparecimento de petéquias ou sufusões hemorrágicas.

Retorno / Reavaliação: Retorno se persistência da febre além do 5º dia ou piora do estado geral.

Diagnóstico 032: Eritema Infeccioso / Quinta Doença (Parvovírus B19)

CID-10: B08.3 | Faixa Etária: 5 a 15 anos (escolares)

Critérios Clínicos: Fase 1: Eritema macular confluyente brilhante nas bochechas poupando a região perioral ('face esbofetada'); Fase 2: Exantema maculopapular reticulado rendilhado em tronco e extremidades extensoras; Fase 3: Recorrência transitória precipitada por calor, sol, banho quente ou estresse emocional por semanas.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Tratamento de Suporte e Sintomático	Dipirona 10-25 mg/kg ou Paracetamol 10-15 mg/kg VO a cada 6-8h se artralgia ou febre leve.	Doses habituais	Doença autolimitada; quando o exantema surge, a criança já não é mais transmissora (não necessita afastamento escolar).

2ª Linha / Resgate: Imunoglobulina Humana Intravenosa (IGIV) apenas em imunodeprimidos com aplasia pura de série vermelha ou anemia crônica por parvovírus.

Medidas Não Farmacológicas: • Evitar exposição solar prolongada e banhos muito quentes para não intensificar o exantema rendilhado. • Repouso relativo se artrite/artralgia em adolescentes.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Crise de Aplasia Eritroide transitória em portadores de anemias hemolíticas hereditárias (anemia falciforme, esferocitose): palidez extrema, taquicardia, cansaço e queda abrupta de Hb. ■■ Exposição de gestantes (risco de hidropisia fetal).

Retorno / Reavaliação: Hemograma imediato em pacientes com anemia falciforme expostos ou sintomáticos.

Diagnóstico 033: Doença Mão-Pé-Boca (Coxsackievirus A16 / Enterovírus A71)

CID-10: B08.4 | Faixa Etária: < 5 anos (especialmente < 3 anos)

Critérios Clínicos: Febre moderada, odinofagia, vesículas/úlceras dolorosas em cavidade oral (língua, gengiva, mucosa jugal, palato) associadas a pápulas e vesículas eritematosas ovaladas de centro cinza nas palmas das mãos, plantas dos pés, nádegas e região genital.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Analgesia Sistêmica (Dipirona gotas ou Paracetamol)	Dipirona 15 a 25 mg/kg/dose VO a cada 6h (manter horários regulares nas primeiras 48-72h se dor oral intensa).	1 g/dose	Controle ágil da dor é a chave para evitar a desidratação secundária à recusa de ingestão oral.
Ibuprofeno suspensão 50 mg/mL ou 100 mg/mL	5 a 10 mg/kg/dose VO a cada 6 a 8 horas por 2 a 3 dias.	400 mg/dose (máx 1.200 mg/dia)	Útil para analgesia anti-inflamatória em crianças bem hidratadas.

2ª Linha / Resgate: Protetores de mucosa orais (geles de ácido hialurônico); evitar sprays com anestésicos tópicos potentes em lactentes pelo risco de aspiração e metemoglobinemia.

Medidas Não Farmacológicas: • Alimentos líquidos ou pastosos, frios ou gelados (sorvetes, iogurtes, gelatinas, sucos não ácidos). • Evitar alimentos quentes, duros, salgados ou ácidos. • Hidratação oral rigorosa em pequenas porções com colher ou seringa. • Afastamento de creches/escolas até cicatrização das lesões orais e ausência de febre.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Desidratação com anúria > 6h, boca seca e prostração. ■■ Meningoencefalite ou miocardite por Enterovírus 71 (mioclonias, ataxia, taquicardia desproporcional, instabilidade hemodinâmica).

Retorno / Reavaliação: Reavaliação se recusa alimentar total ou sinais de desidratação.

Diagnóstico 034: Varicela Não Complicada (Catapora)

CID-10: B01.9 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Exantema vesicular polimórfico e pruriginoso ('gota de orvalho sobre pétala de rosa'), em vários estágios de evolução simultâneos (mácula, pápula, vesícula, pústula e crosta), com distribuição centrípeta (início em couro cabeludo/face/tronco).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Antihistamínico Sedativo ou Não Sedativo para Prurido	Dexclorfeniramina: 0,15 mg/kg/dia VO a cada 8h; OU Hidroxizina: 1 a 2 mg/kg/dia a cada 8-12h; OU Desloratadina: dose diária por idade.	Dose de bula	O alívio do prurido é indispensável para evitar escoriações e infecção bacteriana secundária.
Dipirona ou Paracetamol se febre e desconforto	Dipirona 10-25 mg/kg/dose ou Paracetamol 10-15 mg/kg/dose VO a cada 6h.	Dose padrão	CONTRAINDICAÇÃO ABSOLUTA de AAS (risco de Síndrome de Reye) e Ibuprofeno (risco de fascíte necrotizante e infecções estreptocócicas invasivas graves).

2ª Linha / Resgate: Aciclovir oral (20 mg/kg/dose máx 800 mg 4x/dia por 5 dias) indicado se: >= 12 anos, doença cutânea crônica, uso de corticoide/salicilatos ou 2º caso no domicílio (maior carga viral), iniciando nas primeiras 24-48h.

Medidas Não Farmacológicas: • Corte cuidadoso e limpeza das unhas da criança. • Banhos diários mornos com sabonete neutro (banhos de permanganato de potássio muito diluído ou aveia podem ser usados para conforto). • Isolamento domiciliar até que TODAS as lesões estejam em fase de crosta seca.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Febre alta após o 3º-4º dia de exantema ou recrudescência da febre. ■■ Sinais de infecção bacteriana secundária: eritema perilesional extenso, dor intensa, calor ou pus. ■■ Ataxia cerebelar, convulsões, sonolência excessiva ou taquipneia.

Retorno / Reavaliação: Retorno se qualquer lesão com hiperemia importante e dor ou novos picos de febre.

Diagnóstico 035: Varicela com Infecção Bacteriana Secundária (Impetiginização e Celulite)

CID-10: B01.8 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Lesões de varicela com crostas melicéricas espessas, eritema peri-lesional progressivo, calor, dor acentuada, supuração purulenta e febre alta recorrente (S. aureus e S. pyogenes).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Cefalexina suspensão oral 250 mg/5 mL ou 500 mg	50 a 100 mg/kg/dia VO dividido a cada 6 horas por 7 a 10 dias.	2 g a 4 g/dia	Excelente cobertura para S. aureus sensível e Streptococcus do grupo A.
Oxacina sódica IV (se internação por celulite extensa ou toxemia)	100 a 150 mg/kg/dia IV dividido a cada 6 horas.	12 g/dia	Indicado se lesões extensas, impossibilidade de VO ou evolução rápida.

2ª Linha / Resgate: Clindamicina (30 a 40 mg/kg/dia IV ou VO a cada 6-8h) se suspeita de infecção necrotizante ou choque tóxico estreptocócico/estafilocócico (bloqueia síntese de toxinas).

Medidas Não Farmacológicas: • Limpeza suave das lesões com água e sabão neutro. • Compressas úmidas com SF 0,9% para remoção atraumática de crostas. • Analgesia sistêmica com dipirona.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Dor desproporcional às lesões cutâneas, edema endurecido progressivo, equimoses, crepitação ou bolhas hemorrágicas (suspeita de Fasceíte Necrotizante - emergência cirúrgica). ■■ Toxemia, hipotensão e taquicardia.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação clínica obrigatória em 24 a 48 horas.

Diagnóstico 036: Herpes Zoster Pediátrico

CID-10: B02.9 | Faixa Etária: Crianças que tiveram varicela no 1º ano de vida ou imunodeprimidos

Critérios Clínicos: Erupção vesicular dolorosa agrupada em base eritematosa com distribuição estritamente unilateral respeitando 1 ou 2 dermatômos contíguos (mais frequente em dermatômos torácicos ou trigeminais).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Aciclovir suspensão oral 200 mg/5 mL ou comprimidos 200/400 mg	20 mg/kg/dose (máx 800 mg/dose) VO 4 a 5 vezes ao dia (a cada 4 a 6 horas acordado) por 7 dias.	800 mg por dose (4 g/dia)	Iniciar idealmente nas primeiras 72 horas do surgimento das lesões para acelerar a cicatrização e reduzir neurite.
Analgesia Sistêmica (Dipirona ou Paracetamol)	Dose padrão a cada 6h se dor neuropática/hiperalgesia.	Dose máxima padrão	Em crianças maiores com dor neuropática intensa, associar Gabapentina sob orientação.

2ª Linha / Resgate: Aciclovir intravenoso (30 mg/kg/dia ou 1.500 mg/m²/dia IV dividido a cada 8h) em imunodeprimidos ou herpes zoster oftálmico.

Medidas Não Farmacológicas: • Manter as lesões limpas e secas. • Avaliação oftalmológica de urgência se envolvimento da ponta do nariz (Sinal de Hutchinson) ou ramo oftálmico do trigêmeo.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Acometimento ocular (risco de ceratite herpética e perda visual). ■■ Zoster disseminado (> 20 lesões fora do dermatômo primário). ■■ Sinais de encefalite ou meningite.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação em 3 a 5 dias para acompanhar involução.

Diagnóstico 037: Escarlatina

CID-10: A38 | Faixa Etária: 3 a 12 anos (escolares)

Crítérios Clínicos: Faringoamigdalite estreptocócica associada a exantema micropapular eritematoso difuso áspero ('pele em lixa / lixa de madeira'), rubor malar com palidez perioral (Sinal de Filatov), linhas hiperpigmentadas nas dobras flexoras (Linhas de Pastia) e língua em framboesa.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Benzilpenicilina Benzatina suspensão injetável IM profunda	< 27 kg: 600.000 UI IM dose única; >= 27 kg: 1.200.000 UI IM dose única.	1.200.000 UI	Tratamento de primeira escolha; erradica o estreptococo e previne a febre reumática pós-estreptocócica.
Amoxicilina suspensão oral 250 mg/5 mL ou 500 mg	50 mg/kg/dia VO dividido a cada 8h (ou dose única de 50 mg/kg/dia) por 10 dias completos.	1 g/dia	Não suspender após o desaparecimento do exantema e da febre.

2ª Linha / Resgate: Azitromicina (12 mg/kg/dia por 5 dias) ou Claritromicina (15 mg/kg/dia por 10 dias) se alergia a betalactâmicos.

Medidas Não Farmacológicas: • Descamação lamelar característica surge após 7-14 dias (orientar a família sobre sua benignidade). • Hidratação oral e dieta pastosa. • Afastamento escolar por 24 horas após o início do antibiótico.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Disfagia grave com recusa de líquidos. ■■ Febre refratária após 48h de antibiótico. ■■ Edema matutino e urina escura após 2 a 3 semanas (rastrear GNDA).

Retorno / Reavaliação: Retorno se ausência de melhora clínica em 48h.

Diagnóstico 038: Mononucleose Infecciosa (Vírus Epstein-Barr)

CID-10: B27.0 | Faixa Etária: Pré-escolares, escolares e adolescentes

Crítérios Clínicos: Tríade clássica: febre prolongada (1 a 3 semanas), faringoamigdalite com exsudato membranoso espesso acinzentado e linfadenopatia generalizada simétrica (especialmente cadeia cervical posterior). Esplenomegalia e hepatomegalia em 50% dos casos; linfocitose atípica > 10% no hemograma.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Sintomáticos e Analgésicos (Dipirona ou Paracetamol)	Dipirona 10-25 mg/kg ou Paracetamol 10-15 mg/kg VO a cada 6h se dor ou febre.	Dose padrão	CONTRAINDICADO uso de Amoxicilina ou Ampicilina (desencadeia exantema maculopapular pruriginoso em > 90% dos pacientes com mononucleose, sem significar alergia verdadeira à penicilina).

2ª Linha / Resgate: Corticoterapia sistêmica de curta duração (Prednisolona 1 mg/kg/dia por 5 a 7 dias) APENAS em complicações graves: obstrução iminente de vias aéreas por hipertrofia amigdaliana maciça, anemia hemolítica autoimune ou trombocitopenia grave.

Medidas Não Farmacológicas: • Repouso e AFASTAMENTO RIGOROSO de esportes de contato e exercícios físicos intensos por no mínimo 3 a 4 semanas (risco iminente de RUPTURA ESPLÊNICA traumática). • Hidratação oral abundante.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Dor abdominal súbita intensa em hipocôndrio esquerdo irradiada para o ombro esquerdo (Sinal de Kehr - ruptura esplênica). ■■ Estridor inspiratório e dispneia por edema de orofaringe. ■■ Icterícia intensa ou sangramentos.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento semanal até regressão da esplenomegalia antes de liberar para atividades físicas.

Diagnóstico 039: Dengue Pediátrica - Grupo A e B (Manejo Ambulatorial)

CID-10: A90 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Febre aguda (2 a 7 dias) associada a cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, prostração e exantema. Grupo A: sem sinais de alarme, sem comorbidades e sem sangramento; Grupo B: sem sinais de alarme, mas com sangramento de pele espontâneo (petéquias), prova do laço positiva, lactentes < 2 anos ou comorbidades.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Hidratação Oral Imediata e Rigorosa com SRO e Líquidos Caseiros	< 10 kg: 130 mL/kg/dia; 10 a 20 kg: 100 mL/kg/dia; > 20 kg: 80 mL/kg/dia (sendo 1/3 do volume sob a forma de SRO e 2/3 com água, sucos de frutas, água de coco).	Conforme cálculo	Pilar central do tratamento da dengue; administrar continuamente de forma fracionada ao longo do dia.
Dipirona gotas 500 mg/mL ou Paracetamol gotas 200 mg/mL	Dipirona 10-25 mg/kg ou Paracetamol 10-15 mg/kg VO a cada 6h se dor ou febre.	Dose padrão	CONTRAINDICADOS AINES (Ibuprofeno, Cetoprofeno, Diclofenaco) e AAS pelo risco de sangramento e choque.

2ª Linha / Resgate: Grupo B exige Hemograma completo obrigatório no primeiro atendimento (avaliação de hematócrito basal e plaquetas) e observação até resultado.

Medidas Não Farmacológicas: • Repouso e hidratação oral contínua. • Monitorização diária do aparecimento de sinais de alarme, especialmente no período de desfeverscência (3º ao 6º dia de doença - fase crítica).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdome. ■■ Vômitos persistentes. ■■ Hipotensão postural, tontura ou lipotímia. ■■ Hepatomegalia dolorosa > 2 cm do rebordo costal. ■■ Sangramento de mucosas (epistaxe, gengivorragia). ■■ Letargia ou irritabilidade extrema. ■■ Aumento progressivo do hematócrito ou queda abrupta de plaquetas.

Retorno / Reavaliação: Grupo A: retorno no dia da queda da febre ou se sinais de alarme. Grupo B: reavaliação clínica diária até 48h após o fim da febre.

Diagnóstico 040: Dengue Pediátrica - Grupo C e D (Sinais de Alarme e Choque por Dengue)

CID-10: A91 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Grupo C: Presença de 1 ou mais sinais de alarme (dor abdominal intensa, vômitos incoercíveis, acúmulo de líquidos em pleura/peritônio, hepatomegalia > 2cm, letargia, hemoconcentração). Grupo D: Dengue grave com choque circulatório (pulso fino, enchimento capilar > 3s, PA convergente ou hipotensão), sangramento grave ou disfunção orgânica.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Grupo C: Fase de Expansão Rápida IV com Solução Fisiológica 0,9%	10 mL/kg/hora IV na primeira hora (repetir até 3 vezes se necessário até estabilização e redução do hematócrito).	Conforme resposta	Se melhora clínica e laboratorial, reduzir para 8 mL/kg/h por 2h -> 5 mL/kg/h por 2h -> 3 mL/kg/h por 2h e manutenção.
Grupo D (Choque): Fase de Ressuscitação Volêmica Imediata com SF 0,9%	20 mL/kg IV em 20 minutos (pode ser repetido até 3 vezes). Se refratário: albumina humana 5% (0,5 a 1 g/kg) ou drogas vasoativas.	Conforme metas hemodinâmicas	Monitorização rigorosa de sinais de sobrecarga volêmica.

2ª Linha / Resgate: Concentrado de hemácias se hemorragia volumosa com queda de hematócrito; Concentrado de plaquetas apenas em sangramentos com risco de morte ou plaquetas < 10.000/mm³.

Medidas Não Farmacológicas: • Internação hospitalar obrigatória (Grupo C em enfermaria/observação; Grupo D em UTI Pediátrica). • Hemograma completo com dosagem de hematócrito a cada 2 horas na fase de expansão e a cada 4-6 horas após estabilização. • Sondagem vesical de demora para monitorização estrita do débito urinário (meta > 1 mL/kg/h).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Choque refratário a volume com acidose metabólica grave. ■■ Hemorragia digestiva maciça. ■■ Derrame pleural volumoso com insuficiência respiratória.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação clínica e hematócrito seriado a cada 2 horas durante a fase crítica.

Diagnóstico 041: Chikungunya Aguda Pediátrica

CID-10: A92.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Febre alta de início abrupto associada a poliartralgia/poliartrite intensa simétrica distal (mãos, punhos, tornozelos), exantema maculopapular e, em neonatos e lactentes jovens, lesões bolhosas e hiperpigmentação cutânea difusa.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Dipirona ou Paracetamol para Controle da Dor Articular	Dipirona 15-25 mg/kg ou Paracetamol 10-15 mg/kg VO a cada 6h de horário fixo nos primeiros dias de dor intensa.	Dose máxima padrão	A dor articular pode ser incapacitante em crianças maiores.

2ª Linha / Resgate: Tramadol (0,5 a 1 mg/kg/dose VO a cada 6-8h - máx 400 mg/dia) ou opioides fracos em crianças > 1 ano com dor intensa refratária sob supervisão médica. Corticoides e AINEs são CONTRAINDICADOS na fase aguda.

Medidas Não Farmacológicas: • Repouso articular, aplicação de compressas frias nas articulações inflamadas. • Hidratação oral rigorosa. • Fisioterapia motora suave na fase pós-aguda se rigidez articular.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Artrite com sinais de infecção bacteriana secundária. ■■ Acometimento neurológico (encefalite por Chikungunya, convulsões, letargia). ■■ Chikungunya neonatal por transmissão vertical intraparto (vigilância rigorosa de sepse e choque).

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento semanal até resolução da artralgia.

Diagnóstico 042: Infecção pelo Vírus Zika Pediátrica

CID-10: A92.8 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Exantema maculopapular pruriginoso precoce de início no 1º-2º dia, febre baixa ou ausente, hiperemia conjuntival não purulenta, artralgia leve e edema periarticular.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Tratamento de Suporte e Controle do Prurido	Dexclorfeniramina 0,15 mg/kg/dia VO a cada 8h; OU Desloratadina em dose diária para alívio do prurido.	Dose de bula	Dipirona ou Paracetamol se desconforto febril.
Colírio Lubrificante (Lágrimas Artificiais)	1 gota em cada olho 3 a 4 vezes ao dia.	Livre	Alívio do desconforto da conjuntivite não purulenta.

2ª Linha / Resgate: Avaliação neurológica se fraqueza muscular ascendente (suspeita de Síndrome de Guillain-Barré pós-Zika).

Medidas Não Farmacológicas: • Hidratação oral abundante. • Uso de repelentes adequados para a idade e telas mosquiteiras.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Fraqueza muscular progressiva de membros inferiores ou arreflexia. ■■ Dor ocular intensa ou fotofobia acentuada.

Retorno / Reavaliação: Retorno se persistência dos sintomas ou alterações motoras.

Diagnóstico 043: Febre Maculosa Brasileira (Rickettsia rickettsii)

CID-10: A77.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Histórico de exposição a carrapatos (Amblyomma sculptum / carrapato-estrela) em áreas endêmicas (especialmente MG e interior de SP) associado a febre alta súbita, cefaleia intensa, mialgia difusa e exantema máculo-papular centrípeto que surge no 3º-5º dia, acometendo palmas e plantas, evoluindo para petéquias e púrpura.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Doxiciclina suspensão/comprimido VO ou IV (Tratamento Imediato de Escolha)	< 45 kg: 2,2 mg/kg/dose VO ou IV a cada 12 horas por 7 a 14 dias (ou por pelo menos 3 dias após a resolução da febre); >= 45 kg: 100 mg VO ou IV a cada 12 horas.	200 mg/dia	A Doxiciclina é o medicamento de primeira escolha EM QUALQUER IDADE (inclusive menores de 8 anos e neonatos) devido à altíssima letalidade da doença. NÃO postergar o início pelo receio de manchas dentárias em tratamentos curtos.

2ª Linha / Resgate: Cloranfenicol (50 a 75 mg/kg/dia IV dividido a cada 6h - máx 3 g/dia) como segunda linha apenas se contraindicação absoluta ou indisponibilidade de doxiciclina (menor eficácia comprovada).

Medidas Não Farmacológicas: • NUNCA aguardar confirmação sorológica para iniciar o tratamento (a letalidade ultrapassa 50-80% se o tratamento for iniciado após o 5º dia de sintomas). • Suporte intensivo e hidratação parenteral precoce.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Choque vasoplégico com extravasamento capilar difuso. ■■ Insuficiência renal aguda, hemorragias e edema pulmonar. ■■ Encefalite com coma.

Retorno / Reavaliação: Internação hospitalar obrigatória em leito de alta complexidade/UTI.

Diagnóstico 044: Leptospirose Pediátrica Aguda

CID-10: A27.9 | Faixa Etária: Pré-escolares, escolares e adolescentes

Critérios Clínicos: Histórico de contato com águas de enchente ou roedores associado a febre alta súbita, cefaleia intensa, mialgia severa com predileção pelas panturrilhas e sufusão conjuntival (hiperemia conjuntival sem exsudato). Na forma grave (Síndrome de Weil): icterícia rubínica, IRA oligoanúrica e hemorragia pulmonar.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Formas Leves (Ambulatorial): Amoxicilina ou Doxiciclina	Amoxicilina: 50 mg/kg/dia VO a cada 8h por 7 dias; OU Doxiciclina (em > 8 anos): 2 a 4 mg/kg/dia a cada 12h por 7 dias.	Amoxicilina 1,5 g/dia; Doxiciclina 200 mg/dia	Iniciar o mais precocemente possível na primeira semana de sintomas.
Formas Graves / Síndrome de Weil (Hospitalar): Benzilpenicilina Cristalina IV ou Ceftriaxona IV	Penicilina Cristalina: 200.000 a 400.000 UI/kg/dia IV dividido a cada 4-6h por 7 dias; OU Ceftriaxona: 80 a 100 mg/kg/dia IV 1x/dia por 7 dias.	Penicilina 24 milhões UI/dia; Ceftriaxona 2 g/dia	Monitorar Reação de Jarisch-Herxheimer (febre, calafrios e hipotensão) nas primeiras horas de antibiótico.

2ª Linha / Resgate: Suporte hemodinâmico, correção de hipocalemia (comum na nefropatia por leptospira) e ventilação mecânica protetora se hemorragia alveolar.

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização rigorosa do balanço hídrico, função renal (ureia/creatinina) e eletrólitos. • Hemodiálise precoce se IRA hipercatabólica.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Hemoptise ou desconforto respiratório súbito (Hemorragia Pulmonar Maciça - principal causa de óbito). ■■ Oligúria e icterícia intensa. ■■ Choque e arritmias.

Retorno / Reavaliação: Internação imediata se qualquer sinal de alarme ou acometimento de órgãos-alvo.

Diagnóstico 045: Seps e Pediátrica e Choque Séptico (Protocolo de 1ª Hora)

CID-10: A41.9 / R57.2 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Suspeita ou confirmação de infecção associada a disfunção orgânica aguda (taquicardia/bradicardia, taquipneia, alteração de temperatura, tempo de enchimento capilar > 2s ou pulsos periféricos débeis, alteração do estado mental e oligúria). No choque: hipotensão arterial ou má perfusão periférica persistente.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Ressuscitação Volêmica com Cristaloide Balanceado ou SF 0,9% IV/IO	Alíquotas de 10 a 20 mL/kg IV/IO infundidas em 10 a 20 minutos (avaliando resposta e sinais de sobrecarga a cada alíquota até 40-60 mL/kg na 1ª hora).	Titulado pelas metas	Puncionar via intraóssea se sem acesso venoso em 1 minuto. Suspende expansão se surgirem estertores ou hepatomegalia.
Antibioticoterapia de Amplo Espectro IV na 1ª Hora	Ceftriaxona 100 mg/kg IV + Oxacilina 150-200 mg/kg/dia (ou Ampicilina + Gentamicina em neonatos; ou Cefepima + Vancomicina se infecção hospitalar/neutropenia).	Doses máximas	Coletar hemoculturas antes do antibiótico sem atrasar a infusão além de 60 minutos.
Drogas Vasoativas Precoces (Adrenalina ou Noradrenalina IV/IO)	Choque frio (baixa perfusão/vasoconstrição): Adrenalina 0,05 a 0,3 mcg/kg/min; Choque quente (vasoplegia/pulsos amplos): Noradrenalina 0,05 a 0,3 mcg/kg/min.	Titular conforme PAM	Pode ser iniciada por via periférica ou intraóssea provisória enquanto se providencia o acesso venoso central.

2ª Linha / Resgate: Hidrocortisona (1 a 2 mg/kg/dose IV a cada 6h - máx 200 mg/dia) se Choque Séptico Refratário a Catecolaminas (suspeita de insuficiência adrenal relativa).

Medidas Não Farmacológicas: • Oxigenioterapia para SpO2 >= 94%. • Monitorização multiparamétrica invasiva ou não invasiva em UTI. • Controle glicêmico (evitar hipoglicemia) e correção de hipocalcemia.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Emergência médica absoluta tempo-dependente.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação contínua minuto a minuto na primeira hora de ressuscitação.

MÓDULO 04: NEUROLOGIA E EMERGÊNCIAS NEUROCRÍTICAS

Diagnóstico 046: Crise Convulsiva Febril Simples

CID-10: R56.0 | Faixa Etária: 6 meses a 5 anos (pico 18 meses)

Critérios Clínicos: Crise tônico-clônica generalizada com duração < 15 minutos, episódio único em 24 horas, ocorrida durante ascensão térmica rápida em criança neurologicamente normal, sem infecção intracraniana e com recuperação completa do estado mental em < 1 hora.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Manejo da Crise em Curso: Benzodiazepínico (Diazepam ou Midazolam)	Se crise > 5 minutos: Diazepam 0,2 a 0,3 mg/kg IV lento (ou Diazepam retal 0,5 mg/kg) OU Midazolam 0,2 mg/kg IM/nasal/bucal.	Diazepam 10 mg; Midazolam 10 mg	A vasta maioria cessa espontaneamente em 2 a 3 minutos antes da medicação.
Controle Térmico Sintomático (Dipirona ou Paracetamol)	Dipirona 10-25 mg/kg ou Paracetamol 10-15 mg/kg VO/IV se desconforto febril.	Dose padrão	Antitérmicos trazem conforto, mas NÃO previnem a ocorrência de novas crises febris.

2ª Linha / Resgate: Anticonvulsivantes contínuos de manutenção (Fenobarbital/Valproato) NÃO são indicados para convulsão febril simples.

Medidas Não Farmacológicas: • Posicionamento da criança em decúbito lateral para prevenir aspiração. • Proteção contra traumas locais sem introduzir objetos na boca. • Desmistificação e tranquilização da família quanto ao excelente prognóstico neurológico sem sequelas cognitivas.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Crise com duração > 10-15 minutos. ■■ Crise focal ou assimetria motora residual (Paralisia de Todd > 1h). ■■ Recorrência em menos de 24 horas. ■■ Sinais de irritação meníngea (rigidez de nuca, abaulamento de fontanela) ou letargia persistente.

Retorno / Reavaliação: Investigação obrigatória do foco infeccioso; punção lombar fortemente recomendada em < 6-12 meses não vacinados contra Hib/Pneumococo ou com sinais de toxemia.

Diagnóstico 047: Crise Convulsiva Febril Complexa

CID-10: R56.0 | Faixa Etária: 6 meses a 5 anos

Critérios Clínicos: Presença de pelo menos uma das características: 1) Crise focal (ou com início focal); 2) Duração prolongada >= 15 minutos; 3) Recorrência de 2 ou mais episódios no mesmo período de 24 horas.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Midazolam ou Diazepam na Fase Aguda	Midazolam 0,2 mg/kg IM/nasal ou Diazepam 0,2 a 0,3 mg/kg IV se crise em atividade no momento da admissão.	10 mg	Garantir permeabilidade de via aérea e suporte ventilatório.
Investigação Infecciosa e Neurológica Hospitalar	Punção lombar indicada para afastar meningite/encefalite em crises complexas ou estado pós-ictal prolongado.	N/A	Considerar TC de crânio antes da PL se déficit neurológico focal ou sinais de HIC.

2ª Linha / Resgate: Levetiracetam (20 a 40 mg/kg/dia) ou Fenobarbital em casos selecionados com múltiplos episódios ou epilepsia de base.

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização contínua de saturação e frequência cardíaca em sala de emergência. • Orientação familiar sobre primeiros socorros em crises.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Evolução para Estado de Mal Epiléptico Febril (> 30 minutos). ■■ Déficit motor focal persistente. ■■ Rebaixamento prolongado de consciência.

Retorno / Reavaliação: Observação hospitalar mínima de 24 horas e seguimento com neuropediatra.

Diagnóstico 048: Estado de Mal Epiléptico Pediátrico (Status Epilepticus)

CID-10: G41.9 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Crise convulsiva contínua com duração >= 5 minutos (tempo t1) OU duas ou mais crises consecutivas sem recuperação completa da consciência entre os episódios. Risco de dano neuronal permanente a partir de 30 minutos (tempo t2).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
1ª Linha (0 a 5-10 min): Benzodiazepínico IV / IM / IO	Diazepam 0,2 a 0,3 mg/kg IV/IO lento (máx 10 mg) OU Midazolam 0,2 mg/kg IM/IO/nasal (máx 10 mg). Pode repetir 1 vez após 5 minutos se persistência da crise.	Diazepam 10 mg; Midazolam 10 mg	Monitorar depressão respiratória; ter material de via aérea avançada preparado.
2ª Linha (10 a 20-30 min): Anticonvulsivante de Ação Prolongada IV	Levetiracetam 60 mg/kg IV (máx 4,5 g) em 10 min OU Fenitoína sódica 20 mg/kg IV (máx 1 g) diluída em SF 0,9% (velocidade máx 1 mg/kg/min ou 50 mg/min) OU Fenobarbital sódico 20 mg/kg IV (primeira escolha em neonatos).	Levetiracetam 4,5 g; Fenitoína 1 g; Fenobarbital 1 g	Fenitoína exige monitorização eletrocardiográfica contínua durante a infusão (risco de arritmias e hipotensão).

2ª Linha / Resgate: 3ª Linha (Status Refratário > 30-40 min): Intubação traqueal e infusão contínua de Midazolam (0,1 a 2 mg/kg/h) ou Propofol (1 a 5 mg/kg/h em > 16 anos) ou Cetamina (1 a 5 mg/kg/h) sob monitorização por EEG contínuo em UTI.

Medidas Não Farmacológicas: • Abordagem ABCDE imediata: via aérea pérvia, oxigênio a 100%, aspiração de secreções. • Glicemia capilar imediata (corrigir hipoglicemia com Glicose 10% 2 a 5 mL/kg IV se < 60 mg/dL). • Acesso venoso ou punção intraóssea rápida.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Crise persistente além de 30 minutos. ■■ Hipotensão arterial, acidose láctica grave e rabdomiólise. ■■ Depressão respiratória pós-benzodiazepínico.

Retorno / Reavaliação: Internação mandatória em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.

Diagnóstico 049: Cefaleia Primária Tensional na Infância

CID-10: G44.2 | Faixa Etária: Escolares e adolescentes

Critérios Clínicos: Cefaleia bilateral em aperto/pressão ('em faixa/capacete'), intensidade leve a moderada, não agravada por atividade física rotineira, sem náuseas importantes ou vômitos, podendo apresentar fotofobia OU fonofobia (não ambas).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Dipirona gotas 500 mg/mL ou comprimido	15 a 25 mg/kg/dose VO no início dos sintomas.	1 g/dose	Administrar precocemente no início do quadro.
Ibuprofeno suspensão 100 mg/mL ou comprimido 400 mg	10 mg/kg/dose VO (máx 400 mg) com alimentos.	400 mg/dose (1.200 mg/dia)	Limitar o uso de analgésicos a no máximo 2 a 3 dias por semana para evitar Cefaleia por Uso Excessivo de Medicamentos.

2ª Linha / Resgate: Relaxamento muscular e psicoterapia cognitivo-comportamental em cefaleias tensionais crônicas frequentes.

Medidas Não Farmacológicas: • Ambiente calmo, escuro e silencioso para repouso. • Compressas mornas ou frias na região cervical e fronte. • Higiene do sono (horários regulares), hidratação oral adequada e redução do tempo de telas (smartphones/tablets).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Cefaleia de início súbito e intensidade máxima instantânea ('em trovoadas'). ■■ Cefaleia que desperta a criança à noite ou associada a vômitos matinais em jato. ■■ Piora progressiva com tosse/Valsalva, alteração de comportamento, déficit motor ou papiledema.

Retorno / Reavaliação: Manter diário de cefaleia e reavaliar em 4 a 6 semanas.

Diagnóstico 050: Enxaqueca Pediátrica (Crise Aguda e Profilaxia)

CID-10: G43.9 | Faixa Etária: Escolares e adolescentes

Crítérios Clínicos: Cefaleia recorrente (≥ 5 crises) com duração de 2 a 72 horas, frequentemente bifrontal ou unilateral em crianças, caráter pulsátil, intensidade moderada a grave, agravada por esforço físico, associada a náuseas/vômitos, fotofobia e fonofobia concomitantes, com ou sem aura visual prévia.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Tratamento da Crise Aguda: Ibuprofeno + Dipirona	Ibuprofeno 10 mg/kg/dose VO (máx 600-800 mg) associado ou alternado com Dipirona 15-25 mg/kg/dose VO administrados nos primeiros 15-30 minutos da crise.	Ibuprofeno 800 mg; Dipirona 1 g	Quanto mais precoce a administração, maior a taxa de abortamento da crise.
Triptanos em Adolescentes ≥ 12 anos: Sumatriptano spray nasal ou Zolmitriptano	Sumatriptano spray nasal 10 a 20 mg em 1 narina (em ≥ 12 anos) se refratariedade aos analgésicos comuns.	20 mg/dose (máx 40 mg/24h)	Contraindicado em enxaqueca com aura de tronco/basilar ou enxaqueca hemiplégica.

2ª Linha / Resgate: Profilaxia (se ≥ 3 a 4 crises incapacitantes/mês): Propranolol (1 a 2 mg/kg/dia VO a cada 12h), Topiramato (1 a 3 mg/kg/dia a cada 12h) ou Flunarizina (5 mg à noite em > 10 anos) por 6 a 12 meses.

Medidas Não Farmacológicas: • Repouso imediato em quarto escuro e silencioso. • Identificação e evitação de gatilhos alimentares (chocolates, queijos maturados, embutidos, jejum prolongado) e controle de estresse/privação de sono. • Hidratação oral.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Primeira crise de cefaleia intensa sem histórico prévio. ■■ Sinais neurológicos focais persistentes após a resolução da dor. ■■ Cefaleia em < 3 a 5 anos de idade.

Retorno / Reavaliação: Diário de dor e reavaliação médica em 30 a 60 dias.

Diagnóstico 051: Meningite Bacteriana Aguda Pediátrica

CID-10: G00.9 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Febre alta de início abrupto, cefaleia intensa, vômitos em jato, rigidez de nuca (Sinais de Kernig e Brudzinski positivos), abaulamento de fontanela em lactentes, fotofobia, prostração grave, confusão mental ou petéquias/púrpura fulminante (Meningococo). Líquor turvo com pleocitose neutrofílica, hiperproteinorraquia e hipoglicorraquia.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Dexametasona 4 mg/mL IV (Administrar ANTES ou JUNTO à 1ª dose de antibiótico)	0,15 mg/kg/dose IV a cada 6 horas por 2 a 4 dias.	10 mg/dose	Reduz o risco de perda auditiva neurossensorial e sequelas neurológicas (especialmente em meningite por Hib e Pneumococo). Não iniciar se antibiótico já tiver sido administrado há mais de 4 horas.
Ceftriaxona pó liofilizado injetável IV (Dose Meníngea)	100 mg/kg/dia IV a cada 12 horas (ou 100 mg/kg 1x/dia) por 7 a 14 dias.	4 g/dia (2 g a cada 12h)	Primeira escolha para N. meningitidis, S. pneumoniae e H. influenzae.
Vancomicina frasco-ampola IV (Associar se suspeita de Pneumococo resistente ou < 2 anos)	60 mg/kg/dia IV dividido a cada 6 horas (infundir em 60 minutos).	2 g a 3 g/dia	Monitorar nível sérico de vancomicina (vale alvo 15-20 mcg/mL) e função renal.

2ª Linha / Resgate: Ampicilina (200 a 300 mg/kg/dia IV a cada 6h) associada em neonatos e lactentes < 3 meses para cobertura de Listeria monocytogenes e Streptococcus agalactiae (GBS). Quimioprofilaxia de contatos íntimos com Rifampicina ou Ceftriaxona se Meningococo ou Hib.

Medidas Não Farmacológicas: • Isolamento respiratório por gotículas nas primeiras 24 horas de antibioticoterapia efetiva. • Monitorização contínua de sinais vitais, diurese e perímetro cefálico em lactentes. • Neuroproteção e controle de pressão de perfusão cerebral.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Instabilidade hemodinâmica e choque séptico refratário (Síndrome de Waterhouse-Friderichsen). ■■ Sinais de herniação cerebral iminente (tríade de Cushing: bradicardia, hipertensão e respiração irregular). ■■ Convulsões de difícil controle e coma.

Retorno / Reavaliação: Internação imediata em UTI Pediátrica.

Diagnóstico 052: Meningoencefalite Viral (Herpes Simplex e Enterovírus)

CID-10: G04.0 / B00.4 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Febre, cefaleia, alteração aguda do comportamento/personalidade, rebaixamento do nível de consciência, crises convulsivas focais, afasia e sinais meníngeos. Líquor com predomínio linfomononuclear, glicose normal e PCR positiva.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Aciclovir pó liofilizado injetável IV (Dose Encefalite)	Neonatos: 20 mg/kg/dose IV a cada 8 horas por 21 dias; Crianças (3 meses a 12 anos): 15 a 20 mg/kg/dose (ou 500 mg/m²/dose) IV a cada 8 horas por 14 a 21 dias; > 12 anos: 10 mg/kg/dose IV a cada 8h.	500 mg/m²/dose	Iniciar IMEDIATAMENTE diante de qualquer suspeita de encefalite herpética antes do resultado da PCR líquórica. Infundir lentamente em 1 hora e garantir hidratação venosa vigorosa para prevenir insuficiência renal por precipitação de cristais intratubulares.

2ª Linha / Resgate: Suporte antiepiléptico precoce com Levetiracetam ou Fenitoína se crises convulsivas associadas.

Medidas Não Farmacológicas: • Eletroencefalograma (EEG) e Ressonância Magnética de encéfalo (hiperintensidade em lobos temporais característica de HSV). • Suporte neurocrítico em UTI.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Estado de mal epiléptico refratário. ■■ Hipertensão intracraniana grave com risco de herniação uncal. ■■ Coma profundo.

Retorno / Reavaliação: Manter Aciclovir IV até exclusão definitiva de HSV por PCR no Líquor com mais de 72h de evolução clínica.

Diagnóstico 053: Hipertensão Intracraniana Aguda no PA / UTI Pediátrica

CID-10: G93.2 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Tríade clássica: cefaleia progressiva intensa, vômitos em jato e alteração do nível de consciência / letargia. Sinais avançados: Tríade de Cushing (hipertensão arterial, bradicardia e bradipneia/irregularidade respiratória), papiledema, assimetria pupilar e postura de decorticação/descerebração.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Solução Salina Hipertônica a 3% (NaCl 3%) IV	Bolus de resgate: 2 a 5 mL/kg IV infundidos em 10 a 20 minutos (pode ser repetido se PIC > 20 mmHg). Manutenção: infusão contínua para alvo de Na+ sérico entre 145 e 155 mEq/L e osmolaridade < 360 mOsm/L.	5 mL/kg/bolus	Primeira escolha atual no trauma e edema cerebral pediátrico (menor risco de hipotensão e hipovolemia que o manitol).
Manitol a 20% solução injetável IV	0,25 a 0,5 g/kg (1,25 a 2,5 mL/kg de Manitol 20%) IV em 20 a 30 minutos.	1 g/kg/dose	CONTRAINDICADO em pacientes com choque, hipotensão arterial ou insuficiência renal anúrica.

2ª Linha / Resgate: Sedação profunda e analgesia contínua (Fentanil + Midazolam ou Cetamina); Bloqueio neuromuscular (Cisatracúrio/Rocurônio); Drenagem líquórica via derivação ventricular externa (DVE); Craniectomia descompressiva de resgate.

Medidas Não Farmacológicas: • Posicionamento da cabeça em linha média com elevação da cabeceira a 30 graus (facilita a drenagem venosa jugular). • Ventilação mecânica com alvo de normocapnia (PaCO2 35-40 mmHg); hiperventilação transitória (PaCO2 30-35 mmHg) APENAS em sinais iminentes de herniação. • Normotermia rigorosa (evitar febre com Dipirona e medidas físicas) e normoglicemia.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Anisocoria pupilar súbita com perda do reflexo fotomotor (herniação uncal). ■■ Bradicardia extrema com hipertensão severa (Tríade de Cushing).

Retorno / Reavaliação: Internação imediata em UTI Pediátrica com monitorização invasiva de PIC se TCE grave.

Diagnóstico 054: Traumatismo Cranioencefálico (TCE) Leve - Protocolo PECARN

CID-10: S06.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Escala de Coma de Glasgow (ECG) = 14 ou 15 após o trauma. Aplicação dos critérios PECARN para decisão de TC de crânio vs. observação clínica: < 2 anos (risco alto: ECG <= 14, fratura de crânio palpável; risco intermediário: hematoma subgaleal não frontal, perda de consciência > 5s, mecanismo grave, comportamento anormal); >= 2 anos (risco alto: ECG <= 14, sinais de fratura de base de crânio; risco intermediário: perda de consciência, vômitos, mecanismo grave, cefaleia intensa).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Analgesia Leve a Moderada (Dipirona ou Paracetamol)	Dipirona 10-25 mg/kg ou Paracetamol 10-15 mg/kg VO a cada 6h se dor local.	Dose padrão	Evitar sedativos ou anti-histamínicos que interfiram na avaliação neurológica sequencial.

2ª Linha / Resgate: Se alto risco PECARN: Tomografia Computadorizada de Crânio sem contraste imediata. Se risco intermediário: período de observação clínica de 4 a 6 horas no PA antes de decidir por TC.

Medidas Não Farmacológicas: • Observação clínica neurológica seriada (escala de Glasgow, reatividade pupilar e comportamento). • Orientações formais e por escrito aos responsáveis sobre sinais de alerta para retorno imediato.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Piora da dor de cabeça ou choro contínuo inconsolável. ■■ Mais de 2 episódios de vômitos. ■■ Sonolência excessiva, dificuldade para despertar ou confusão. ■■ Convulsões, fraqueza em membros ou assimetria pupilar. ■■ Saída de sangue ou líquido claro pelo nariz ou ouvidos (rinoliquorria/otoliquorria).

Retorno / Reavaliação: Alta após 4 a 6 horas de observação se paciente assintomático, estável e com cuidadores confiáveis.

Diagnóstico 055: Traumatismo Cranioencefálico (TCE) Moderado a Grave

CID-10: S06.9 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Moderado: Glasgow 9 a 13; Grave: Glasgow <= 8. Presença de lesão neurológica anatômica (hematoma extradural, subdural, contusão parenquimatosa ou hemorragia subaracnóidea traumática).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Intubação Traqueal Sequência Rápida com Neuroproteção (se Glasgow <= 8)	Premedicação com Fentanil (1 a 2 mcg/kg IV) + Indução com Cetamina (1 a 2 mg/kg IV) ou Etomidato (0,3 mg/kg IV) + Bloqueador Neuromuscular (Rocurônio 1 a 1,2 mg/kg IV ou Succinilcolina 1 a 2 mg/kg).	Doses padrão	Evitar hipóxia e hipotensão a todo custo (um único episódio de hipotensão duplica a mortalidade no TCE grave).
Solução Fisiológica 0,9% para Manutenção da Pressão Arterial Alvo	Bolus de 10 a 20 mL/kg IV se sinais de choque/hipotensão para manter PAM acima do percentil 50 para a idade.	Conforme metas	NUNCA utilizar soluções hipotônicas (SG 5%, SF 0,45%) pelo risco de piora imediata do edema cerebral.
Profilaxia Anticonvulsivante Precoce: Levetiracetam ou Fenitoína IV	Levetiracetam: 20 a 30 mg/kg/dose IV a cada 12h; OU Fenitoína: ataque 20 mg/kg IV seguido de 5 mg/kg/dia.	Levetiracetam 3 g/dia; Fenitoína 300 mg/dia	Previne crises convulsivas precoces nos primeiros 7 dias pós-trauma.

2ª Linha / Resgate: Osmoterapia com NaCl 3% (2 a 5 mL/kg em bolus) se suspeita de hipertensão intracraniana; Avaliação neurocirúrgica de emergência para drenagem de hematomas expansivos.

Medidas Não Farmacológicas: • TC de crânio urgente após estabilização hemodinâmica e de via aérea. • Imobilização cervical com colar adequado até exclusão de lesão raquimedular. • Cabeceira a 30° centrada.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Deterioração rápida do escore de Glasgow (queda >= 2 pontos). ■■ Midríase unilateral fixa (herniação de uncus por hematoma extradural).

Retorno / Reavaliação: Internação imediata em UTI Pediátrica e acompanhamento neurocirúrgico contínuo.

Diagnóstico 056: Síndrome de Guillain-Barré Pediátrica

CID-10: G61.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Polirradiculoneuropatia inflamatória desmielinizante aguda pós-infecciosa (1 a 4 semanas após diarreia por Campylobacter ou infecção viral), caracterizada por fraqueza muscular simétrica progressiva ascendente (pernas -> tronco -> braços), arreflexia tendínea profunda osteotendínea global e dissociação proteíno-citológica no líquido.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Imunoglobulina Humana Intravenosa (IGIV) 5% ou 10%	2 g/kg IV administrados em dose total dividida: 1 g/kg/dia por 2 dias consecutivos (ou 400 mg/kg/dia por 5 dias consecutivos).	2 g/kg dose total	Tratamento de primeira escolha; iniciar preferencialmente nas primeiras 2 semanas de evolução para bloquear a progressão da paralisia.
Plasmaférese (Troca Plasmática)	4 a 5 sessões em dias alternados (alternativa de igual eficácia à IGIV, preferida em crianças maiores e adolescentes).	5 sessões	Exige acesso vascular calibroso e equipe especializada.

2ª Linha / Resgate: Corticoides sistêmicos (Prednisona/Metilprednisolona) NÃO SÃO EFICAZES e não devem ser utilizados no tratamento da Síndrome de Guillain-Barré.

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização rigorosa da Capacidade Vital Forçada e padrão respiratório (risco de paralisia diafragmática súbita). • Prevenção de tromboembolismo e cuidados posturais com fisioterapia motora precoce. • Vigilância de disautonomia cardiovascular (flutuações de PA e arritmias).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Insuficiência respiratória neuromuscular aguda por fraqueza diafragmática / intercostal (indicação de intubação eletiva). ■■ Disfagia grave com risco de broncoaspiração. ■■ Parada cardíaca por disautonomia grave.

Retorno / Reavaliação: Internação em UTI Pediátrica durante a fase progressiva da doença.

Diagnóstico 057: Paralisia Facial Periférica Aguda (Paralisia de Bell)

CID-10: G51.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Fraqueza ou paralisia aguda e unilateral de TODOS os músculos da mímica facial (incluindo a fronte/sobrancelha, com incapacidade de fechar o olho completamente - Sinal de Bell e apagamento do sulco nasolabial), de início súbito em < 48-72h, sem outros déficits neurológicos.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Prednisolona solução oral 3 mg/mL ou comprimido	1 a 2 mg/kg/dia VO (máx 60 mg/dia) em dose única matinal por 7 a 10 dias (com desmame rápido nos últimos 3 dias).	60 mg/dia	Iniciar idealmente nas primeiras 72 horas para acelerar a recuperação completa e prevenir sincinesias.
Proteção Ocular: Colírio Lubrificante de Dia + Pomada Oftálmica à Noite	Colírio de lágrimas artificiais (Carmelose 0,5%): 1 a 2 gotas a cada 2-3 horas no olho afetado; Pomada de retinol ou pomada lubrificante ao dormir.	Livre	Oclusão ocular noturna com fita microporosa para prevenir ceratite de exposição e úlcera de córnea por lagoftalmo.

2ª Linha / Resgate: Aciclovir oral (20 mg/kg 4x/dia) associado apenas se suspeita de Síndrome de Ramsay Hunt (vesículas no pavilhão auricular/conduto e otalgia intensa associadas à paralisia facial).

Medidas Não Farmacológicas: • Oclusão ocular durante o sono e uso de óculos de sol durante o dia para proteção contra poeira e vento. • Fisioterapia e exercícios de mímica facial após a fase aguda inicial.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Paralisia facial central (poupa a fronte/movimento da sobrancelha preservado - investigar AVC ou lesão expansiva do SNC). ■■ Hipertensão arterial grave associada (investigar feocromocitoma ou coarctação de aorta). ■■ Lesão ulcerada na córnea por ressecamento.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação oftalmológica e pediátrica em 7 a 14 dias; recuperação completa ocorre em > 90% dos casos em semanas a meses.

MÓDULO 05: DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA E ALERGOLOGIA

Diagnóstico 058: Dermatite Atópica Leve (Cuidados de Barreira e Hidratação)

CID-10: L20.9 | Faixa Etária: Todas as idades (início comum no 1º ano)

Crítérios Clínicos: Xerose cutânea difusa, prurido crônico e lesões eczematosas típicas: lactentes (face, bochechas e superfícies extensoras poupando a área das fraldas); crianças maiores e adolescentes (dobras flexoras: fossas antecubitais e poplíteas, punhos e pescoço).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Emolientes / Hidratantes de Barreira sem Fragrância (Pilar Central)	Aplicar generosamente em todo o corpo 2 a 3 vezes ao dia (obrigatoriamente até 3 minutos após o banho com a pele ainda levemente úmida).	Livre	Preferir cremes espessos ou pomadas (com ceramidas, aveia coloidal, glicerina ou petrolato) em vez de loções aquosas finas.
Hidrocortisona 1% creme / pomada (Corticoide de Baixa Potência)	Aplicar camada fina sobre as placas ativas inflamadas 1 a 2 vezes ao dia por 5 a 7 dias nas crises.	Uso pontual	Seguro para aplicação em face, pescoço e dobras por curtos períodos.

2ª Linha / Resgate: Anti-histamínicos de 1ª geração (Hidroxizina 1 a 2 mg/kg/dia ou Dexclorfeniramina) em dose única noturna se prurido grave que prejudica o sono.

Medidas Não Farmacológicas: • Banhos curtos (5 a 10 minutos), com água morna (nunca quente) e sabonetes suaves sem sabão (syndet) aplicados apenas em axilas e genitais. • Roupas 100% algodão, folgadas; evitar lã, tecidos sintéticos e etiquetas irritantes. • Manter unhas curtas e lixadas para evitar escoriações.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Aparecimento de vesículas agrupadas umbilicadas com febre (Eczema Herpético / Erupção Variceliforme de Kaposi - emergência dermatológica). ■■ Sinais de impetiginização secundária (crostas melicéricas e supuração).

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento no retorno dermatológico/pediátrico a cada 1 a 3 meses.

Diagnóstico 059: Dermatite Atópica Moderada a Grave

CID-10: L20.9 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Eczema extenso, liquenificação acentuada, escoriações múltiplas, prurido intratável, distúrbio grave do sono e falha no controle com corticoides tópicos de baixa potência.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Corticoides Tópicos de Média a Alta Potência (Mometasona 0,1% ou Desonida 0,05%)	Desonida 0,05% (face/dobras) ou Mometasona 0,1% (corpo/membros): aplicar 1x/dia nas lesões ativas por 7 a 14 dias com transição para terapia proativa de fim de semana (2x/semana).	Uso tópico controlado	Evitar corticoides de alta potência em face, pálpebras e genitália para prevenir atrofia cutânea e estrias.
Inibidores Tópicos da Calcineurina: Pimecrolimo 1% creme ou Tacrolimo 0,03%/0,1% pomada	Aplicar camada fina 2 vezes ao dia nas lesões em face, pescoço e áreas sensíveis (em crianças >= 2 anos).	2x/dia	Excelente opção poupadora de corticoide; pode causar ardência transitória nos primeiros dias de aplicação.

2ª Linha / Resgate: Terapia biológica com Dupilumabe (anticorpo anti-IL-4/IL-13) para dermatite atópica grave refratária a partir de 6 meses de idade; Imunossupressores sistêmicos (Ciclosporina ou Metotrexato) sob supervisão especializada.

Medidas Não Farmacológicas: • Técnica de enfaixamento úmido (Wet wrap therapy) para controle rápido de crises agudas graves sob orientação médica. • Controle rigoroso de alérgenos ambientais e hidratação contínua.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Eczema herpético disseminado (iniciar Aciclovir IV imediatamente). ■■ Eritrodermia esfoliativa generalizada (> 90% da superfície corporal) com perda de calor e desidratação.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento conjunto com alergista / dermatopediatra.

Diagnóstico 060: Dermatite de Contato (Irritativa e Alérgica)

CID-10: L24.9 / L23.9 | Faixa Etária: Todas as idades

Crítérios Clínicos: Irritativa: lesões eritematosas, descamativas e dolorosas restritas exatamente à área de contato com o agente agressor (saliva, urina, produtos químicos); Alérgica: reação de hipersensibilidade tipo IV com placas eczematosas pruriginosas e vesículas que ultrapassam as bordas do contato (níquel de botões/brincos, borracha, esmaltes, plantas/hera venenosa).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Desonida 0,05% ou Hidrocortisona 1% creme/pomada	Aplicar camada fina sobre as lesões 1 a 2 vezes ao dia por 5 a 10 dias.	2x/dia	Suspender assim que houver remissão das lesões ativas.
Hidratante Reparador de Barreira (com Óxido de Zinco, Pantenol ou Ceramidas)	Aplicar após a regressão da fase aguda para restaurar a integridade cutânea.	Livre	Usar produtos hipoalergênicos sem perfume.

2ª Linha / Resgate: Prednisolona oral (1 mg/kg/dia por 3 a 5 dias) em dermatite de contato alérgica extensa grave (ex: fitofotodermatose ou reação a plantas).

Medidas Não Farmacológicas: • Identificação e AFASTAMENTO RIGOROSO e definitivo da substância irritante ou sensibilizante causadora. • Lavagem imediata com água fria e sabão neutro após contato acidental suspeito. • Compressas frias com SF 0,9% nas lesões exsudativas agudas.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Sinais de infecção bacteriana secundária com pústulas e crostas amareladas. ■■ Acometimento de face e pálpebras com edema intenso.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação em 7 a 10 dias para confirmação da melhora após afastamento do agente.

Diagnóstico 061: Dermatite Seborreica do Lactente / Crosta Láctea

CID-10: L21.0 | Faixa Etária: Primeiros 3 meses de vida (até 6 a 12 meses)

Crítérios Clínicos: Escamas untuosas, gordurosas, amareladas e aderentes em couro cabeludo ('crosta láctea'), sobrancelhas, fronte e dobras retroauriculares e flexoras, sem prurido significativo e com lactente assintomático e em ótimo estado geral.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Óleo Mineral ou Óleo Vegetal Suave (Amêndoas doces / Girassol)	Aplicar no couro cabeludo 15 a 30 minutos antes do banho para amolecer as crostas, seguido de lavagem suave com xampu neutro infantil e escovação com escova de cerdas macias.	Livre	NUNCA forçar a remoção das crostas secas com as unhas ou pentes duros pelo risco de escoriação e infecção secundária.
Cetoconazol 2% xampu ou creme (se lesões inflamatórias exuberantes)	Xampu: 2 a 3 vezes por semana no couro cabeludo; Creme: aplicar camada fina nas dobras 1x/dia por 5 a 7 dias.	Uso tópico	Atua sobre a proliferação excessiva de Malassezia spp.

2ª Linha / Resgate: Hidrocortisona 1% creme em camada ultrafina por 3 a 5 dias se eritema importante nas dobras.

Medidas Não Farmacológicas: • Tranquilização dos cuidadores: condição fisiológica benigna, autolimitada e não decorrente de falta de higiene. • Manter as dobras do bebê sempre limpas e secas.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Eritrodermia esfoliativa generalizada com diarreia e déficit ponderal (Doença de Leiner). ■■ Sangramento ou exsudato purulento nas lesões.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento nas consultas de puericultura.

Diagnóstico 062: Dermatite das Fraldas Irritativa Simples

CID-10: L22 | Faixa Etária: Lactentes (fase de uso de fraldas)

Crítérios Clínicos: Eritema brilhante confluyente em áreas convexas em contato direto com a fralda (nádegas, coxas, monte pubiano e abdome inferior), com POUPAMENTO NÍTIDO DAS DOBRAS E PREGAS CUTÂNEAS.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Pomada de Barreira com Óxido de Zinco 10% a 40% + Dexpanthenol ou Petrolato	Aplicar uma camada espessa e generosa em TODAS as trocas de fralda.	Livre	Na troca, remover apenas o excesso de fezes; não esfregar a pomada residual aderida à pele para evitar trauma mecânico repetido.
Hidrocortisona 1% pomada (se inflamação/eritema intenso)	Aplicar camada fina 2 vezes ao dia por no máximo 2 a 3 dias.	2x/dia	Uso estritamente pontual; nunca utilizar corticoides de média/alta potência sob oclusão da fralda.

2ª Linha / Resgate: Se não houver melhora clínica em 48-72h, suspeitar fortemente de colonização secundária por Candida albicans.

Medidas Não Farmacológicas: • Trocas frequentes de fraldas (assim que a criança urinar ou evacuar). • Limpeza suave com água morna e algodão; suspender completamente lenços umedecidos industriais durante as crises. • Deixar a criança sem fraldas (arejamento livre da pele) o maior tempo possível ao longo do dia.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Surgimento de pápulas e pústulas satélites e invasão das dobras (candidíase). ■■ Ulcerações profundas ou necrose.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação em 3 a 5 dias se ausência de cicatrização.

Diagnóstico 063: Dermatite das Fraldas com Candidíase Secundária

CID-10: B37.2 | Faixa Etária: Lactentes em uso de fraldas (frequente pós-antibioticoterapia)

Crítérios Clínicos: Eritema vermelho-vivo intenso e brilhante QUE ACOMETE O FUNDO DAS PREGAS E DOBRAS CUTÂNEAS INGUINAIS, associado a PÁPULAS E PÚSTULAS ERITEMATOSAS SATÉLITES características na periferia.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Nistatina 100.000 UI/g + Óxido de Zinco 200 mg/g pomada	Aplicar camada generosa na área afetada e nas dobras a cada troca de fralda (4 a 6 vezes ao dia) por 7 a 14 dias (manter por até 48h após o desaparecimento das lesões).	Livre	Associa a ação antifúngica da nistatina com a barreira protetora do óxido de zinco.
Miconazol 2% ou Clotrimazol 1% creme/pomada	Aplicar camada fina 2 a 3 vezes ao dia sobre as lesões por 10 a 14 dias.	3x/dia	Excelente alternativa antifúngica tópica.

2ª Linha / Resgate: Nistatina suspensão oral (100.000 UI 4x/dia) associada se houver 'sapinho' (candidíase oral) concomitante para erradicar o reservatório gastrointestinal.

Medidas Não Farmacológicas: • Manter a região perianal limpa e extremamente seca. • Trocas rigorosas de fraldas e exposição ao ar ambiente. • Higiene das mãos dos cuidadores antes e após as trocas.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Extensão das lesões para tronco e membros em lactente imunodeprimido. ■■ Infecção bacteriana mista com secreção purulenta.

Retorno / Reavaliação: Retorno se persistência dos sinais após 7 dias de antifúngico tópico.

Diagnóstico 064: Urticária Aguda e Angioedema Não Anafilático

CID-10: L50.0 / T78.3 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Placas eritematosas, edematosas, elevadas, com halo hiperêmico e centro pálido, intensamente pruriginosas e fugazes (cada lesão individual dura < 24 horas, desaparecendo sem deixar marcas e surgindo em novos locais), com ou sem angioedema subcutâneo (edema de lábios e pálpebras), SEM comprometimento respiratório, gastrointestinal ou hemodinâmico.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Anti-histamínico de 2ª Geração Não Sedativo (Primeira Escolha)	Desloratadina solução oral 0,5 mg/mL: 6 a 11 meses: 1 mg (2 mL) 1x/dia; 1 a 5 anos: 1,25 mg (2,5 mL) 1x/dia; 6 a 11 anos: 2,5 mg (5 mL) 1x/dia; >= 12 anos: 5 mg 1x/dia por 5 a 10 dias; OU Cetirizina 1x/dia.	Desloratadina 5 mg/dia; Cetirizina 10 mg/dia	Maior segurança, eficácia prolongada de 24h e ausência de efeitos sedativos/anticolinérgicos importantes.
Anti-histamínico de 1ª Geração (se prurido noturno intratável)	Hidroxizina 1 a 2 mg/kg/dia VO dividido a cada 8h ou dose única noturna.	50 mg/dia	Causa sonolência.

2ª Linha / Resgate: Prednisolona oral (1 mg/kg/dia por 3 a 5 dias) reservada estritamente para urticárias agudas refratárias graves ou angioedema facial exuberante.

Medidas Não Farmacológicas: • Banhos mornos ou frios e aplicação de compressas frias para alívio do prurido. • Identificação e suspensão de medicamentos deflagradores (AINES, antibióticos) ou alérgenos alimentares suspeitos. • Evitar calor excessivo e roupas apertadas.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Dificuldade para respirar, tosse súbita, rouquidão, estridor ou chiado no peito. ■■ Vômitos repetidos, dor abdominal intensa ou diarreia. ■■ Tontura, palidez súbita, desmaio ou sensação de morte iminente (SINAIS DE ANAFILAXIA - REQUEREM ADRENALINA IM IMEDIATA).

Retorno / Reavaliação: Retorno se persistência dos sintomas após 10 dias ou sinais de anafilaxia.

Diagnóstico 065: Anafilaxia Pediátrica e Choque Anafilático

CID-10: T78.2 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Reação de hipersensibilidade sistêmica aguda, rápida e potencialmente fatal, com acometimento de >= 2 sistemas (Pele/mucosas: urticária, angioedema; Respiratório: estridor, broncoespasmo, hipóxia; Cardiovascular: hipotensão, choque; Gastrointestinal: vômitos em jato, cólicas intensas) OU hipotensão súbita após exposição a alérgeno conhecido.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
ADRENALINA (EPINEFRINA) 1 mg/mL (1:1000) INTRAMUSCULAR IMEDIATA	0,01 mg/kg (0,01 mL/kg da solução pura 1:1000) IM aplicada no VASTO LATERAL DA COXA (face anterolateral). Dose máxima: 0,3 mg (crianças) ou 0,5 mg (adolescentes). Pode ser repetida a cada 5 a 15 minutos se resposta insuficiente.	0,3 mg (< 12 anos) ou 0,5 mg (adolescentes)	FÁRMACO SALVADOR DE VIDAS DE PRIMEIRA LINHA ABSOLUTA. NUNCA atrasar a adrenalina para administrar anti-histamínicos ou corticoides. A via intramuscular na coxa garante pico plasmático em menos de 8 minutos (muito superior à via deltoidea ou subcutânea).
Expansão Volêmica Imediata com Solução Fisiológica 0,9% IV/IO (se Choque)	Bolus de 20 mL/kg IV/IO em 5 a 10 minutos (repetir se PA não normalizar).	Conforme metas	Trata a vasodilatação e extravasamento capilar maciço.

2ª Linha / Resgate: Segunda Linha (Adjuvantes pós-adrenalina): Salbutamol inalatório para broncoespasmo; Metilprednisolona (1 a 2 mg/kg IV) ou Hidrocortisona (5 a 10 mg/kg IV) para prevenir reação bifásica tardia; Anti-histamínico IV (Difenidramina 1 mg/kg IV ou Dipirona) para controle de sintomas cutâneos.

Medidas Não Farmacológicas: • Posicionamento em decúbito dorsal com elevação de membros inferiores (posição de Trendelenburg); se dispneia preponderante, manter semi-sentado; NUNCA colocar o paciente de pé subitamente (risco de colapso circulatório por esvaziamento da veia cava). • Oxigênio a 100% sob máscara com reservatório. • Remoção do alérgeno (ex: interromper infusão venosa de medicamento).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Emergência médica absoluta.

Retorno / Reavaliação: Internação e monitorização contínua por no mínimo 6 a 24 horas pelo risco de Reação Anafilática Bifásica (recorrência dos sintomas sem nova exposição).

Diagnóstico 066: Impetigo Crostoso e Bolhoso (S. aureus e S. pyogenes)

CID-10: L01.0 / L01.1 | Faixa Etária: 2 a 6 anos (frequente em climas quentes/úmidos)

Crítérios Clínicos: Crostoso: pequenas pápulas/vesículas que se rompem rapidamente formando crostas espessas aderentes de cor amarelada ('crostas melicéricas / cor de mel') em face (perioral e nasal) e extremidades; Bolhoso: bolhas flácidas de conteúdo claro a turvo que se rompem deixando colarete descamativo (S. aureus produtor de toxina esfoliativa).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Lesões Localizadas/Poucas: Mupirocina 2% pomada tópica	Aplicar camada fina sobre as lesões 3 vezes ao dia por 5 a 7 dias.	3x/dia	Primeira escolha para lesões localizadas; amolecer e remover gentilmente as crostas com água morna antes da aplicação.
Lesões Múltiplas/Extensas (> 5 lesões ou ectima): Cefalexina oral	50 a 100 mg/kg/dia VO dividido a cada 6 horas por 7 dias.	2 g/dia	Tratamento sistêmico obrigatório se lesões disseminadas ou peri-orificiais múltiplas.

2ª Linha / Resgate: Amoxicilina + Clavulanato (50 mg/kg/dia) ou Clindamicina (30 mg/kg/dia) se falha ou suspeita de MRSA comunitário.

Medidas Não Farmacológicas: • Lavagem diária das lesões com água e sabonete antisséptico neutro. • Manter unhas cortadas e limpas. • Não compartilhar toalhas, roupas de cama e vestuário durante o tratamento ativo. • Afastamento escolar por 24-48h após início do antibiótico.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Extensão rápida para celulite com calor, dor intensa e edema perilesional. ■■ Febre alta e toxemia. ■■ Urina escura e edema palpebral após 2-3 semanas (rastrear GNDA pós-estreptocócica).

Retorno / Reavaliação: Reavaliação em 48 a 72 horas para confirmar cicatrização.

Diagnóstico 067: Celulite e Erisipela Pediátrica

CID-10: L03.9 / A46 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Erisipela: infecção dermo-epidérmica superficial com placa eritematosa vermelho-vivo, bordas nítidas e bem delimitadas, dolorosa, edemaciada e quente (S. pyogenes); Celulite: infecção do tecido subcutâneo profundo com placa eritematosa de bordas imprecisas/indistintas, calor, dor e edema (S. aureus e Streptococcus).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Formas Leves / Ambulatoriais: Cefalexina suspensão oral 250 mg/5 mL ou 500 mg	50 a 100 mg/kg/dia VO dividido a cada 6 horas por 7 a 10 dias.	2 g a 4 g/dia	Demarcar com caneta a borda do eritema para acompanhar a progressão ou regressão diária.
Formas Moderadas a Graves / Hospitalares: Oxacilina sódica frasco-ampola IV ou Cefazolina IV	Oxacilina: 100 a 150 mg/kg/dia IV a cada 6h; OU Cefazolina: 50 a 100 mg/kg/dia IV a cada 8h por 7 a 10 dias.	Oxacilina 12 g/dia; Cefazolina 6 g/dia	Primeira escolha para infecções com febre alta, toxemia, face ou lactentes < 1 ano.

2ª Linha / Resgate: Clindamicina (30 a 40 mg/kg/dia IV/VO a cada 6h) ou Vancomicina (40-60 mg/kg/dia IV) se suspeita de CA-MRSA ou alergia a penicilinas.

Medidas Não Farmacológicas: • Elevação do membro afetado para reduzir o edema e facilitar a drenagem linfática. • Compressas frias locais para alívio da dor. • Tratamento de portas de entrada (micoses interdigitais, picadas de inseto, escoriações).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Dor desproporcional, bolhas hemorrágicas, anestesia cutânea ou crepitação (suspeita de fascíte necrotizante). ■■ Acometimento facial ou periorbitário. ■■ Choque séptico.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação clínica mandatória em 24 a 48 horas.

Diagnóstico 068: Folliculite, Furunculose e Abscessos Cutâneos

CID-10: L73.9 / L02.9 | Faixa Etária: Crianças e adolescentes

Critérios Clínicos: Folliculite: pústulas folliculares superficiais; Furúnculo/Antraz: nódulo inflamatório profundo, eritematoso, doloroso centrado por folículo piloso com necrose central ('carnegão'); Abscesso: coleção flutuante purulenta dérmica e subcutânea com eritema e dor local (S. aureus).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Incisão e Drenagem Cirúrgica (Tratamento Principal do Abscesso Flutuante)	Incisão simples, evacuação completa do pus, quebra de septos e drenagem.	Procedimento mecânico	Abscessos não complicados < 5 cm em crianças saudáveis são curados APENAS com incisão e drenagem adequada, SEM necessidade de antibióticos sistêmicos.
Cefalexina oral (se celulite perilesional extensa, febre ou face)	50 a 75 mg/kg/dia VO dividido a cada 6 horas por 7 dias.	2 g/dia	Indicado se sinais sistêmicos, imunodepressão, lesões em face ou múltiplos furúnculos.

2ª Linha / Resgate: Sulfametoxazol + Trimetoprima (40 mg/kg/dia de SMX a cada 12h) ou Clindamicina se prevalência de MRSA comunitário ou furunculose recorrente.

Medidas Não Farmacológicas: • Compressas mornas locais por 15-20 min 3x/dia para acelerar a drenagem espontânea em furúnculos não flutuantes. • Descolonização de S. aureus com sabonete de clorexidina e mupirocina nasal por 5 dias em casos de furunculose de repetição na família.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Furúnculo em triângulo da face (asa nasal e lábio superior - risco de trombose do seio cavernoso). ■■ Flutuação não drenada com dor severa e febre.

Retorno / Reavaliação: Retorno em 48 horas para troca de curativo e avaliação da cavidade.

Diagnóstico 069: Escabiose Pediátrica (Sarna Humana - Sarcoptes scabiei)

CID-10: B86 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Prurido noturno intenso e intratável associado a pápulas eritematosas, escoriações, túneis serpiginosos e vesículas. Topografia clássica: espaços interdigitais das mãos, punhos, axilas, auréolas, umbigo, genitália e nádegas. Em lactentes < 2 anos: acomete tipicamente couro cabeludo, face, palmas e plantas.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Permetrina 5% loção / creme (Tratamento Tópico de Primeira Escolha)	Aplicar no corpo todo à noite, do pescoço aos pés (EM LACTENTES: INCLUIR COURO CABELUDO E FACE, poupando olhos e boca). Deixar agir por 8 a 14 horas e enxaguar no banho matinal. REPETIR OBRIGATORIAMENTE APÓS 7 A 10 DIAS.	Livre	O retratamento após 7-10 dias é mandatório para eliminar as larvas recém-eclodidas dos ovos resistentes à primeira aplicação. TRATAR SIMULTANEAMENTE TODOS OS CONTATOS DOMICILIARES E CUIDADORES, MESMO ASSINTOMÁTICOS.
Ivermectina gotas ou comprimido 6 mg (em crianças >= 15 kg ou > 2-5 anos)	200 mcg/kg (0,2 mg/kg) VO em dose única. REPETIR APÓS 7 A 14 DIAS.	12 a 15 mg/dose	Excelente opção para escabiose crostosa (norueguesa), surtos institucionais ou falha do tratamento tópico.

2ª Linha / Resgate: Enxofre precipitado 5% a 10% em vaselina para recém-nascidos e lactentes < 2 meses (quando permetrina 5% não for permitida). Anti-histamínicos orais para prurido pós-escabiotico residual.

Medidas Não Farmacológicas: • Lavar roupas de uso pessoal, toalhas e roupas de cama em água quente (ou secar em secadora quente / passar a ferro quente). Roupas não laváveis devem ser isoladas em sacos plásticos vedados por 72 horas (o ácaro não sobrevive fora do hospedeiro humano por > 3 dias). • Manter unhas curtas para evitar impetiginização secundária.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Infecção bacteriana secundária grave (impetiginização maciça com celulite). ■■ Persistência de lesões novas após 2 semanas da segunda aplicação (falha terapêutica ou reinfestação por contato não tratado).

Retorno / Reavaliação: Reavaliação clínica 14 dias após o segundo ciclo.

Diagnóstico 070: Pediculose do Couro Cabeludo (Piolho - Pediculus humanus capitis)

CID-10: B85.0 | Faixa Etária: Escolares e pré-escolares

Critérios Clínicos: Prurido intenso no couro cabeludo (com predileção pelas regiões occipital e retroauricular), escoriações por coçadura e visualização direta de lêndeas esbranquiçadas fortemente aderidas à haste capilar ou piolhos vivos.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Permetrina 1% loção capilar (com condicionador/veículo apropriado)	Lavar os cabelos com xampu neutro comum (sem condicionador), secar com toalha, aplicar a loção de permetrina 1% em todo o couro cabeludo e fios úmidos, deixar agir por 10 minutos e enxaguar com água. REPETIR OBRIGATORIAMENTE APÓS 7 A 10 DIAS.	Livre	A segunda aplicação é indispensável para matar as ninfas que eclodiram das lêndeas remanescentes.
Pente Fino Metálico (Instrumento Mecânico Fundamental)	Passar pente fino nos cabelos úmidos mecha por mecha a cada 2 a 3 dias por 2 semanas.	Mecânico	A remoção mecânica associada ao vinagre diluído (1 parte de vinagre para 1 parte de água para dissolver a quitina de fixação) maximiza o sucesso terapêutico.

2ª Linha / Resgate: Ivermectina oral (200 mcg/kg VO dose única, repetir em 7-10 dias) em crianças >= 15 kg com pediculose resistente ou refratária.

Medidas Não Farmacológicas: • Não compartilhar escovas, pentes, bonés, capacetes ou elásticos de cabelo. • Lavar roupas de cama e toalhas em água quente. • Exame da cabeça de todos os contactantes próximos da família e da escola.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Linfadenopatia occipital com sinais inflamatórios supurativos. ■■ Impetiginização bacteriana secundária do couro cabeludo.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação em 7 a 10 dias no momento do retratamento.

Diagnóstico 071: Molusco Contagioso Pediátrico (Poxvírus)

CID-10: B08.1 | Faixa Etária: 1 a 10 anos

Critérios Clínicos: Pápulas firmes, hemisféricas, de aspecto perolado ou cor da pele, indolores, com típica UMBILICAÇÃO CENTRAL, medindo de 1 a 5 mm de diâmetro, distribuídas em tronco, axilas, fossa poplíteia ou virilha.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Conduta Expectante / Não Intervencionista (Primeira Opção)	Acompanhamento clínico e proteção da pele com emolientes.	N/A	Infecção viral benigna e autolimitada; na grande maioria dos imunocompetentes, as lesões regredem espontaneamente em 6 a 18 meses sem deixar cicatrizes.
Hidróxido de Potássio (KOH) 5% a 10% solução tópica (se tratamento ativo desejado)	Aplicar pontualmente com cotonete sobre cada pápula 1x/dia à noite até surgimento de eritema/inflamação (geralmente 3 a 7 dias), momento em que deve ser suspenso.	Uso pontual	Protege a pele sã perilesional com vaselina para evitar irritação química.

2ª Linha / Resgate: Curetagem física sob anestesia tópica (EMLA creme) ou Crioterapia com nitrogênio líquido em ambiente dermatológico especializado.

Medidas Não Farmacológicas: • Evitar coçar, espremer ou manipular as lesões para prevenir autoinoculação e disseminação. • Não compartilhar toalhas de banho. • Banhos rápidos e hidratação da pele circundante para controlar eczema perimolusco.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Infecção bacteriana secundária com supuração perilesional. ■■ Lesões gigantes (> 1 cm) ou disseminação maciça (> 100 lesões), sugerindo imunodeficiência celular subjacente.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento a cada 3 a 6 meses para monitorar regressão natural.

Diagnóstico 072: Queimaduras Térmicas Ambulatoriais (1º Grau e 2º Grau Superficial < 10% SCQ)

CID-10: T30.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: 1º Grau: eritema, calor e dor intensa sem bolhas (flicker); 2º Grau superficial: eritema intenso com formação de flictenas (bolhas) de conteúdo citrino e dor severa, acometendo < 10% da Superfície Corporal Queimada (SCQ), sem atingir áreas nobres (face, mãos, pés, genitália, grandes articulações).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Resfriamento Imediato com Água Corrente em Temperatura Ambiente	Irrigação contínua por 10 a 20 minutos imediatamente após o acidente térmico.	20 minutos	Interrompe a progressão do dano térmico tecidual e alivia a dor. NUNCA USAR GELO ou água gelada (risco de aprofundamento da lesão por vasoconstricção e hipotermia em crianças).
Sulfadiazina de Prata 1% creme ou Pomada com Dexpantenol/Hidrogel	Aplicar camada fina sobre a área queimada e cobrir com gaze não aderente estéril e faixa 1 vez ao dia.	1x/dia	Sulfadiazina de prata é contraindicada em neonatos e lactentes < 2 meses pelo risco de kernicterus (sulfonamida).
Analgesia Sistêmica Regular (Dipirona + Paracetamol ou Ibuprofeno)	Dipirona 15-25 mg/kg VO a cada 6h de horário fixo nos primeiros 2 a 3 dias.	Dose padrão	Fundamental para permitir trocas de curativo confortáveis.

2ª Linha / Resgate: Curativos biológicos modernos / coberturas de silicone e prata nanocristalina com trocas espaçadas a cada 3 a 7 dias.

Medidas Não Farmacológicas: • NUNCA romper intencionalmente bolhas intactas estéreis (a epiderme descolada é o melhor curativo biológico natural). • NUNCA aplicar substâncias caseiras (pasta de dente, manteiga, pó de café, clara de ovo). • Profilaxia antitetânica conforme cartão vacinal.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Queimadura em áreas especiais (face, pescoço, mãos, pés, períneo/genitália ou queimaduras circunferenciais de membros). ■■ Queimaduras de 2º grau > 10% SCQ ou qualquer queimadura de 3º grau (indicação de internação em Centro de Tratamento de Queimados - CTQ). ■■ Suspeita de inalação de fumaça (fuligem nasal, queimadura de cílios/vibrissas, estridor).

Retorno / Reavaliação: Revisão ambulatorial do curativo a cada 48 a 72 horas até reepitelização completa.

MÓDULO 06: NEFROLOGIA E UROLOGIA PEDIÁTRICA

Diagnóstico 073: Infecção do Trato Urinário Baixa / Cistite Aguda

CID-10: N30.0 | Faixa Etária: Pré-escolares, escolares e adolescentes

Critérios Clínicos: Disúria, polaciúria, urgência miccional, dor suprapúbica, enurese secundária e urina turva com odor fétido, na AUSÊNCIA de febre alta ou dor lombar/toxemia. EAS com leucocitúria significativa, bacteriúria e nitrito positivo.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Cefalexina suspensão oral 250 mg/5 mL ou comprimido 500 mg	50 a 100 mg/kg/dia VO dividido a cada 6 horas por 5 a 7 dias.	2 g/dia	Excelente opção de primeira escolha para tratamento empírico ambulatorial de cistite comunitária.
Nitrofurantoína suspensão 25 mg/5 mL ou cápsula 100 mg (em > 1 mês de idade)	5 a 7 mg/kg/dia VO dividido a cada 6 horas com alimentos por 7 dias.	400 mg/dia	Atinge altas concentrações urinárias; CONTRAINDICADA se suspeita de pielonefrite ou ClCr < 30 mL/min.

2ª Linha / Resgate: Sulfametoxazol + Trimetoprima (40 mg/kg/dia de SMX a cada 12h) ou Amoxicilina + Clavulanato (50 mg/kg/dia a cada 8h) ajustados conforme urocultura e antibiograma.

Medidas Não Farmacológicas: • Ingestão hídrica abundante para lavagem mecânica do trato urinário. • Esvaziamento vesical completo em intervalos regulares (evitar retenção voluntária). • Higiene perineal adequada da frente para trás nas meninas.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Surgimento de febre alta (>= 38,5°C), calafrios ou vômitos (progressão para pielonefrite). ■■ Hematúria macroscópica persistente ou dor lombar.

Retorno / Reavaliação: Urocultura de controle apenas se persistência de sintomas após 48-72h de antibiótico.

Diagnóstico 074: Pielonefrite Aguda Pediátrica

CID-10: N10 | Faixa Etária: Lactentes, pré-escolares e escolares

Crítérios Clínicos: Febre alta (>= 38,5°C), calafrios, toxemia, vômitos, prostração, dor lombar / punho-percussão dolorosa positiva (Sinal de Giordano) e, em lactentes jovens, febre sem foco com irritabilidade e recusa alimentar.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Tratamento Ambulatorial / Oral (em crianças > 3-6 meses em bom estado geral): Cefuroxima axetil ou Ciprofloxacino	Cefuroxima axetil: 30 mg/kg/dia VO a cada 12h por 10 a 14 dias; OU Amoxicilina + Clavulanato: 80 a 90 mg/kg/dia a cada 12h por 10 a 14 dias.	Cefuroxima 1 g/dia; Amoxicilina 2 g/dia	Garantir tolerância à via oral e seguimento ambulatorial confiável.
Tratamento Hospitalar / Parenteral (Lactentes < 3 meses, vômitos, toxemia ou desidratação): Ceftriaxona sódica IV	80 a 100 mg/kg/dia IV em dose única diária por 10 a 14 dias (pode transicionar para via oral após 48h afebril).	2 g a 4 g/dia	Primeira linha parenteral; em neonatos < 28 dias preferir Ampicilina + Cefotaxima ou Gentamicina.

2ª Linha / Resgate: Amicacina (15 mg/kg/dia IV dose única diária) ou Ciprofloxacino IV em infecções complicadas por enterobactérias produtoras de ESBL.

Medidas Não Farmacológicas: • Ultrassonografia de rins e vias urinárias obrigatória no primeiro episódio febril de ITU para rastreamento de malformações urológicas. • Hidratação venosa ou oral vigorosa.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Persistência de febre alta após 48 a 72 horas de antibioticoterapia adequada (suspeita de abscesso renal/perirrenal ou obstrução urinária). ■■ Sepses com instabilidade hemodinâmica.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação clínica diária nas primeiras 72 horas; investigação com Ulectocistografia Miccional (UCM) e Cintilografia Renal DMSA conforme protocolos da SBP se alterações no USG ou infecção de repetição.

Diagnóstico 075: Glomerulonefrite Difusa Aguda Pós-Estreptocócica (GNDA / Síndrome Nefrítica)

CID-10: N00.9 | Faixa Etária: 5 a 12 anos (rara em < 2 anos)

Crítérios Clínicos: Tríade clássica nefrítica: 1) Hematúria glomerular (urina cor de 'coca-cola' ou chá escuro com dismorfismo eritrocitário e cilindros hemáticos); 2) Edema agudo facial/periorbitário matutino; 3) Hipertensão arterial sistêmica, surgindo 1 a 3 semanas após faringoamigdalite ou 2 a 6 semanas após piodermite estreptocócica. Queda transitória de C3 sérico e ASLO/Anti-DNAse B elevados.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Furosemida solução oral ou injetável IV (Controle da Hipervolemia e Hipertensão)	1 a 2 mg/kg/dose IV ou VO a cada 6 a 12 horas.	4 mg/kg/dia (máx 80-120 mg/dia)	Pilar central farmacológico; promove natriurese rápida, alivia a congestão circulatória e reduz a pressão arterial.
Erradicação do Estreptococo (se infecção ainda ativa ou comunicantes): Benzilpenicilina Benzatina IM	< 27 kg: 600.000 UI IM; >= 27 kg: 1.200.000 UI IM dose única.	1.200.000 UI	Não altera o curso da nefropatia já instalada, mas interrompe a cadeia de transmissão comunitária da cepa nefritogênica.

2ª Linha / Resgate: Anti-hipertensivos vasodilatadores: Hidralazina (0,5 a 2 mg/kg/dia a cada 6-8h) ou Amlodipino (0,1 a 0,3 mg/kg/dia) se hipertensão refratária à furosemida. Evitar IECA/BRA na fase aguda pelo risco de hipercalemia.

Medidas Não Farmacológicas: • Restrição hídrica rigorosa (Balanço Hídrico: Perdas insensíveis 400 mL/m²/dia + volume de diurese do dia anterior). • Dieta hipossódica estrita (sem sal de adição). • Repouso no leito durante a fase de hipertensão e edema ativo. • Pesagem diária em jejum e controle rigoroso da PA a cada 4 horas.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Encefalopatia Hipertensiva (cefaleia intensa, vômitos, turvação visual/amaurose, convulsões e coma). ■■ Edema Agudo de Pulmão com congestão venocapilar e dispneia grave. ■■ Injúria renal aguda anúrica com hipercalemia refratária.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento semanal até resolução da hipertensão e do edema; normalização do C3 ocorre em 6 a 8 semanas; micro-hematúria residual pode persistir por até 1 a 2 anos.

Diagnóstico 076: Síndrome Nefrótica Idiopática (Lesão Renal Mínima)

CID-10: N04.0 | Faixa Etária: 2 a 8 anos (pico 3 a 5 anos)

Critérios Clínicos: Tétrade nefrótica: 1) Proteinúria maciça (> 50 mg/kg/dia ou relação proteína/creatinina urinária > 2,0 mg/mg); 2) Hipoalbuminemia grave (< 2,5 g/dL); 3) Edema generalizado anasarca (periorbitário, escrotal/vulvar, ascite e membros inferiores); 4) Hipercolesterolemia / dislipidemia.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Prednisona ou Prednisolona oral (Protocolo Padrão SBP/KDIGO)	Fase de Indução: 60 mg/m²/dia (ou 2 mg/kg/dia) VO em dose única matinal (máx 60 mg/dia) por 4 a 6 semanas consecutivas. Fase de Manutenção: 40 mg/m² (ou 1,5 mg/kg) em dias alternados pela manhã por mais 4 a 6 semanas com desmame gradual.	60 mg/dia	Cerca de 85-90% das crianças são cortico-responsivas (remissão da proteinúria em 2 a 4 semanas). Associar suplementação de Cálcio + Vitamina D e profilaxia antiparasitária prévia com Ivermectina/Albendazol.
Furosemida associada a Espironolactona (para edema sintomático)	Furosemida: 1 a 2 mg/kg/dia + Espironolactona: 1 a 2 mg/kg/dia VO.	Furosemida 4 mg/kg/dia	Usar com extrema cautela para não precipitar choque hipovolêmico por depleção intravascular.

2ª Linha / Resgate: Albumina Humana a 20% (0,5 a 1 g/kg IV em 2 a 4h) seguida de Furosemida IV (1 a 2 mg/kg) reservada estritamente para hipovolemia sintomática (hipotensão, má perfusão, dor abdominal) ou anasarca refratária com desconforto respiratório.

Medidas Não Farmacológicas: • Dieta normoproteica e hipossódica estrita durante a fase de edema ativo. • Pesagem diária matinal e controle de fita reagente de proteinúria na primeira urina da manhã em domicílio.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE) por *S. pneumoniae* (dor abdominal difusa, desconcompressão dolorosa, febre alta). ■■ Eventos Tromboembólicos (dor em membros, dispneia súbita, cefaleia intensa - hipercoagulabilidade por perda urinária de antitrombina III). ■■ Choque hipovolêmico por hipoalbuminemia severa.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento semanal na indução e mensal após remissão com nefropediatra.

Diagnóstico 077: Injúria Renal Aguda (IRA) Pré-Renal e Distúrbios Eletrolíticos

CID-10: N17.9 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Queda abrupta da taxa de filtração glomerular com elevação de creatinina sérica (critérios pRIFLE / KDIGO) e oligúria (< 0,5 mL/kg/h por > 6-12 horas) secundária à hipovolemia, desidratação grave, sepse ou perdas hemorrágicas. Fração de Excreção de Sódio (FeNa) < 1% e densidade urinária > 1.020.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Prova de Volume com Cristaloides Balanceados ou SF 0,9% IV	10 a 20 mL/kg IV infundidos em 30 a 60 minutos sob monitorização hemodinâmica.	Até 40-60 mL/kg se hipovolemia	Na IRA pré-renal verdadeira, a restauração da volemia promove aumento rápido do débito urinário e queda da creatinina em 24-48h. Suspender se ausência de resposta e sinais de sobrecarga.

2ª Linha / Resgate: Furosemida em teste funcional (1 a 2 mg/kg IV) apenas APÓS correção volêmica comprovada em pacientes que permanecem anúricos/oligúricos com hipervolemia; Terapia de Substituição Renal (Diálise Peritoneal ou Hemodiálise) se hipercalemia refratária, acidose grave, hipervolemia refratária ou uremia sintomática.

Medidas Não Farmacológicas: • Sondagem vesical para medida horária precisa da diurese. • Ajuste obrigatório de doses de TODOS os medicamentos de excreção renal. • Suspensão imediata de fármacos nefrotóxicos (AINes, aminoglicosídeos, anfotericina, contrastes iodados).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Hipercalemia grave (K+ > 6,5 mEq/L) com arritmias no ECG (ondas T apiculadas, alargamento de QRS). ■■ Edema agudo de pulmão hipervolêmico e anúria persistente.

Retorno / Reavaliação: Dosagem seriada de ureia, creatinina, gasometria e eletrólitos a cada 6 a 12 horas em ambiente de terapia intensiva.

Diagnóstico 078: Balanopostite Aguda Pediátrica

CID-10: N48.1 | Faixa Etária: Meninos de 1 a 6 anos

Crítérios Clínicos: Inflamação e infecção aguda da glândula e prepúcio, com eritema intenso, edema peniano, disúria inicial, choro ao urinar e saída de exsudato purulento pelo orifício prepucial (S. aureus, Streptococcus e flora cutânea/fecal).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Banhos de Assento com Água Morna ou Solução Fisiológica	Imersão peniana em água morna por 10 a 15 minutos 3 a 4 vezes ao dia.	Livre	Acalma a dor, reduz o edema e facilita a drenagem espontânea de secreções acumuladas no espaço balanoprepucial.
Mupirocina 2% pomada tópica ou Neomicina + Bacitracina	Aplicar no orifício e glândula externa 3 vezes ao dia após os banhos de assento por 5 a 7 dias.	3x/dia	NUNCA forçar a retração prepucial durante a fase inflamatória aguda (risco de dor atroz, sangramento, fissura e parafimose irreversível).

2ª Linha / Resgate: Cefalexina oral (50 mg/kg/dia por 7 dias) se celulite peniana ascendente, febre ou toxemia associada.

Medidas Não Farmacológicas: • Analgesia sistêmica com Dipirona ou Paracetamol. • Higiene suave com água e sabão neutro sem forçar o prepúcio.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Retenção urinária aguda com bexigoma palpável por dor intensa ao urinar. ■■ Parafimose (estrangulamento da glândula pelo prepúcio retraído edemaciado).

Retorno / Reavaliação: Retorno em 48 a 72 horas para reavaliação clínica.

Diagnóstico 079: Fimose Fisiológica vs. Fimose Verdadeira e Parafimose Aguda

CID-10: N47 | Faixa Etária: Meninos de todas as idades

Crítérios Clínicos: Fimose Fisiológica: aderências balanoprepuciais normais sem anel fibroso cicatricial (presente em 90% dos recém-nascidos e 50% dos meninos de 1 ano; resolução espontânea até 3-5 anos); Fimose Verdadeira: anel fibrótico estenótico e esbranquiçado no prepúcio; Parafimose: emergência urológica com prepúcio estreito retraído proximalmente ao sulco coronal, causando estrangulamento vascular, edema maciço e risco de isquemia da glândula.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Fimose Verdadeira / Estenose Prepucial: Betametasona 0,05% + Hialuronidase pomada (Postec)	Aplicar camada fina no anel fibrótico prepucial 2 vezes ao dia por 4 a 8 semanas, associada a tração manual muito suave e progressiva (massagem sem dor) a partir da 2ª semana de uso.	2x/dia por até 8 semanas	Taxa de sucesso > 80-90% evitando cirurgia; indicada apenas a partir de 2 a 3 anos de idade se persistência de anel verdadeiro ou ITUs de repetição.
Parafimose Aguda: Redução Manual Imediata sob Analgesia/Anestesia Local	Compressão circunferencial firme da glândula com os dedos por 5 a 10 minutos para drenar o edema, seguida de tração anterior do prepúcio com os polegares empurrando a glândula para dentro.	Emergência imediata	Se falha da manobra manual não invasiva: incisão dorsal de emergência no anel constritor.

2ª Linha / Resgate: Postectomia cirúrgica (circuncisão) eletiva se falha do corticoide tópico, balanite xerótica obliterante (BXO) ou infecções urinárias recorrentes com malformação.

Medidas Não Farmacológicas: • ORIENTAÇÃO MANDATÓRIA: NUNCA REALIZAR MASSAGENS FORÇADAS ('exercícios') no pênis do bebê nos primeiros anos (provocam microfissuras que cicatrizam com fibrose irreversível, transformando uma aderência fisiológica em fimose patológica). • Após retração para higienização em crianças maiores, o prepúcio DEVE SER IMEDIATAMENTE RETORNADO à posição anatômica cobrindo a glândula (previne parafimose).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Glândula arroxeadada ou cianótica com edema irreduzível (parafimose com risco de necrose isquêmica). ■■ Retenção urinária aguda com abaulamento prepucial 'em balão' durante a micção.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação após 6 a 8 semanas do ciclo de corticoide tópico.

Diagnóstico 080: Vulvovaginite Inespecífica da Infância

CID-10: N76.0 | Faixa Etária: Meninas na fase pré-puberal (2 a 8 anos)

Critérios Clínicos: Corrimento vaginal mucoso ou seroso claro/amarelado, hiperemia e prurido vulvar, disúria de contato ('dor ao urinar quando a urina bate na pele irritada'), sem odor pútrido fétido e sem sangramento vaginal.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Banhos de Assento com Chá de Camomila ou Água Morna	Imersão por 10 a 15 minutos 1 a 2 vezes ao dia por 7 a 10 dias.	Livre	Ação anti-inflamatória e calmante local natural.
Pomada Protetora de Barreira com Óxido de Zinco + Dexpantenol	Aplicar camada fina nos grandes e pequenos lábios externos após higiene 2 vezes ao dia.	2x/dia	Protege a mucosa delgada e hipoestrogênica do contato com a urina e fezes.

2ª Linha / Resgate: Amoxicilina oral (50 mg/kg/dia por 7 dias) se cultura positiva com isolamento de Streptococcus pyogenes (Streptococcus do grupo A - causa de vulvovaginite bacteriana aguda com eritema perianal vermelho-vivo).

Medidas Não Farmacológicas: • Higiene perineal rigorosa da frente para trás após urinar e evacuar. • Uso exclusivo de calcinhas 100% algodão; evitar tecidos sintéticos, lycra e calças justas. • Dormir sem calcinha para arejamento da região genital. • Evitar banhos de espuma, sabonetes perfumados, talcos e produtos químicos irritantes. • Tratamento de oxiúriase se prurido perianal noturno associado.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Sangramento vaginal (investigar corpo estranho vaginal, abuso sexual ou puberdade precoce). ■■ Corrimento fétido purulento profuso contínuo (forte suspeita de corpo estranho como papel higiênico retido). ■■ Lesões verrucosas ou vesiculares.

Retorno / Reavaliação: Retorno se persistência dos sintomas após 2 a 3 semanas de medidas higiênicas.

Diagnóstico 081: Enurese Noturna Monossintomática Primária

CID-10: F98.0 | Faixa Etária: >= 5 anos de idade

Critérios Clínicos: Perda involuntária de urina durante o sono em crianças com idade >= 5 anos, pelo menos 1 a 2 vezes por semana por > 3 meses consecutivos, sem qualquer outro sintoma diurno (sem urgência, incontinência diurna, polaciúria ou disúria) e sem histórico prévio de continência noturna > 6 meses.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Terapia Comportamental e Alarme Noturno (Tratamento Padrão-Ouro de Primeira Linha)	Dispositivo sensor de umidade acoplado à cueca/calcinha que emite alarme sonoro ao primeiro sinal de perda urinária, por 3 a 4 meses consecutivos.	Intervenção comportamental	Maior taxa de cura definitiva (> 70-80%) e menor taxa de recaída; exige motivação da criança e dos cuidadores.
Acetato de Desmopressina (DDAVP) comprimido sublingual (Melly 120/240 mcg) ou oral	Iniciar com 120 mcg (sublingual) ou 0,2 mg (oral) 30 a 60 minutos antes de dormir; pode titular para 240 mcg se necessário.	240 mcg sublingual ou 0,4 mg oral	RESTRIÇÃO HÍDRICA RIGOROSA: ingerir no máximo 100-200 mL de água a partir de 1 hora antes até 8 horas após a tomada (risco grave de Intoxicação Hídrica e Hiponatremia Convulsiva).

2ª Linha / Resgate: Oxibutinina (0,2 a 0,4 mg/kg/dia a cada 12h) se componente de bexiga hiperativa concomitante (enurese não monossintomática).

Medidas Não Farmacológicas: • NUNCA castigar, punir, humilhar ou culpar a criança (a enurese é um atraso de maturação involuntário com forte componente genético). • Reduzir a ingestão de líquidos após as 18-19 horas e evitar bebidas com cafeína/refrigerantes à noite. • Esvaziar a bexiga imediatamente antes de deitar. • Tratar rigorosamente a constipação intestinal (o reto dilatado por fezes comprime a bexiga).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Enurese de início recente em criança previamente continente há > 6 meses (enurese secundária - investigar diabetes mellitus, ITU, estresse psicológico grave ou abuso). ■■ Sintomas urinários diurnos ou alterações no jato.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação médica a cada 4 a 8 semanas para ajuste do plano de tratamento.

Diagnóstico 082: Orquiepididimite Aguda vs. Torção Testicular Aguda

CID-10: N45.9 / N44 | Faixa Etária: Adolescentes e escolares (torção tem picos no período neonatal e na puberdade)

Crítérios Clínicos: Diagnóstico Diferencial Crítico: Torção Testicular (Dor escrotal súbita atroz, testículo elevado e horizontalizado, reflexo cremastérico AUSENTE, Sinal de Prehn negativo - emergência cirúrgica com janela de salvamento < 6h); Orquiepididimite (Início mais gradual de dor, febre, edema e eritema escrotal, epidídimo espessado doloroso, reflexo cremastérico PRESENTE, Sinal de Prehn positivo - alívio da dor à elevação do testículo).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Suspeita de Torção Testicular: EXPLORAÇÃO CIRÚRGICA DE EMERGÊNCIA IMEDIATA	Encaminhamento cirúrgico/urológico sem perda de tempo com exames se alta probabilidade clínica.	Cirurgia imediata	O Doppler escrotal só deve ser realizado se disponível instantaneamente sem atrasar a transferência ao bloco cirúrgico.
Orquiepididimite Bacteriana: Ceftriaxona IV/IM + Azitromicina ou Ciprofloxacino	Se sexualmente ativos (C. trachomatis / N. gonorrhoeae): Ceftriaxona 500 mg IM dose única + Azitromicina 1 g VO dose única; Se pré-puberal (enterobactérias): Cefalexina ou Ceftriaxona por 10 a 14 dias.	Doses padrão	Associar repouso e analgesia vigorosa.

2ª Linha / Resgate: Destorção manual externa ('como abrir um livro' - de medial para lateral) no PA como medida de resgate provisória enquanto a equipe cirúrgica se prepara.

Medidas Não Farmacológicas: • Repouso absoluto no leito com suspensório escrotal ou suporte escrotal elevado. • Aplicação de compressas frias locais na orquiepididimite. • Analgesia sistêmica com Dipirona ou AINE.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Dor testicular súbita aguda é torção testicular até que se prove o contrário por exploração ou Doppler. ■■ Atraso > 6 horas na torção testicular resulta em isquemia irreversível e necrose testicular.

Retorno / Reavaliação: Internação imediata se suspeita de torção testicular.

MÓDULO 07: CARDIOLOGIA E EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES

Diagnóstico 083: Parada Cardiorrespiratória Pediátrica - Ritmos Chocáveis (FV / TV sem Pulso)

CID-10: I46.9 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Inconsciência súbita, ausência de pulso central (braquial/femoral em lactentes; carotídeo/femoral em crianças) e ausência de respiração normal (apneia ou gasping). Monitor com Fibrilação Ventricular (FV) ou Taquicardia Ventricular sem pulso (TVSP).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Desfibrilação Elétrica Precoce Imediata (Manual ou DEA com atenuador)	1º Choque: 2 J/kg; 2º Choque: 4 J/kg; Choques subsequentes: >= 4 J/kg (máx 10 J/kg ou dose de adulto 200-360 J).	10 J/kg ou 360 J	Minimizar interrupções nas compressões torácicas (< 5 segundos para o choque).
Adrenalina (Epinefrina) 1 mg/mL (1:1000) diluída para 1:10.000 IV/IO	0,01 mg/kg (0,1 mL/kg da diluição 1:10.000) IV/IO administrada após o 2º choque e a cada 3 a 5 minutos durante a RCP.	1 mg (10 mL da 1:10.000)	Lavar com flush de 5 mL de SF 0,9% e elevar o membro após a administração.
Amiodarona 50 mg/mL ou Lidocaína 2% IV/IO (Antiarrítmicos para FV/TV refratária)	Amiodarona: 5 mg/kg IV/IO em bolus rápido (máx 300 mg), pode repetir até 2 vezes (total 15 mg/kg); OU Lidocaína: 1 mg/kg IV/IO (máx 100 mg).	Amiodarona 300 mg/dose; Lidocaína 100 mg	Administrar após o 3º choque se persistência de ritmo chocável.

2ª Linha / Resgate: Sulfato de Magnésio 50% (25 a 50 mg/kg IV/IO - máx 2 g) se suspeita ou confirmação de Torsades de Pointes (TV polimórfica com QT longo).

Medidas Não Farmacológicas: • Compressões torácicas de alta qualidade: frequência 100-120/min, profundidade de pelo menos 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax (4 cm em lactentes, 5 cm em crianças), permitir retorno total do tórax e evitar hiperventilação (1 respiração a cada 2-3s com via aérea avançada). • Identificação e tratamento imediato dos 5Hs e 5Ts (Hipóxia, Hipovolemia, Hidrogênio/Acidose, Hipo/Hipercalemia, Hipotermia; Tensão/Pneumotórax, Tamponamento, Toxinas, Trombose pulmonar, Trombose coronariana).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Emergência médica absoluta com risco iminente de morte.

Retorno / Reavaliação: Checagem de ritmo e pulso estritamente a cada 2 minutos de ciclo de RCP ininterrupto.

Diagnóstico 084: Parada Cardiorrespiratória Pediátrica - Ritmos Não Chocáveis (Assistolia e AESP)

CID-10: I46.9 | **Faixa Etária:** Todas as idades pediátricas (ritmo mais frequente em crianças)

Critérios Clínicos: Inconsciência, ausência de pulso e apneia/gasping. Monitor com linha isoeétrica (Assistolia confirmada em 2 derivações - Protocolo da Linha Reta) ou ritmo elétrico organizado sem pulso palpável (Atividade Elétrica Sem Pulso - AESP). Etiologia quase sempre hipóxica/asfíxica ou hipovolêmica.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Adrenalina (Epinefrina) 1:10.000 (0,1 mg/mL) IV / IO IMEDIATA	0,01 mg/kg (0,1 mL/kg da diluição 1:10.000) IV/IO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL no início da RCP, repetindo a cada 3 a 5 minutos.	1 mg (10 mL)	Na assistolia/AESP, a administração precoce de adrenalina nos primeiros minutos está diretamente associada ao retorno da circulação espontânea (RCE).
Cristaloides Balanceados ou SF 0,9% IV/IO (Expansão Volêmica)	Bolus de 10 a 20 mL/kg IV/IO se suspeita de hipovolemia, desidratação, hemorragia ou sepse.	Conforme necessidade	A hipovolemia é a causa tratável mais comum de AESP na infância.

2ª Linha / Resgate: Bicarbonato de Sódio a 8,4% (1 mEq/kg IV/IO) APENAS se acidose metabólica grave preexistente comprovada, hipercalemia grave ou intoxicação por antidepressivos tricíclicos.

Medidas Não Farmacológicas: • Prioridade máxima: OXIGENAÇÃO E VENTILAÇÃO EFICAZES com bolsa-válvula-máscara (BVM) e O2 a 100%, com via aérea avançada precoce (cânula com balonete). • Busca ativa e correção agressiva da causa primária (5Hs e 5Ts).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Assistolia refratária com tempo de RCP > 20-30 minutos sem causa reversível identificável.

Retorno / Reavaliação: Checagem de ritmo e troca de socorrista a cada 2 minutos.

Diagnóstico 085: Taquicardia Supraventricular (TSV) Pediátrica

CID-10: I47.1 | **Faixa Etária:** Lactentes e crianças

Critérios Clínicos: Taquicardia com QRS estreito (< 0,09s), ritmo regular, ausência de ondas P visíveis e FC extremamente elevada e fixa: > 220 bpm em lactentes e > 180 bpm em crianças maiores, de início e término súbitos. Estável (perfusão preservada) vs. Instável (choque, hipotensão, letargia, insuficiência cardíaca congestiva).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Paciente Estável: Manobras Vagais Precoces	Lactentes: Aplicação de bolsa de gelo com água na face (cobrindo fronte e nariz) por 15 a 20 segundos (Reflexo do Mergulho); Crianças maiores: Manobra de Valsalva modificada (soprar em seringa de 10 mL por 15s e reclinar o tronco com elevação de pernas).	Sem drogas	NUNCA realizar compressão ocular/do globo ocular em pediatria (risco de descolamento de retina).
Adenosina 3 mg/mL solução injetável IV/IO (se falha vagal ou estável)	1ª dose: 0,1 mg/kg (máx 6 mg) IV em BOLUS ULTRA-RÁPIDO (< 2s) seguido IMEDIATAMENTE de flush de 5-10 mL de SF 0,9%. 2ª dose (se sem reversão em 1-2 min): 0,2 mg/kg (máx 12 mg) IV bolus rápido.	1ª dose 6 mg; 2ª dose 12 mg	Administrar na veia mais proximal ao coração (antecubital) usando torneirinha de 3 vias (three-way). Registro contínuo de ECG no momento da infusão (pausa sinusal transitória é esperada).
Paciente Instável: Cardioversão Elétrica Sincronizada Imediata	1ª dose: 0,5 a 1 J/kg sincronizada. Se refratária: aumentar para 2 J/kg sincronizada.	2 J/kg ou dose adulta	Sedação e analgesia prévia rápida com Cetamina ou Etomidato se o paciente estiver consciente.

2ª Linha / Resgate: Amiodarona IV (5 mg/kg em 20-60 min) ou Procainamida IV se TSV refratária com auxílio de cardiopediatra. Manutenção ambulatorial: Propranolol ou Flecainida.

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização eletrocardiográfica contínua de 12 derivações antes e após a reversão. • Avaliação de ecocardiograma para descartar cardiopatia estrutural ou via anômala (Síndrome de Wolff-Parkinson-White).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Evolução para choque cardiogênico com má perfusão e colapso circulatório. ■■ Deterioração para taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular.

Retorno / Reavaliação: Internação e monitorização em leito de observação contínua ou UTI até estabilidade do ritmo.

Diagnóstico 086: Bradiarritmias Sintomáticas e Bloqueio Atrioventricular (BAV)

CID-10: I44.2 / R00.1 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Frequência cardíaca abaixo do limite inferior para a idade (< 60 bpm em lactentes e crianças com choque/má perfusão), associada a comprometimento cardiopulmonar (hipotensão, alteração do estado mental, tempo de enchimento capilar > 3s, pulsos filiformes). BAV de 2º grau Mobitz II ou BAV Total no ECG.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Ventilação e Oxigenação com Pressão Positiva (Tratamento Principal)	Se FC < 60 bpm com má perfusão apesar de oxigenação adequada: INICIAR COMPRESSÕES TORÁCICAS DE RCP IMEDIATAMENTE.	Manobra básica	A causa mais comum de bradicardia sintomática na infância é a HIPÓXIA GRAVE. A ventilação eficaz com BVM e O2 a 100% reverte a maioria dos casos.
Adrenalina (Epinefrina) 1:10.000 IV/IO (se persistência de FC < 60 bpm)	0,01 mg/kg (0,1 mL/kg da 1:10.000) IV/IO a cada 3 a 5 minutos.	1 mg	Droga de primeira escolha se bradicardia sintomática refratária à oxigenação.
Atropina 0,25 mg/mL ou 0,5 mg/mL IV/IO (se tônus vagal aumentado ou BAV primário)	0,02 mg/kg IV/IO (dose mínima: 0,1 mg; dose máxima única: 0,5 mg em crianças e 1 mg em adolescentes).	0,5 mg (criança) / 1 mg (adolescente)	Dose mínima de 0,1 mg para evitar bradicardia paradoxal central.

2ª Linha / Resgate: Marcapasso Transcutâneo ou Transvenoso de emergência se BAV total congênito ou adquirido refratário a fármacos; Infusão contínua de Isoproterenol ou Adrenalina.

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização contínua de ECG, SpO2 e pressão arterial. • Investigação de causas toxicológicas (intoxicação por betabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio, clonidina ou digitálicos).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Parada cardiorrespiratória em assistolia iminente.

Retorno / Reavaliação: Internação imediata em UTI Pediátrica e interconsulta com eletrofisiologia/cardiopediatria.

Diagnóstico 087: Choque Cardiogênico Pediátrico e Disfunção Miocárdica Aguda

CID-10: R57.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Sinais de baixo débito cardíaco (taquicardia, pulsos centrais e periféricos filiformes, oligúria, extremidades frias, tempo de enchimento capilar > 3s, letargia) associados a SINAIS DE CONGESTÃO SISTÊMICA E PULMONAR: hepatomegalia dolorosa, estertores crepitantes pulmonares, ritmo de galope (B3) e turgência jugular.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Inotrópico / Inodilatador IV Contínuo: Milrinona ou Dobutamina	Milrinona: 0,25 a 0,75 mcg/kg/min IV contínuo (sem bolus se PA limítrofe) OU Dobutamina: 5 a 15 mcg/kg/min IV contínuo.	Milrinona 0,75 mcg/kg/min; Dobutamina 20 mcg/kg/min	Aumentam a contratilidade miocárdica e reduzem a pós-carga ventricular. Se hipotensão arterial associada, titular com Adrenalina ou Noradrenalina.
Adrenalina (Epinefrina) em Infusão Contínua IV	0,05 a 0,3 mcg/kg/min IV em bomba de infusão contínua.	1 mcg/kg/min	Suporte inotrópico e vasopressor potente se disfunção miocárdica com choque descompensado.
Furosemida IV (se sobrecarga volêmica franca e estabilidade de PA)	0,5 a 1 mg/kg/dose IV a cada 12 horas.	2 mg/kg/dose	Administrar com cautela apenas após melhora da perfusão miocárdica com os inotrópicos.

2ª Linha / Resgate: Suporte Circulatório Mecânico com ECMO venoarterial (Oxigenação por Membrana Extracorpórea) em choque cardiogênico refratário a drogas vasoativas máximas.

Medidas Não Farmacológicas: • Oxigênio suplementar e suporte ventilatório não invasivo (CPAP/VNI) com PEEP para reduzir a pós-carga do VE e aliviar o edema pulmonar. • Restrição hídrica cuidadosa; EVITAR bolus rápidos volumosos de cristaloides (risco de piora aguda da falência ventricular esquerda). • Ecocardiograma à beira-leito (POCUS) para avaliar fração de ejeção, contratilidade segmentar e derrames.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Edema agudo de pulmão com secreção espumosa rósea em vias aéreas. ■■ Parada cardíaca por falência de bomba.

Retorno / Reavaliação: Monitorização hemodinâmica contínua em UTI Pediátrica.

Diagnóstico 088: Choque Obstrutivo (Tamponamento Cardíaco e Pneumotórax Hipertensivo)

CID-10: R57.8 / I31.9 / J93.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Choque com colapso circulatório por restrição mecânica ao enchimento ou ejeção cardíaca. Tamponamento: Tríade de Beck (hipotensão arterial, abafamento de bulhas cardíacas e turgência jugular) + pulso paradoxal; Pneumotórax Hipertensivo: desvio de traqueia contralateral, abolição unilateral do murmúrio vesicular, hipertimpanismo e choque.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Pneumotórax Hipertensivo: Toracocentese de Alívio com Agulha Imediata	Punção no 2º espaço intercostal na linha hemiclavicular (ou 4º/5º espaço na linha axilar anterior/média) com cateter calibroso (Abbocath 14-18G), seguida de drenagem torácica tubular fechada em selo d'água.	Procedimento descompressivo	EMERGÊNCIA MÉDICA CLÍNICA ABSOLUTA. NUNCA aguardar radiografia de tórax para descompressão se instabilidade hemodinâmica.
Tamponamento Cardíaco: Pericardiocentese de Emergência (guiada por POCUS se disponível)	Punção subxifoidiana em ângulo de 45º direcionada ao ombro esquerdo com aspiração contínua do líquido pericárdico.	Alívio hemodinâmico	A aspiração de pequenos volumes (10 a 20 mL) já restaura imediatamente o débito cardíaco.

2ª Linha / Resgate: Expansão volêmica rápida com cristalóide (10 a 20 mL/kg IV) como medida de ponte temporária para manter a pré-carga enquanto se realiza o procedimento descompressivo.

Medidas Não Farmacológicas: • Oxigenioterapia a 100%. • Drenagem torácica definitiva em selo d'água após punção com agulha.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP) por obstrução mecânica crítica.

Retorno / Reavaliação: Internação em UTI Pediátrica e ecocardiograma/TC de controle.

Diagnóstico 089: Doença de Kawasaki Aguda (Vasculite Sistêmica)

CID-10: M30.3 | Faixa Etária: 6 meses a 5 anos (pico 1 a 2 anos)

Crítérios Clínicos: Febre alta diária persistente por >= 5 dias associada a pelo menos 4 dos 5 critérios clínicos clássicos: 1) Conjuntivite bulbar bilateral não exsudativa; 2) Alterações labiais e de cavidade oral (lábios fissurados/eritematosos, língua em framboesa, hiperemia faríngea); 3) Alterações de extremidades (edema indolor e eritema palmo-plantar agudo; descamação periungueal subaguda); 4) Exantema polimórfico não vesicular; 5) Linfadenopatia cervical aguda não supurativa (>= 1,5 cm, geralmente unilateral).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Imunoglobulina Humana Intravenosa (IGIV) 10%	2 g/kg IV infundidos em dose única contínua ao longo de 10 a 12 horas.	2 g/kg (máx 100 g)	Pilar central do tratamento. Iniciar idealmente entre o 5º e o 10º dia de febre para REDUZIR O RISCO DE ANEURISMAS DE ARTÉRIA CORONÁRIA de 25% para menos de 4%. Monitorar reações anafilactóides.
Ácido Acetilsalicílico (AAS) comprimido 100 mg ou 500 mg	Fase Aguda Anti-inflamatória: 30 a 50 mg/kg/dia (ou 80-100 mg/kg/dia) VO dividido a cada 6 horas até a criança estar afebril por 48 a 72 horas. Fase Subaguda / Antiagregante Plaquetária: 3 a 5 mg/kg/dia VO em dose única diária por 6 a 8 semanas.	Fase aguda até 4 g/dia; Fase manutenção até 100 mg/dia	Manter dose antiagregante indefinidamente se houver formação de aneurismas coronarianos no ecocardiograma.

2ª Linha / Resgate: Casos Refratários à 1ª dose de IGIV (febre persistente > 36h após término da infusão): 2ª dose de IGIV (2 g/kg) OU Pulsoterapia com Metilprednisolona (30 mg/kg/dia IV por 3 dias) OU Infliximabe (5 mg/kg IV).

Medidas Não Farmacológicas: • Ecocardiograma transtorácico com cálculo do Z-score das artérias coronárias (DA e CD) no diagnóstico, em 2 semanas e em 6-8 semanas. • Vacinação anual contra Influenza para reduzir risco de Síndrome de Reye pelo uso prolongado de AAS. • Postergar vacinas de vírus vivos atenuados (SCR e Varicela) por 11 meses após a infusão de IGIV.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Infarto agudo do miocárdio por trombose de aneurisma coronariano gigante (Z-score > 10 ou diâmetro > 8 mm). ■■ Choque por Síndrome do Choque de Kawasaki (KDSS) com falência miocárdica.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento multidisciplinar conjunto com cardiopediatria e reumatopediatria.

Diagnóstico 090: Miocardite Aguda Pediátrica

CID-10: I40.9 | **Faixa Etária:** Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Inflamação miocárdica aguda pós-viral (Enterovírus, Parvovírus B19, Adenovírus, SARS-CoV-2) manifestando-se por taquicardia desproporcional à febre, dispneia, fadiga, dor torácica, ritmo de galope (B3/B4), sopro sistólico mitral, elevação de Troponina e BNP/NT-proBNP, alterações difusas de ST-T no ECG e disfunção ventricular ao ecocardiograma.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Suporte Inotrópico com Milrinona ou Dobutamina IV (se disfunção/choque)	Milrinona: 0,25 a 0,75 mcg/kg/min IV contínuo (inodilatador de escolha).	0,75 mcg/kg/min	Suporte inotrópico com redução da resistência vascular sistêmica e pulmonar.
Imunoglobulina Humana Intravenosa (IGIV) em Miocardite Fulminante	1 a 2 g/kg IV infundidos em 12 a 24 horas.	2 g/kg	Efeito imunomodulador e neutralização de citocinas inflamatórias na fase aguda hiperinflamatória.

2ª Linha / Resgate: Pulsoterapia com Metilprednisolona (30 mg/kg/dia IV por 3 dias) em miocardites autoimunes, associadas a MIS-C ou fulminantes; ECMO venoarterial como ponte para recuperação miocárdica.

Medidas Não Farmacológicas: • Repouso absoluto no leito (o exercício físico na fase ativa da miocardite acelera a replicação viral e a necrose miocárdica). • Monitorização contínua em UTI Pediátrica para detecção imediata de arritmias ventriculares e bloqueios AV.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Arritmias ventriculares malignas (TV sustentada, FV). ■■ Choque cardiogênico fulminante com parada circulatória iminente.

Retorno / Reavaliação: Seguimento com ecocardiogramas seriados e ressonância magnética cardíaca.

Diagnóstico 091: Febre Reumática Aguda (Critérios de Jones / Febre Reumática Pós-Estreptocócica)

CID-10: I00 | **Faixa Etária:** 5 a 15 anos

Critérios Clínicos: Doença inflamatória multissistêmica autoimune que surge 2 a 4 semanas após faringoamigdalite por *S. pyogenes*. Diagnóstico pelos Critérios de Jones revisados (presença de evidência de infecção estreptocócica prévia + 2 critérios maiores OU 1 maior e 2 menores). Critérios Maiores: 1) Cardite (pancardite com sopro de insuficiência mitral/aórtica); 2) Poliartrite migratória de grandes articulações; 3) Coreia de Sydenham; 4) Eritema Marginado; 5) Nódulos Subcutâneos.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Eradicação do Estreptococo: Benzilpenicilina Benzatina IM profunda	< 27 kg: 600.000 UI IM dose única; >= 27 kg: 1.200.000 UI IM dose única.	1.200.000 UI	Primeira etapa obrigatória em todos os pacientes, mesmo sem sintomas de faringite ativa.
Poliartrite Isolada (sem Cardite): Ácido Acetilsalicílico (AAS)	80 a 100 mg/kg/dia VO dividido a cada 6 horas por 1 a 2 semanas, seguido de redução para 50-60 mg/kg/dia por mais 2 a 4 semanas.	4 g/dia	A resposta articular ao AAS é espetacular e dramática em 24 a 48 horas (se não houver melhora rápida, questionar o diagnóstico).
Cardite Reumática Moderada a Grave: Prednisona ou Prednisolona oral	1 a 2 mg/kg/dia VO em dose única matinal (máx 60-80 mg/dia) por 2 a 4 semanas, com desmame gradual ao longo de 2 a 4 semanas associado a AAS.	80 mg/dia	Indicado na presença de cardiomegalia, sopro novo importante ou insuficiência cardíaca congestiva.

2ª Linha / Resgate: Profilaxia Secundária Mandatória Contínua: Benzilpenicilina Benzatina IM a cada 21 dias (duração: até 21 anos ou 5 anos após o surto se sem cardite; até 25 anos ou 10 anos após o surto se cardite curada; até 40 anos ou por toda a vida se valvopatia residual grave/cirurgia valvar).

Medidas Não Farmacológicas: • Repouso absoluto no leito durante a fase de artrite aguda e cardite ativa. • Haloperidol (0,5 a 2 mg/dia) ou Ácido Valproico se Coreia de Sydenham incapacitante.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Insuficiência cardíaca descompensada com taquipneia, hepatomegalia e galope. ■■ Ruptura de cordoalha tendínea com insuficiência mitral aguda maciça.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento com provas inflamatórias (VHS/PCR) e ecocardiograma a cada 4 a 12 semanas.

Diagnóstico 092: Crise de Hipóxia / Cianose na Tetralogia de Fallot ('Spell')

CID-10: Q21.3 | Faixa Etária: Lactentes com Tetralogia de Fallot (pico 2 a 6 meses)

Critérios Clínicos: Episódio agudo e súbito de hiperpneia paroxística, choro intenso, irritabilidade, cianose profunda generalizada e diminuição ou desaparecimento do sopro sistólico ejetivo pulmonar (espasmo do infundíbulo subpulmonar com aumento maciço do shunt da direita para a esquerda).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Manobra Joelho-Tórax (Genupeitoral) Imediata	Flexão forçada e sustentada dos joelhos e coxas contra o tórax do lactente.	Manobra física	Aumenta imediatamente a Resistência Vascular Sistêmica (RVS), reduz o shunt D-E na CIV e força o fluxo sanguíneo desoxigenado em direção aos pulmões.
Sulfato de Morfina 10 mg/mL injetável SC ou IV	0,1 a 0,2 mg/kg SC ou IV lento.	10 mg/dose	Acalma o paciente, suprime o centro respiratório hiperativo e relaxa o espasmo muscular infundibular subpulmonar.
Expansão Volêmica com SF 0,9% IV	Bolus rápido de 10 a 20 mL/kg IV.	20 mL/kg	Aumenta o volume intravascular e melhora o enchimento do ventrículo direito.

2ª Linha / Resgate: Propranolol IV (0,01 a 0,1 mg/kg IV lento em 5 min) ou Esmolol para relaxamento infundibular; Fenilefrina IV (5 a 20 mcg/kg em bolus) como vasopressor alfa-1 puro para elevar a RVS; Intubação traqueal e anestesia com Cetamina se crise refratária.

Medidas Não Farmacológicas: • Oxigenioterapia em alto fluxo sob máscara. • Tranquilização e evitar punções dolorosas sem analgesia adequada.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Acidose metabólica grave, convulsões hipóxicas, síncope e parada cardiorrespiratória.

Retorno / Reavaliação: Internação em UTI Pediátrica e indicação de correção cirúrgica definitiva ou shunt paliativo (Blalock-Taussig).

Diagnóstico 093: Coarctação de Aorta Descompensada no Neonato / Cardiopatia Canal-Dependente

CID-10: Q25.1 | Faixa Etária: Neonatos nos primeiros 7 a 14 dias de vida

Critérios Clínicos: Colapso circulatório, choque cardiogênico e acidose metabólica grave que surgem abruptamente no momento do FECHAMENTO FISIOLÓGICO DO CANAL ARTERIAL. Diferencial de pulsos e pressão: pulsos femorais filiformes ou ausentes com pulsos braquiais palpáveis, e gradiente pressórico > 15-20 mmHg entre membros superiores e inferiores.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
ALPROSTADIL (PROSTAGLANDINA E1 - PGE1) Infusão Contínua IV Imediata	Dose de Ataque: 0,05 a 0,1 mcg/kg/min IV em infusão contínua em bomba. Após abertura do canal arterial e restauração da perfusão (aumento de pulsos femorais e melhora da diurese), reduzir para dose de manutenção: 0,01 a 0,025 mcg/kg/min.	0,1 mcg/kg/min	FÁRMACO SALVADOR DE VIDAS. Reabre ou mantém patente o ductus arteriosus, restabelecendo o fluxo sanguíneo para a aorta descendente. PRINCIPAL EFEITO ADVERSO: APNEIA (em 10-12% dos neonatos, especialmente na 1ª hora); MANTER MATERIAL DE INTUBAÇÃO PRONTO À BEIRA DO LEITO.

2ª Linha / Resgate: Suporte inotrópico com Milrinona ou Dobutamina associado; Correção cuidadosa da acidose metabólica.

Medidas Não Farmacológicas: • Ecocardiograma de urgência à beira-leito. • Intubação eletiva se apneia induzida pela PGE1. • Encaminhamento imediato para correção cirúrgica ou cateterismo intervencionista com cirurgião cardiovascular pediátrico.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Isquemia mesentérica grave com enterocolite necrosante. ■■ Insuficiência renal anúrica e choque refratário se atraso na infusão de prostaglandina.

Retorno / Reavaliação: Manter infusão contínua ininterrupta de Alprostadil em UTI Neonatal até o bloco cirúrgico.

Diagnóstico 094: Crise Hipertensiva Pediátrica (Emergência vs. Urgência Hipertensiva)

CID-10: I10 / I15.9 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Pressão Arterial > Percentil 99 + 5 mmHg para sexo, idade e altura. Emergência Hipertensiva: presença de Lesão de Órgão-Alvo (LOU) aguda em curso (Encefalopatia hipertensiva, AVC, edema agudo de pulmão, dissecção aórtica ou IRA rapidamente progressiva); Urgência Hipertensiva: PA no estágio 2 severo, mas SEM lesão aguda de órgão-alvo.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Emergência Hipertensiva (LOU presente): Nitroprussiato de Sódio IV Contínuo	0,5 a 8 mcg/kg/min IV em infusão contínua protegida da luz (iniciar com 0,5 a 1 mcg/kg/min e titular a cada 5-10 min). Meta: reduzir a PA em no máximo 25% nas primeiras 6 a 8 horas (evitar queda abrupta para prevenir isquemia cerebral).	8 mcg/kg/min (risco de toxicidade por cianeto/tiocianato se > 2 mcg/kg/min por > 48h)	Exige monitorização contínua de pressão arterial invasiva (PAI) em UTI.
Urgência Hipertensiva (Sem LOU): Amlodipino ou Hidralazina ou Captopril VO	Amlodipino: 0,1 a 0,3 mg/kg/dia VO (máx 10 mg); OU Hidralazina: 0,2 a 0,5 mg/kg/dose VO a cada 6-8h; OU Captopril: 0,3 a 0,5 mg/kg/dose VO.	Amlodipino 10 mg; Hidralazina 50 mg/dose; Captopril 25 mg/dose	Redução gradual e suave da PA ao longo de 24 a 48 horas em ambiente hospitalar.

2ª Linha / Resgate: Nicardipino IV (0,5 a 5 mcg/kg/min) ou Labetalol IV como alternativas de excelência para infusão contínua em emergências.

Medidas Não Farmacológicas: • Ambiente calmo e repouso absoluto. • Investigação etiológica detalhada de hipertensão secundária na infância (doença do parênquima renal, estenose de artéria renal, coarctação de aorta, feocromocitoma, causas endócrinas). • Restrição rigorosa de sódio.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Cefaleia em trovoada, vômitos em jato, turvação visual, crises convulsivas e coma (Encefalopatia Hipertensiva). ■■ Edema pulmonar com insuficiência respiratória aguda.

Retorno / Reavaliação: Internação em UTI Pediátrica para emergências hipertensivas e controle de PA a cada 15-30 minutos.

MÓDULO 08: OTORRINOLARINGOLOGIA E OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA

Diagnóstico 095: Otite Média Aguda (OMA) Não Supurada

CID-10: H66.0 | Faixa Etária: 6 meses a 3 anos (pico 6 a 12 meses)

Crítérios Clínicos: Início agudo de otalgia (ou lactente puxando a orelha com choro e irritabilidade), febre e otoscopia demonstrando ABAULAMENTO MODERADO A INTENSO DA MEMBRANA TIMPÂNICA com hiperemia e opacidade (Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae não tipável, Moraxella catarrhalis).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Analgesia Sistêmica Regular (Dipirona ou Ibuprofeno)	Dipirona 15-25 mg/kg ou Ibuprofeno 10 mg/kg VO a cada 6h nos primeiros 2 a 3 dias.	Dose padrão	O alívio da dor é mandatório e imediato em todos os pacientes.
Amoxicilina suspensão oral 250 mg/5 mL ou 400 mg/5 mL	80 a 90 mg/kg/dia VO dividido a cada 8h ou 12h por 10 dias (em < 2 anos ou OMA grave) ou por 5 a 7 dias (em >= 2 anos com OMA leve/moderada).	2 g a 3 g/dia	Dose dobrada (80-90 mg/kg) recomendada pela SBP/AAP para superar cepas com PBP alterada de pneumococo. Conduta de observação vigilante (sem ATB imediato) é permitida apenas em >= 2 anos com OMA unilateral leve e seguimento garantido em 48h.

2ª Linha / Resgate: Amoxicilina + Clavulanato (90 mg/kg/dia de amoxicilina na proporção 7:1 ou 14:1) se falha após 48-72h, conjuntivite purulenta associada (Síndrome Otite-Conjuntivite por H. influenzae) ou uso de amoxicilina nos últimos 30 dias; Cefuroxima axetil ou Ceftriaxona IM (50 mg/kg/dia por 3 dias) se vômitos ou alergia.

Medidas Não Farmacológicas: • Lavagem nasal com SF 0,9% para desobstrução da tuba auditiva. • NUNCA instilar gotas otológicas sem confirmação prévia de integridade timpânica. • Elevação da cabeceira durante o sono.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Abaulamento e eritema retroauricular com apagamento do sulco (Mastoidite). ■■ Paralisia facial periférica ou vertigem. ■■ Persistência de febre e dor após 72h de antibiótico.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação em 48 a 72 horas se ausência de melhora clínica.

Diagnóstico 096: Otite Média Aguda Supurada / Perfurada

CID-10: H66.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Histórico de otalgia aguda intensa que CESSA OU ALIVIA SUBITAMENTE com o início de OTORREIA PURULENTA OU SANGUINOLENTA profusa no conduto auditivo externo (perfuração timpânica espontânea de alívio por pressão).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio suspensão oral (Dose Alta 90 mg/kg/dia)	90 mg/kg/dia de amoxicilina (com 6,4 mg/kg/dia de clavulanato) VO dividido a cada 12h por 10 dias completos.	2 g a 3 g/dia de amoxicilina	Tratamento sistêmico obrigatório em todas as faixas etárias de OMA supurada.
Gotas Otológicas Tópicas: Ciprofloxacino 0,3% ou Ciprofloxacino + Dexametasona	3 a 4 gotas no ouvido afetado 2 vezes ao dia por 7 dias.	2x/dia	Gotas contendo quinolonas tópicas são SEGURAS na vigência de perfuração timpânica. NUNCA USAR gotas contendo aminoglicosídeos (Neomicina/Gentamicina) ou álcool na perfuração (risco grave de OTOTOXICIDADE IRREVERSÍVEL).

2ª Linha / Resgate: Ceftriaxona IM (50 mg/kg/dia por 3 dias consecutivos) se intolerância gastrointestinal ou vômitos.

Medidas Não Farmacológicas: • PROTEÇÃO RIGOROSA DO OUVIDO CONTRA ENTRADA DE ÁGUA: não molhar o ouvido no banho (proteger com algodão embebido em vaselina/óleo) e não frequentar piscinas ou praias até confirmação de cicatrização timpânica. • Limpeza externa delicada da concha auricular com gaze seca.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Otorreia contínua por > 2 semanas (evolução para Otite Média Crônica Supurada). ■■ Sinais de mastoidite ou paralisia do VII par craniano.

Retorno / Reavaliação: Otoscopia de controle em 10 a 14 dias e após 6 a 8 semanas para confirmar o fechamento espontâneo da membrana timpânica.

Diagnóstico 097: Mastoidite Aguda Pediátrica

CID-10: H70.0 | Faixa Etária: Lactentes e pré-escolares (< 2 a 4 anos)

Critérios Clínicos: Complicação supurativa de OMA caracterizada por febre alta, prostração, edema, eritema, calor e dor intensa na região retroauricular/apófise mastoide, com APAGAMENTO DO SULCO RETROAURICULAR E PROJEÇÃO ANTERIOR DO PAVILHÃO AURICULAR ('orelha em abano / desvio anterior').

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Ceftriaxona sódica IV + Oxacilina sódica IV (Hospitalar Imediato)	Ceftriaxona: 100 mg/kg/dia IV 1x/dia + Oxacilina: 150 a 200 mg/kg/dia IV dividido a cada 6h por 14 a 21 dias.	Ceftriaxona 2 g a 4 g/dia; Oxacilina 12 g/dia	Cobertura para S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus e P. aeruginosa. Internação hospitalar obrigatória.
Miringotomia com Timpanotomia / Colocação de Tubo de Ventilação	Procedimento otorrinolaringológico de emergência para descompressão e drenagem da orelha média e mastoide.	Procedimento cirúrgico	Coletar secreção para bacterioscopia e cultura com antibiograma.

2ª Linha / Resgate: Vancomicina (40-60 mg/kg/dia) se suspeita de MRSA ou pneumococo resistente; Mastoidectomia cirúrgica com debridamento se abscesso subperiosteal (Abscesso de Bezold) ou falha do tratamento clínico em 48h.

Medidas Não Farmacológicas: • Tomografia Computadorizada (TC) de ossos temporais com contraste para avaliar erosão óssea e complicações intracranianas. • Analgesia e hidratação venosa.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Complicações intracranianas: trombose do seio venoso lateral/sigmoide, abscesso extradural/cerebral ou meningite bacteriana. ■■ Sinais neurológicos focais e rebaixamento de consciência.

Retorno / Reavaliação: Tratamento sob regime de internação hospitalar e acompanhamento diário com otorrinolaringologista.

Diagnóstico 098: Otite Externa Difusa Aguda ('Ouvindo de Nadador')

CID-10: H60.8 | Faixa Etária: Crianças maiores, escolares e adolescentes (frequente no verão)

Crítérios Clínicos: Otolgia intensa que piora dramaticamente à TRAÇÃO DO PAVILHÃO AURICULAR OU À PRESSÃO NO TRAGUS (Sinal do Tragus positivo), edema importante e eritema do conduto auditivo externo, prurido, sensação de plenitude auricular e otorreia serosa/purulenta, com membrana timpânica íntegra (Pseudomonas aeruginosa e S. aureus).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Gotas Otológicas Tópicas: Ciprofloxacino 0,3% + Dexametasona ou Polimixina B + Neomicina + Fluocinolona	Instilar 3 a 4 gotas no conduto auditivo afetado 3 a 4 vezes ao dia (a cada 6 a 8 horas) por 7 dias.	3 a 4 vezes/dia	Aquecer o frasco com as mãos antes de pingar para evitar vertigem calórica; manter a cabeça lateralizada por 3 a 5 minutos após a aplicação.
Analgesia Sistêmica Potente (Dipirona + Ibuprofeno)	Dipirona 15-25 mg/kg + Ibuprofeno 10 mg/kg VO de horário fixo nos primeiros 2 a 3 dias.	Dose padrão	A otite externa é uma das afecções mais dolorosas da infância devido à aderência do periósteo ao conduto ósseo.

2ª Linha / Resgate: Antibioticoterapia oral (Ciprofloxacino oral em adolescentes ou Cefalexina) indicada APENAS se a infecção ultrapassar o conduto auditivo externo, com celulite do pavilhão auricular ou febre sistêmica/diabetes.

Medidas Não Farmacológicas: • PROTEÇÃO ABSOLUTA CONTRA ÁGUA: manter o ouvido rigorosamente seco durante o banho por pelo menos 7 a 10 dias. • NUNCA introduzir hastes flexíveis de algodão (cotonetes), grampos ou outros objetos no conduto. • Aspiração suave de debris purulentos pelo médico para permitir que as gotas atinjam a mucosa.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Disseminação inflamatória com celulite periauricular ou facial. ■■ Febre alta e toxemia. ■■ Otite externa maligna/necrosante em imunocomprometidos.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação em 48 a 72 horas se ausência de alívio da dor.

Diagnóstico 099: Celulite Pré-Septal (Periorbitária)

CID-10: L03.2 | Faixa Etária: < 5 anos (frequente associada a picadas de inseto, trauma ou sinusite etmoidal)

Crítérios Clínicos: Edema palpebral, eritema e calor restritos aos tecidos anteriores ao septo orbitário, COM MOTILIDADE OCULAR EXTRÍNSECA TOTALMENTE PRESERVADA E INDOLOR, ACUIDADE VISUAL NORMAL, REFLEXOS PUPILARES NORMAIS E AUSÊNCIA DE PROPTOSE (S. aureus, S. pyogenes, S. pneumoniae).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Tratamento Ambulatorial / Leve: Amoxicilina + Clavulanato de Potássio ou Cefuroxima axetil	Amoxicilina + Clavulanato: 50 a 80 mg/kg/dia VO dividido a cada 8h ou 12h por 7 a 10 dias; OU Cefuroxima: 30 mg/kg/dia a cada 12h.	Amoxicilina 2 g/dia	Permitido apenas em crianças > 1 ano, afebris, em bom estado geral e com cuidadores confiáveis.
Tratamento Hospitalar / Lactentes < 1 ano ou Toxemia: Ceftriaxona sódica IV + Oxacilina IV	Ceftriaxona: 100 mg/kg/dia IV 1x/dia + Oxacilina: 100 a 150 mg/kg/dia IV a cada 6h por 7 a 10 dias.	Ceftriaxona 2 g/dia; Oxacilina 12 g/dia	Internação mandatória para lactentes jovens ou se incapacidade de abrir os olhos para exame.

2ª Linha / Resgate: Clindamicina ou Vancomicina IV se suspeita de infecção por CA-MRSA.

Medidas Não Farmacológicas: • Compressas mornas locais com SF 0,9%. • Avaliação da acuidade visual e reflexo fotomotor a cada 6 a 12 horas. • Higiene ocular delicada.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Aparecimento de qualquer sinal de transição para Celulite Orbitária Pós-Septal: proptose, dor à movimentação dos olhos, oftalmoplegia ou redução da acuidade visual.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação clínica obrigatória a cada 24 horas no manejo ambulatorial.

Diagnóstico 100: Celulite Pós-Septal (Orbitária Verdadeira)

CID-10: H05.0 | Faixa Etária: Todas as idades (frequente complicação de sinusite etmoidal bacteriana)

Crítérios Clínicos: Infecção grave dos tecidos profundos posteriores ao septo orbitário. TETRADE CLÁSSICA DIAGNÓSTICA: 1) PROPTOSE (olho projetado para a frente); 2) OFTALMOPLÉGIA / PARESIA OCULAR (restrição do movimento dos olhos); 3) DOR INTENSA À MOVIMENTAÇÃO OCULAR; 4) QUEDA DA ACUIDADE VISUAL ou alteração pupilar (defeito pupilar aferente). Associada a febre alta, toxemia e quemose conjuntival.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Antibioticoterapia Intravenosa de Amplo Espectro Imediata: Ceftriaxona IV + Oxacilina IV (ou Clindamicina IV)	Ceftriaxona: 100 mg/kg/dia IV 1x/dia + Oxacilina: 150 a 200 mg/kg/dia IV a cada 6h (ou Clindamicina 40 mg/kg/dia IV a cada 6h) por 14 a 21 dias.	Ceftriaxona 4 g/dia; Oxacilina 12 g/dia	EMERGÊNCIA OFTALMOLÓGICA E PEDIÁTRICA ABSOLUTA. Internação imediata em leito de alta vigilância/UTI.
Tomografia Computadorizada de Crânio e Órbitas com Contraste Urgente	Mapeamento anatômico para rastreamento de abscesso subperiosteal orbitário, abscesso intracraniano ou trombose de seio cavernoso.	Exame diagnóstico imediato	Indica a necessidade de descompressão cirúrgica urgente.

2ª Linha / Resgate: Drenagem cirúrgica de urgência por via endoscópica nasal ou orbitária externa se abscesso subperiosteal/orbitário volumoso, perda progressiva de acuidade visual ou ausência de melhora após 24-48h de ATB IV.

Medidas Não Farmacológicas: • Exame oftalmológico seriado a cada 4 a 6 horas (acuidade visual, reflexos pupilares e fundo de olho). • Cabeceira elevada a 30-45 graus.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Cegueira / perda visual irreversível por isquemia do nervo óptico. ■■ Trombose do Seio Cavernoso (oftalmoplegia bilateral, acometimento de pares cranianos III, IV, V1, V2 e VI, cefaleia em trovoada e coma).

Retorno / Reavaliação: Tratamento sob internação hospitalar rigorosa.

Diagnóstico 101: Conjuntivite Bacteriana Aguda Pediátrica

CID-10: H10.0 | Faixa Etária: Todas as idades (> período neonatal)

Crítérios Clínicos: Hiperemia conjuntival difusa, secreção ocular purulenta ou mucopurulenta espessa amarelada/esverdeada contínua, colamento das pálpebras ao despertar ('olhos colados pela manhã'), sensação de corpo estranho e edema palpebral leve, com acuidade visual preservada e reflexos normais (H. influenzae, S. pneumoniae, S. aureus).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Colírio de Tobramicina 0,3% ou Ciprofloxacino 0,3% ou Cloranfenicol	Instilar 1 a 2 gotas no olho afetado a cada 4 a 6 horas (4 a 6 vezes ao dia) por 7 dias.	6 vezes/dia	Limpar as secreções com gaze estéril embebida em SF 0,9% antes de instilar o colírio. Evitar contato da ponta do conta-gotas com os olhos.
Pomada Oftálmica de Tobramicina ou Cloranfenicol (ao deitar)	Aplicar pequena quantidade no saco conjuntival inferior à noite antes de dormir.	1x à noite	Mantém ação prolongada durante o sono e evita o colamento palpebral matinal.

2ª Linha / Resgate: Tratamento sistêmico com Amoxicilina + Clavulanato oral se associação com Otite Média Aguda (Síndrome Otite-Conjuntivite).

Medidas Não Farmacológicas: • Higiene rigorosa das mãos da criança e cuidadores. • Uso de toalhas e fronhas individuais trocadas diariamente. • Afastamento de creche/escola até 24h após início do colírio antibiótico.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Dor ocular intensa ou fotofobia marcada (suspeita de úlcera de córnea / ceratite). ■■ Conjuntivite hiperaguda com secreção purulenta copiosa em jatos em neonatos/adolescentes (suspeita de Neisseria gonorrhoeae - requer Ceftriaxona IM/IV imediata pelo risco de perfuração de córnea em 24h).

Retorno / Reavaliação: Retorno se ausência de melhora após 48-72h de colírio.

Diagnóstico 102: Conjuntivite Viral e Alérgica Pediátrica

CID-10: H10.1 / H10.2 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Viral (Adenovírus): hiperemia conjuntival, secreção serosa aquosa abundante, sensação de areia nos olhos, linfonodo pré-auricular palpável doloroso e pródromo gripal/faringite (Febre Faringoconjuntival); Alérgica: prurido ocular intenso e bilateral, quemose (edema conjuntival gelatinoso), lacrimejamento e histórico de atopia.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Forma Viral: Compressas Frias com SF 0,9% + Colírio Lubrificante (Lágrimas Artificiais)	Colírio lubrificante (Carmelose 0,5%): 1 a 2 gotas 4 a 6 vezes ao dia por 7 a 14 dias.	Livre	Doença autolimitada; antibióticos tópicos NÃO são indicados na conjuntivite viral pura.
Forma Alérgica: Colírio de Olopatadina 0,1% ou 0,2% (Estabilizador de Mastócitos + Anti-H1)	Instilar 1 gota em cada olho 1 a 2 vezes ao dia durante a temporada de sintomas.	2x/dia	Excelente alívio do prurido com início de ação em minutos e proteção prolongada.

2ª Linha / Resgate: Anti-histamínicos orais de 2ª geração (Desloratadina/Cetirizina) na conjuntivite alérgica com rinite associada. Corticoides tópicos oftálmicos DEVEM SER PRESCRIÇÃO EXCLUSIVA DO OFTALMOLOGISTA (risco de glaucoma e catarata).

Medidas Não Farmacológicas: • Compressas frias com soro fisiológico ou água filtrada gelada por 10 minutos 3x/dia. • NÃO COÇAR OS OLHOS (a fricção mecânica desgranula mastócitos e piora o prurido). • Higiênização frequente das mãos.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Diminuição da acuidade visual ou opacidade de córnea. ■■ Dor ocular profunda ou assimetria pupilar.

Retorno / Reavaliação: Avaliação oftalmológica se sintomas refratários além de 10 a 14 dias.

Diagnóstico 103: Obstrução Congênita do Duto Nasolacrimonal / Dacriocistite Aguda

CID-10: Q10.5 / H04.3 | Faixa Etária: Lactentes nos primeiros meses de vida

Critérios Clínicos: Obstrução Congênita: epífora contínua (olho constantemente 'lacrimejando e molhado') e secreção mucosa matinal não purulenta com conjuntiva clara e olho calmo (persistência da membrana de Hasner); Dacriocistite Aguda: complicação infecciosa com nódulo eritematoso, quente e extremamente doloroso no canto interno do olho (sobre o saco lacrimal) com saída de pus ao refluxo.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Obstrução Congênita Simples: Massagem de Crigler (Terapêutica Central)	Compressão firme com a ponta do dedo indicador indicador sobre o saco lacrimal (canto interno do olho) com movimento deslizante descendente em direção à narina, 10 repetições por sessão, 3 a 4 vezes ao dia.	Massagem mecânica	Aumenta a pressão hidrostática no duto e rompe a membrana de Hasner; cura espontânea em > 90% dos lactentes até 1 ano de idade.
Dacriocistite Aguda Infecciosa: Cefalexina ou Amoxicilina + Clavulanato oral	Cefalexina 50 a 100 mg/kg/dia VO a cada 6h por 10 dias (ou Oxacilina IV se toxemia/lactente jovem).	2 g/dia	Tratamento antibiótico sistêmico obrigatório.

2ª Linha / Resgate: Sondagem cirúrgica das vias lacrimais sob anestesia geral por oftalmopediatra se persistência da obstrução após 10 a 12 meses de idade.

Medidas Não Farmacológicas: • Higiene do olho com soro fisiológico e gaze estéril. • Compressas mornas sobre o saco lacrimal na dacriocistite para acelerar a drenagem.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Celulite orbitária a partir de dacriocistite complicada. ■■ Flutuação e ruptura espontânea do saco lacrimal com fístula cutânea.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento no puericério até desobstrução completa.

Diagnóstico 104: Epistaxe Anterior Aguda na Infância

CID-10: R04.0 | Faixa Etária: Pré-escolares, escolares e adolescentes

Critérios Clínicos: Sangramento nasal agudo originado do Plexo de Kiesselbach (área de Little) no septo nasal anterior, frequentemente deflagrado por microtrauma digital ('cutucar o nariz'), ressecamento ambiental, rinite alérgica ou corpo estranho.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Compressão Digital Direta Externa Imediata (Pilar Central)	Comprimir firmemente as asas nasais contra o septo com os dedos (em pinça) por 10 a 15 minutos ININTERRUPTOS, com a criança SENTADA e com a CABEÇA LEVEMENTE INCLINADA PARA A FRENTE.	Procedimento mecânico	NUNCA inclinar a cabeça para trás (evita a deglutição de sangue, que provoca náuseas, vômitos escuros e risco de broncoaspiração). Não soltar a pressão antes de 10 minutos para não romper o coágulo em formação.
Vasoconstritor Tópico de Resgate: Oximetazolina ou Nafazolina 0,05% tópica	Embeber algodão com vasoconstritor tópico, introduzir na fossa nasal sangrante e manter compressão digital por mais 5 a 10 minutos.	Uso pontual de emergência	Uso exclusivo de resgate no episódio agudo de difícil controle; não usar de forma contínua.
Hidratação da Mucosa Nasal: Gel Nasal ou Pomada com Dexpantenol / SF 0,9%	Aplicar gel hidratante nasal ou SF 0,9% em jatos 4 a 6 vezes ao dia por 2 a 4 semanas.	Livre	Previne ressecamento e recidiva de crostas que deflagram novos sangramentos.

2ª Linha / Resgate: Cauterização química do septo com Nitrato de Prata a 10-20% ou Tamponamento Nasal Anterior com esponja expansível (Merocel) se sangramento refratário à compressão digital.

Medidas Não Farmacológicas: • Umidificação do ambiente nos meses secos. • Corte e lixamento das unhas da criança para evitar trauma mecânico digital. • Tratamento de rinite alérgica de base com corticoide nasal.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Epistaxe posterior profusa com sangramento fluindo continuamente pela orofaringe. ■■ Hipotensão, palidez e instabilidade hemodinâmica. ■■ Histórico familiar de coagulopatia ou sangramentos em outros sítios (petéquias, hematomas espontâneos, gengivorragia - investigar Doença de von Willebrand, hemofilia, trombocitopenia ou leucemia).

Retorno / Reavaliação: Retorno se epistaxes recorrentes frequentes para avaliação otorrinolaringológica.

MÓDULO 09: DISTÚRBIOS HIDROELETROLÍTICOS E ENDOCRINOLOGIA

Diagnóstico 105: Cetoacidose Diabética (CAD) Leve a Moderada

CID-10: E10.1 | Faixa Etária: Crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus Tipo 1

Critérios Clínicos: Tríade diagnóstica: Hiperglicemia (> 200 mg/dL) + Acidose Metabólica (pH venoso < 7,30 ou Bicarbonato sérico < 15 mEq/L) + Cetonemia (>= 3,0 mmol/L) ou cetonúria moderada/grave. Leve: pH 7,20-7,29, HCO3 10-14; Moderada: pH 7,10-7,19, HCO3 5-9; paciente alerta/orientado, sem choque e sem sinais de edema cerebral.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
1ª Etapa: Expansão Volêmica Inicial com SF 0,9% ou Ringer Lactato IV	10 a 20 mL/kg IV infundidos em 1 hora.	20 mL/kg na 1ª hora	Restaura a volemia e melhora a filtração renal. NUNCA INICIAR INSULINA ANTES DE PELO MENOS 1 HORA DE HIDRATAÇÃO VENOSA EFETIVA.
2ª Etapa: Insulinoterapia com Insulina Regular IV Contínua	0,05 a 0,1 U/kg/hora IV em infusão contínua em bomba (NÃO FAZER BOLUS DE INSULINA).	0,1 U/kg/h	Iniciar apenas após a 1ª hora de hidratação e após confirmar K+ > 3,5 mEq/L. Meta: queda suave da glicemia de 50 a 75 mg/dL por hora. QUANDO GLICEMIA ATINGIR 250-300 mg/dL, ADICIONAR OBRIGATORIAMENTE GLICOSE (SG 5% ou SG 10%) À SOLUÇÃO DE HIDRATAÇÃO para manter a infusão de insulina até resolução da acidose (pH > 7,30 e HCO3 > 15).
Reposição Precoce de Potássio (KCl 10% ou 19,1%) IV	Adicionar 40 mEq de K+ por litro de solução venosa assim que confirmada diurese e K+ sérico < 5,0-5,5 mEq/L.	0,5 mEq/kg/h	A insulina e a correção da acidose provocam influxo maciço de potássio para o meio intracelular com risco de hipocalemia grave.

2ª Linha / Resgate: BICARBONATO DE SÓDIO É CONTRAINDICADO de rotina na CAD leve/moderada (aumenta o risco de edema cerebral, acidose liquórica paradoxal e hipocalemia).

Medidas Não Farmacológicas: • Balanço hídrico horário rigoroso e glicemia capilar horária. • Controle gasométrico e ionograma a cada 2 a 4 horas.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Sinais precoces de Edema Cerebral: cefaleia progressiva intensa, vômitos recorrentes, bradicardia, hipertensão, letargia súbita e queda da escala de Glasgow.

Retorno / Reavaliação: Internação hospitalar e transição para insulina subcutânea apenas após resolução da acidose e boa aceitação oral.

Diagnóstico 106: Cetoacidose Diabética (CAD) Grave

CID-10: E10.1 | Faixa Etária: Crianças e adolescentes

Critérios Clínicos: pH venoso < 7,10 e/ou Bicarbonato sérico < 5 mEq/L, respiração profunda e rápida de Kussmaul com hálito cetônico marcante, desidratação grave (> 10%), sonolência, torpor ou coma.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Ressuscitação Volêmica Gradual com SF 0,9% IV	Bolus de 10 a 20 mL/kg IV na 1ª hora. Reposição do déficit hídrico calculada para ser infundida DE FORMA LENTA E GRADUAL AO LONGO DE 48 HORAS (nunca reidratar rapidamente em < 24-36h pelo risco de EDEMA CEREBRAL por gradiente osmótico).	Volume calculado para 48h	Evitar quedas de osmolaridade plasmática superiores a 3 mOsm/kg/hora.
Insulina Regular IV Contínua em Bomba	0,05 a 0,1 U/kg/hora IV após a 1ª hora de expansão.	0,1 U/kg/h	Manter a infusão contínua para desligar a lipólise e cetogênese, titulando a oferta de glicose para manter glicemia entre 150 e 200 mg/dL até o pH normalizar.
Tratamento de Emergência do Edema Cerebral: Solução Salina a 3% ou Manitol IV	NaCl 3%: 2,5 a 5 mL/kg IV em 10-15 min OU Manitol 20%: 0,5 a 1 g/kg IV em 20 min IMEDIATAMENTE ao primeiro sinal de deterioração neurológica.	Doses padrão	ADMINISTRAR ANTES DE QUALQUER EXAME DE IMAGEM (TC) se suspeita de edema cerebral.

2ª Linha / Resgate: Bicarbonato de sódio a 8,4% (1 a 2 mEq/kg IV lento em 1-2h) reservado EXCLUSIVAMENTE para acidose com risco iminente de morte (pH < 6,90 com choque refratário ou hipercalemia com arritmia).

Medidas Não Farmacológicas: • Internação obrigatória em UTI Pediátrica. • Monitorização neurológica contínua (Glasgow) e monitorização eletrocardiográfica. • Sondagem vesical de demora para controle rigoroso de débito urinário.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Edema Cerebral (principal causa de óbito em CAD pediátrica). ■■ Arritmias por hipocalcemia ou hipomagnesemia graves.

Retorno / Reavaliação: Gasometria, glicemia e eletrólitos a cada 2 horas até estabilização.

Diagnóstico 107: Hipoglicemia Pediátrica Sintomática

CID-10: E16.2 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Glicemia capilar ou plasmática < 50 mg/dL em crianças e lactentes (< 45-50 mg/dL em neonatos nas primeiras 24-48h), associada a sintomas adrenérgicos (sudorese fria, palidez, taquicardia, tremores, irritabilidade) ou neuroglicopênicos (sonolência, confusão mental, ataxia, convulsões e coma) - Tríade de Whipple.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Correção de Emergência IV: Glicose a 10% em Bolus (Regra dos 2 mL/kg)	2 a 5 mL/kg de Glicose a 10% IV em bolus lento (0,2 a 0,5 g/kg de glicose pura) ao longo de 2 a 5 minutos.	5 mL/kg de SG 10% (máx 25-50 mL em bolus)	Para preparar SG 10%: misturar partes iguais de SG 5% e Glicose 50% (ou 100 mL de SG 5% + 11 mL de Glicose 50%). NUNCA ADMINISTRAR GLICOSE A 50% PURA EM VEIAS PERIFÉRICAS DE CRIANÇAS (risco de flebite química, necrose tecidual e hiperosmolaridade com hemorragia intracraniana).
Taxa de Infusão de Glicose (TIG) de Manutenção Contínua IV	Iniciar infusão de SG 10% + eletrólitos com TIG de 4 a 8 mg/kg/min em crianças (6 a 8 mg/kg/min em neonatos) para manter glicemia entre 70 e 120 mg/dL.	TIG calculada	Fórmula da TIG: TIG (mg/kg/min) = [% Glicose × Velocidade de infusão em mL/h] / [6 × Peso em kg]. Titular conforme glicemias seriadas.
Glucagon 1 mg/mL frasco injetável SC / IM (se sem acesso venoso imediato)	< 20 kg ou < 5 anos: 0,5 mg SC/IM; >= 20 kg ou >= 5 anos: 1,0 mg SC/IM.	1 mg	Promove liberação rápida de glicogênio hepático; eficaz apenas se reservas hepáticas de glicogênio preservadas (ineficaz em jejum prolongado ou desnutrição grave).

2ª Linha / Resgate: Hidrocortisona IV (2 a 5 mg/kg) se suspeita de insuficiência adrenal ou hipopituitarismo; Diazóxido ou Octreotida em hiperinsulinismo congênito.

Medidas Não Farmacológicas: • Oferta imediata de carboidratos simples por via oral (15 g de glicose: 150 mL de suco de frutas ou 1 colher de sopa de açúcar diluída em água) APENAS se o paciente estiver totalmente consciente, orientado e com deglutição preservada. • Coleta de 'amostra crítica' de sangue (glicemia, insulina, C-peptídeo, cortisol, GH, corpos cetônicos, lactato) no momento exato da hipoglicemia antes da infusão de glicose se etiologia desconhecida.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Convulsão hipoglicêmica e coma com risco de dano neurológico permanente. ■■ Hipoglicemias recorrentes com necessidade de TIG > 12-15 mg/kg/min (hiperinsulinismo).

Retorno / Reavaliação: Glicemia capilar a cada 15-30 minutos após o bolus até estabilização > 70 mg/dL em duas dosagens consecutivas.

Diagnóstico 108: Hiponatremia Aguda Sintomática (Correção com NaCl 3%)

CID-10: E87.1 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Sódio sérico (Na+) < 135 mEq/L (grave se < 120-125 mEq/L) com instalação aguda (< 48 horas) e manifestações neurológicas de edema cerebral: cefaleia intensa, náuseas, vômitos em jato, irritabilidade extrema, sonolência, crises convulsivas e rebaixamento do nível de consciência.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Solução Salina Hipertônica a 3% (NaCl 3%) IV (Correção de Emergência)	Bolus de 2 a 5 mL/kg IV (ou 2 mL/kg em 10 a 20 minutos), podendo repetir até 2 vezes se persistência de crises convulsivas ou rebaixamento de consciência.	5 mL/kg em alíquotas	Como preparar NaCl 3%: misturar 85 mL de SF 0,9% + 15 mL de NaCl 20% (ou 89 mL de água destilada + 11 mL de NaCl 20%). Cada 1 mL/kg de NaCl 3% eleva o sódio sérico em aproximadamente 1 mEq/L. Meta emergencial: elevar o Na+ em 4 a 6 mEq/L rapidamente para estancar o edema cerebral e as convulsões.

2ª Linha / Resgate: Após controle dos sintomas neurológicos agudos: CORREÇÃO LENTA E GRADUAL DO RESTANTE DO DÉFICIT DE SÓDIO. LIMITE MÁXIMO DE ELEVAÇÃO DO SÓDIO: NÃO ULTRAPASSAR 8 A 10 mEq/L EM 24 HORAS (risco grave de Síndrome de Desmielinização Osmótica / Mielinólise Pontina Central se correção rápida em hiponatremias crônicas).

Medidas Não Farmacológicas: • Restrição hídrica se Síndrome da Secreção Inapropriada de ADH (SIADH) ou hipervolemia. • Monitorização contínua de ionograma e balanço hídrico rigoroso.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Crise convulsiva refratária e parada respiratória por herniação tentorial. ■■ Elevação do sódio sérico > 10-12 mEq/L/dia.

Retorno / Reavaliação: Dosagem de sódio sérico a cada 2 horas na fase aguda e a cada 4 horas na fase de manutenção em UTI Pediátrica.

Diagnóstico 109: Hipernatremia Grave Pediátrica

CID-10: E87.0 | Faixa Etária: Lactentes (frequente pós-gastroenterite com SRO mal diluído ou erro de preparo de fórmulas)

Crítérios Clínicos: Sódio sérico (Na+) > 145 mEq/L (grave se > 160 mEq/L), sede intensa e insaciável, febre de origem central, pele com turgor pastoso ('pele em massa de pão / borracha'), mucosas secas, irritabilidade extrema com choro estridente de alta frequência, tremores, hipertonia e torpor.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Fase de Estabilização Hemodinâmica Inicial (se Choque): SF 0,9% IV	Bolus de 10 a 20 mL/kg IV até restauração da perfusão periférica.	Conforme volemia	Utilizar SF 0,9% (solução fisiológica tem Na+ 154 mEq/L, sendo relativamente hipotônica em relação ao paciente com Na+ > 165 mEq/L).
Fase de Reposição do Déficit de Água Livre (Correção Lenta e Gradual)	Calcular o Déficit de Água Livre e infundir solução hipotônica (ex: SF 0,45% em SG 5% com Na+ 77 mEq/L) distribuída LENTAMENTE AO LONGO DE 48 A 72 HORAS.	Velocidade máxima de queda: 0,5 mEq/L/hora (máx 10-12 mEq/L em 24h)	REGRA DE SEGURANÇA MANDATÓRIA: NUNCA CORRIGIR A HIPERNATREMIA DE FORMA RÁPIDA. A entrada rápida de água livre nas células cerebrais carregadas de osmólitos idiógenos adaptativos causa EDEMA CEREBRAL GRAVE, CONVULSÕES E MORTE.

2ª Linha / Resgate: Tratamento de Diabetes Insipidus Central com Desmopressina (DDAVP) se perda maciça de água livre urinária com densidade urinária < 1.005.

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização horária de débito urinário e balanço hídrico. • Preferir hidratação por via oral/enteral com água livre se o trato gastrointestinal estiver funcionante (via mais fisiológica e segura).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Surgimento de convulsões durante a correção da hipernatremia (sinal de edema cerebral por correção excessivamente rápida -> infundir bolus de NaCl 3% 2 a 3 mL/kg para reverter o gradiente). ■■ Trombose de seios venosos durais e hemorragia intracraniana.

Retorno / Reavaliação: Dosagem seriada de sódio sérico e glicemia a cada 2 a 4 horas em UTI Pediátrica.

Diagnóstico 110: Hipocalemia Aguda e Reposição de Potássio (KCl)

CID-10: E87.6 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Potássio sérico (K+) < 3,5 mEq/L (grave se < 2,5-3,0 mEq/L ou com alterações no ECG: achatamento/inversão de onda T, infradesnívelamento de ST, aparecimento de onda U proeminente e aumento do intervalo QTc). Manifestações clínicas: fraqueza muscular ascendente, hiporreflexia, íleo paralítico e arritmias cardíacas.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Reposição Oral (Casos Leves/Assintomáticos K+ 3,0-3,5 mEq/L): Xarope de Cloreto de Potássio (KCl 6% ou 10%)	1 a 3 mEq/kg/dia (1 a 3 mL/kg/dia de KCl 6%) VO dividido em 2 a 3 tomadas junto com alimentos.	3 mEq/kg/dia (máx 40-60 mEq/dia)	Via preferencial e mais segura. Administrar com água ou suco para evitar irritação gástrica.
Reposição Intravenosa Contínua (Casos Graves K+ < 2,5 mEq/L ou ECG alterado): KCl 10% ou 19,1% diluído em SF 0,9%	0,3 a 0,5 mEq/kg/hora IV em infusão contínua em bomba ao longo de 2 a 4 horas sob monitorização cardíaca contínua.	Velocidade máxima periférica: 0,5 mEq/kg/hora (concentração máxima periférica: 40 a 60 mEq/L)	NUNCA ADMINISTRAR KCl EM BOLUS RÁPIDO OU DIRETO NA VEIA (risco de assistolia e parada cardíaca fatal instantânea). Concentrações > 60 mEq/L exigem acesso venoso central.

2ª Linha / Resgate: Sulfato de Magnésio 50% (25 a 50 mg/kg IV em 30 min) SE HIPOCALEMIA REFRATÁRIA (a hipomagnesemia bloqueia a Na+/K+ ATPase e impede a retenção renal de potássio; é impossível corrigir a hipocalemia sem corrigir o magnésio).

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização eletrocardiográfica contínua durante a infusão venosa de potássio. • Identificação e suspensão de perdas ativas (diuréticos de alça, vômitos, aspiração gástrica).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Arritmias ventriculares malignas e Torsades de Pointes. ■■ Paralisia da musculatura respiratória.

Retorno / Reavaliação: Dosagem de potássio sérico e magnésio a cada 2 a 4 horas durante a reposição parenteral.

Diagnóstico 111: Hipercalemia com Alterações Eletrocardiográficas

CID-10: E87.5 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Potássio sérico (K+) > 5,5-6,0 mEq/L (emergência médica se K+ > 6,5-7,0 mEq/L ou QUALQUER alteração no ECG). Sequência no ECG: 1) Ondas T altas, simétricas e apiculadas ('em tenda'); 2) Achatamento e desaparecimento de onda P com prolongamento de PR; 3) Alargamento de QRS; 4) Ritmo sinoventricular e fibrilação ventricular/assistolia.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
1ª Etapa: Estabilização de Membrana Miocárdica Imediata: Gluconato de Cálcio a 10% IV	0,5 a 1,0 mL/kg (50 a 100 mg/kg) de Gluconato de Cálcio 10% IV infundido lentamente em 3 a 5 minutos sob monitorização no ECG.	10 mL (1 g/dose)	NÃO REDUZ O POTÁSSIO SÉRICO, mas antagoniza imediatamente a cardiotoxicidade da hipercalemia e normaliza o ECG em 1 a 3 minutos. Pode repetir 1 vez após 5 min se ECG mantiver alterações.
2ª Etapa: Promotores de Influxo Celular de Potássio (Shifting Intra-celular)	a) Solução Glicosulada: Glicose 10% (5 mL/kg) + Insulina Regular (0,1 U/kg) IV infundidos em 30 minutos; b) Salbutamol Inalatório: 10 a 20 gotas ou 4 a 8 jatos em nebulização contínua; c) Bicarbonato de Sódio 8,4%: 1 mEq/kg IV se acidose metabólica associada.	Doses padrão	Reduzem o K+ sérico em 15 a 30 minutos ao direcioná-lo temporariamente para o meio intracelular.
3ª Etapa: Eliminação Definitiva de Potássio do Organismo	a) Furosemida: 1 a 2 mg/kg IV se função renal preservada; b) Poliestirenosulfonato de Cálcio (Sorcal): 0,5 a 1 g/kg VO ou retal a cada 6h com sorbitol.	Sorcal até 30 g/dose	Promovem excreção real do excesso de potássio.

2ª Linha / Resgate: Hemodiálise de emergência ou Diálise Peritoneal se hipercalemia refratária às medidas farmacológicas ou anúria/IRA hipercatabólica.

Medidas Não Farmacológicas: • Suspensão imediata de todas as fontes de potássio da dieta, nutrição parenteral e soros de manutenção. • Monitorização contínua em monitor cardíaco e desfibrilador à beira do leito.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Alargamento de QRS com ritmo sinusal bizarro (iminência de parada cardíaca em FV/assistolia).

Retorno / Reavaliação: ECG contínuo e ionograma a cada 1 a 2 horas em UTI Pediátrica.

Diagnóstico 112: Hipocalcemia Aguda Sintomática (Tetania e Convulsão)

CID-10: E83.5 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Crítérios Clínicos: Cálcio iônico < 1,0 mmol/L (ou Cálcio total < 8,5 mg/dL corrigido pela albumina), manifestando-se por irritabilidade neuromuscular extrema, parestesias, hiperreflexia, Sinal de Chvostek positivo (espasmo facial à percussão do nervo facial), Sinal de Trousseau positivo (espasmo carpopodal à insuflação do manguito de PA), laringoespasmo com estridor e crises convulsivas hipocalcêmicas.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Gluconato de Cálcio a 10% IV (Tratamento Imediato de Resgate)	1 a 2 mL/kg (100 a 200 mg/kg) de Gluconato de Cálcio 10% diluído em partes iguais de SG 5% infundido lentamente em 10 a 20 minutos sob monitorização cardíaca contínua.	10 a 20 mL (1 a 2 g de gluconato)	Infundir lentamente (risco de bradicardia grave e parada sinusal se infusão rápida). Interromper temporariamente se FC cair. Evitar extravasamento periférico (risco de necrose tecidual e calcinose cutânea).
Manutenção Contínua de Cálcio IV ou Oral	Manutenção IV: 200 a 500 mg/kg/dia de Gluconato de Cálcio 10% em infusão contínua; Manutenção Oral: Carbonato de Cálcio (50 a 100 mg/kg/dia de Ca elementar VO dividido a cada 6-8h) + Calcitriol (Vitamina D ativa 0,02 a 0,05 mcg/kg/dia).	Conforme níveis séricos	Transicionar para via oral assim que os sintomas agudos cessarem.

2ª Linha / Resgate: Sulfato de Magnésio 50% IV (25 a 50 mg/kg em 30 min) se hipomagnesemia concomitante (a hipomagnesemia causa resistência periférica ao PTH e bloqueia a secreção paratireoidiana).

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização do intervalo QTc no ECG (hipocalcemia prolonga o intervalo ST e QTc). • Investigação etiológica: hipoparatiroidismo congênito (Síndrome de DiGeorge), deficiência de vitamina D, raquitismo ou pancreatite aguda.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Laringoespasmo agudo com obstrução total de via aérea superior. ■■ Crise convulsiva generalizada e arritmias cardíacas.

Retorno / Reavaliação: Dosagem seriada de cálcio iônico a cada 4 a 6 horas em ambiente hospitalar.

Diagnóstico 113: Insuficiência Adrenal Aguda / Crise Addisoniana

CID-10: E27.2 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas (pico neonatal na Hiperplasia Adrenal Congênita)

Crítérios Clínicos: Colapso circulatório agudo e choque refratário a volume e catecolaminas, acompanhado de hipoglicemia grave, hiponatremia, hipercalemia, vômitos incoercíveis, dor abdominal, hiperpigmentação cutânea (na forma primária crônica) ou ambiguidade genital em recém-nascidos do sexo feminino (Hiperplasia Adrenal Congênita perdedora de sal).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO) IV / IM IMEDIATA (Dose de Estresse)	Bolus de Ataque Imediato: 50 a 100 mg/m² IV (ou: < 3 anos: 25 mg; 3 a 12 anos: 50 mg; > 12 anos: 100 mg IV). Manutenção: 50 a 100 mg/m²/dia IV dividido a cada 6 horas.	100 mg em bolus; 200 a 300 mg/dia	FÁRMACO SALVADOR DE VIDAS DE PRIMEIRA LINHA. NUNCA postergar a administração para aguardar resultados laboratoriais. A hidrocortisona possui ação glicocorticoide e mineralocorticoide combinada.
Ressuscitação Volêmica com Solução Fisiológica 0,9% + Glicose a 5% ou 10% IV	Bolus de 20 mL/kg IV em 20 a 30 minutos (repetir se choque), seguido de infusão contínua de SF 0,9% + SG 5% para correção da hipovolemia, hiponatremia e hipoglicemia.	Conforme metas hemodinâmicas	NUNCA adicionar potássio à solução de hidratação na fase inicial.

2ª Linha / Resgate: Fludrocortisona oral (Acetato de Fludrocortisona 0,05 a 0,2 mg/dia VO dose única) iniciada na fase de manutenção para reposição mineralocorticoide em insuficiência adrenal primária.

Medidas Não Farmacológicas: • Coleta rápida de sangue para dosagem de Cortisol, ACTH, 17-OH-progesterona, eletrólitos e glicemia antes do corticoide (se não atrasar a aplicação). • Aquecimento térmico passivo e monitorização em UTI Pediátrica.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Choque refratário com parada cardíaca por hipercalemia e hipovolemia.

Retorno / Reavaliação: Internação em UTI Pediátrica e acompanhamento conjunto com endocrinopediatria.

Diagnóstico 114: Hipotireoidismo Congênito no Lactente

CID-10: E03.1 | **Faixa Etária:** Recém-nascidos e lactentes jovens

Crítérios Clínicos: Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) com TSH elevado e T4 livre baixo. Sinais clínicos clássicos (tardios): icterícia neonatal prolongada (> 14 dias), fontanela posterior ampla (> 0,5 cm), macroglossia, hipotonia muscular, hérnia umbilical, choro rouco, constipação, pele seca e atraso importante no desenvolvimento neuropsicomotor.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Levotiroxina Sódica comprimido (T4 Sintético - Início Precoce)	10 a 15 mcg/kg/dia VO em dose única diária pela manhã.	15 mcg/kg/dia (aprox. 37,5 a 50 mcg/dia no recém-nascido)	O TRATAMENTO DEVE SER INICIADO OBRIGATORIAMENTE ANTES DOS 14 A 28 DIAS DE VIDA PARA GARANTIR DESENVOLVIMENTO COGNITIVO NORMAL E PREVENIR O CRETINISMO / DEFICIÊNCIA INTELECTUAL IRREVERSÍVEL. Como administrar: triturar o comprimido e diluir em poucas gotas de água ou leite materno em colher; NUNCA misturar com fórmulas de soja, ferro ou cálcio (bloqueiam a absorção).

2ª Linha / Resgate: Ajuste de dose guiado por dosagens periódicas de T4 livre e TSH sérico (meta: manter T4 livre na metade superior da faixa normal e TSH < 2-5 mIU/L no primeiro ano).

Medidas Não Farmacológicas: • Orientação familiar sobre adesão estrita diária sem interrupções. • Acompanhamento do ganho ponderal, crescimento estatural e marcos do neurodesenvolvimento.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■■ Sinais de subdosagem: letargia, constipação, desaceleração do crescimento e sonolência excessiva. ■■■ Sinais de superdosagem: irritabilidade, taquicardia, insônia, diarreia e sudorese.

Retorno / Reavaliação: Dosagem de TSH e T4 livre a cada 1 a 2 meses no primeiro ano de vida e a cada 2 a 3 meses entre 1 e 3 anos com endocrinopediatria.

MÓDULO 10: ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA E TRAUMATOLOGIA

Diagnóstico 115: Artrite Séptica Pediátrica

CID-10: M00.9 | **Faixa Etária:** Todas as idades (frequente em < 3 anos)

Crítérios Clínicos: Monoartrite aguda (predileção por quadril e joelho) com dor intensa à mobilização passiva e ativa, recusa em apoiar o membro / claudicação aguda, derrame articular, calor local, febre alta e toxemia (S. aureus, S. pyogenes, S. pneumoniae, Kingella kingae em < 4 anos). Critérios de Kocher para quadril: 1) Febre > 38,5°C; 2) Incapacidade de apoiar peso; 3) VHS > 40 mm/h; 4) Leucócitos > 12.000/mm³.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Artrocentese Descompressiva e Drenagem Articular Cirúrgica de Emergência	Lavagem articular e artrotomia por ortopedista pediátrico imediatamente.	Procedimento cirúrgico	EMERGÊNCIA ORTOPÉDICA ABSOLUTA. A pressão intracapsular elevada causa isquemia e necrose avascular da cabeça femoral e destruição da cartilagem articular em menos de 24 horas.
Antibioticoterapia Intravenosa Empírica Precoce: Oxacilina IV + Ceftriaxona IV	Oxacilina: 150 a 200 mg/kg/dia IV a cada 6h + Ceftriaxona: 80 a 100 mg/kg/dia IV 1x/dia por 3 a 4 semanas (mínimo 2 a 3 semanas IV antes de transição para VO com melhora clínica e queda de PCR).	Oxacilina 12 g/dia; Ceftriaxona 2 g/dia	Iniciar após coleta do líquido sinovial e hemoculturas.

2ª Linha / Resgate: Vancomicina (40-60 mg/kg/dia IV) ou Clindamicina (40 mg/kg/dia IV) se suspeita ou confirmação de CA-MRSA.

Medidas Não Farmacológicas: • Imobilização provisória da articulação em posição funcional e repouso absoluto no leito. • Analgesia venosa potente (Dipirona + Morfina se dor refratária). • Fisioterapia motora suave apenas após a fase inflamatória aguda.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■■ Necrose avascular da cabeça femoral / luxação patológica do quadril. ■■■ Sepses grave com choque. **Retorno / Reavaliação:** Internação hospitalar e acompanhamento diário com ortopedia pediátrica e infectologia.

Diagnóstico 116: Osteomielite Hematogênica Aguda

CID-10: M86.1 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas (metáfise de ossos longos: fêmur, tíbia, úmero)

Critérios Clínicos: Dor óssea metafisária localizada pontual intensa à palpação, calor e edema local, recusa de movimentação do membro (pseudoparalisia em lactentes), febre alta e elevação marcante de PCR e VHS (S. aureus sensível e MRSA em > 80% dos casos).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Oxacilina sódica frasco-ampola IV ou Cefazolina IV	Oxacilina: 150 a 200 mg/kg/dia IV dividido a cada 6 horas; OU Cefazolina: 100 mg/kg/dia IV a cada 8 horas.	Oxacilina 12 g/dia; Cefazolina 6 g/dia	Tratamento prolongado por 4 a 6 semanas totais (inicialmente IV até melhora clínica e normalização de PCR, completando com Cefalexina oral em dose alta de 100 mg/kg/dia).
Ceftriaxona IV (em < 3 meses e crianças com Anemia Falciforme)	100 mg/kg/dia IV em dose única diária.	2 g a 4 g/dia	Cobertura para Salmonella spp. e enterobactérias Gram-negativas obrigatória em pacientes falciformes.

2ª Linha / Resgate: Vancomicina IV ou Clindamicina IV se CA-MRSA; Desbridamento cirúrgico e drenagem de abscesso subperiosteal se flutuação ao USG/Ressonância ou falha de melhora em 48-72h de ATB.

Medidas Não Farmacológicas: • Ressonância Magnética precoce (exame mais sensível nas primeiras 48h; RX simples só mostra alterações líticas após 10 a 14 dias de evolução). • Imobilização e repouso.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Evolução para osteomielite crônica com sequestro e invólucro ósseo. ■■ Disseminação séptica metastática.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento sob internação com dosagem seriada de PCR a cada 48 a 72 horas.

Diagnóstico 117: Sinovite Transitória do Quadril

CID-10: M67.3 | Faixa Etária: 3 a 8 anos (pico 4 a 6 anos; predomínio masculino)

Critérios Clínicos: Claudicação aguda ('mancar') ou recusa de marcha de início súbito, dor no quadril ou joelho referida, amplitude de movimento levemente limitada (especialmente rotação interna e abdução), sem febre alta e com criança em EXCELENTE ESTADO GERAL, surgindo 1 a 2 semanas após infecção viral de vias aéreas superiores. Provas inflamatórias normais ou discretamente elevadas; USG com pequeno derrame anecóico simples.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Anti-inflamatório Não Esteroidal (Ibuprofeno ou Cetoprofeno oral)	Ibuprofeno: 10 mg/kg/dose VO a cada 8 horas com alimentos por 5 a 7 dias; OU Cetoprofeno gotas: 0,5 mg/kg/dose a cada 8h.	Ibuprofeno 400 mg/dose (1.200 mg/dia)	Acelera a resolução do derrame e alivia a dor rapidamente em 24 a 48 horas.
Dipirona ou Paracetamol se dor residual	Dose padrão conforme peso.	Dose padrão	Uso de resgate.

2ª Linha / Resgate: Diagnóstico de exclusão: se febre alta (> 38,5°C), leucocitose > 12.000 ou dor em repouso importante, investigar obrigatoriamente Artrite Séptica pelos critérios de Kocher.

Medidas Não Farmacológicas: • REPOUSO RELATIVO NO LEITO: evitar corridas, saltos e apoio forçado de peso até remissão da dor. • Tranquilização dos pais: processo inflamatório benigno, autolimitado e sem sequelas articulares a longo prazo.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Aparecimento de febre alta, calafrios ou toxemia. ■■ Piora da dor à mobilização passiva mínima do quadril. ■■ Persistência da claudicação além de 7 a 10 dias (investigar Doença de Legg-Calvé-Perthes).

Retorno / Reavaliação: Reavaliação clínica mandatória em 48 a 72 horas e após 1 semana.

Diagnóstico 118: Epifisiólise Proximal da Cabeça Femoral (SCFE)

CID-10: M93.0 | Faixa Etária: Adolescentes em estirão puberal (10 a 16 anos; associada a sobrepeso/obesidade)

Crítérios Clínicos: Escorregamento da epífise da cabeça femoral sobre o colo do fêmur através da placa fisária de crescimento. Manifesta-se por claudicação crônica ou aguda, marcha antálgica com membro inferior em ROTAÇÃO EXTERNA OBRIGATÓRIA (Sinal de Drehmann positivo: flexão passiva do quadril força a rotação externa) e DOR REFERIDA NA COXA ANTEROMEDIAL OU JOELHO (frequente armadilha diagnóstica).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
SUSPENSÃO IMEDIATA DO APOIO DE PESO E REPOUSO ABSOLUTO	Paciente deve ser colocado imediatamente em cadeira de rodas ou maca.	Restrição mecânica	NUNCA PERMITIR QUE O ADOLESCENTE CAMINHE OU APOIE O PÉ NO CHÃO (o apoio de peso continuado transforma um escorregamento estável em instável, multiplicando o risco de necrose avascular).
Fixação Cirúrgica Urgente com Parafuso Canulado In Situ	Procedimento ortopédico definitivo de urgência.	Cirurgia ortopédica	Avaliar profilaxia cirúrgica contralateral simultânea (risco de acometimento bilateral em 20-40% dos casos).

2ª Linha / Resgate: Analgesia sistêmica com Dipirona (1 g VO/IV) ou AINE até a abordagem cirúrgica.

Medidas Não Farmacológicas: • Radiografia de bacias em incidências AP e RÃ (Lauenstein) bilaterais (Linha de Klein alterada). • NUNCA tentar manobras de redução forçada fechada no PA (risco de lesão dos vasos retinaculares e necrose avascular catastrófica).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Incapacidade súbita de apoiar peso após trauma mínimo (epifisiólise instável / escorregamento agudo). ■■ Necrose avascular e condrólise.

Retorno / Reavaliação: Internação imediata e transferência para ortopedia pediátrica.

Diagnóstico 119: Pronação Dolorosa da Cabeça do Rádio (Subluxação do Rádio)

CID-10: S53.0 | Faixa Etária: 1 a 4 anos (pico 2 a 3 anos)

Crítérios Clínicos: Histórico clássico de TRAÇÃO LONGITUDINAL SÚBITA DO BRAÇO COM ANTEBRAÇO EM PRONAÇÃO (ex: puxar a criança pela mão para subir calçada ou tropeço). A criança chora de início, recusa-se a movimentar o membro afetado e mantém o braço aduzido ao corpo com o antebraço em pronação e cotovelo semi-fletido (pseudoparalisia), sem edema, calor ou deformidades visíveis.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Manobra de Redução Manual Fechada (Hiperpronação ou Supinação/Flexão)	Manobra de Hiperpronação (Maior taxa de sucesso na 1ª tentativa): 1) Apoiar o polegar sobre a cabeça do rádio no cotovelo; 2) Segurar a mão/punho da criança e realizar hiperpronação rápida e firme do antebraço. OU Manobra Clássica: supinação forçada seguida de flexão completa do cotovelo.	Manobra física	Um estalido tátil característico ('click') é sentido pelo examinador na cabeça do rádio no momento do reposicionamento do ligamento anular. Não exige radiografia prévia se história típica.

2ª Linha / Resgate: Se falha na 1ª tentativa: aguardar 10 a 15 minutos e repetir a manobra 1 vez. Se nova falha, solicitar Radiografia do cotovelo e antebraço para descartar fraturas (galho verde de ulna, fratura supracondiliana).

Medidas Não Farmacológicas: • A criança retoma o uso funcional completo e indolor do braço em 5 a 15 minutos após a manobra bem-sucedida (oferecer brinquedo ou objeto para testar o alcance ativo). • Orientar rigorosamente os pais e cuidadores a NUNCA puxar ou levantar a criança pelos braços/mãos.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Presença de edema volumoso, equimose, deformidade óssea ou histórico de trauma direto/queda de altura (contraindicação à manobra de redução; suspeita de fratura).

Retorno / Reavaliação: Alta imediata após recuperação motora ativa normal; sem necessidade de imobilização ou tipoia.

Diagnóstico 120: Fraturas Pediátricas Incompletas (Galho Verde e Deformidade Plástica)

CID-10: S52.9 | Faixa Etária: Lactentes, pré-escolares e escolares

Crítérios Clínicos: Fraturas exclusivas do esqueleto pediátrico decorrentes da alta elasticidade e periósteo espesso. Galho Verde: fratura incompleta com ruptura da cortical no lado da convexidade e encurvamento/periósteo íntegro no lado da concavidade; Toro / Torus (Impactação): enrugamento ou abaulamento da cortical óssea metafisária por compressão axial (ex: queda sobre a mão espalmada).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Imobilização Provisória com Tala Gessada Rígida no PA	Tala axilopalmar, antebraquiopalmar ou bota gessada (conforme o osso acometido), mantendo as articulações adjacentes imobilizadas em posição funcional neutra.	Imobilização ortopédica	NUNCA confeccionar aparelho gessado circular fechado na fase aguda inicial no pronto-socorro (risco de Síndrome Compartimental por edema pós-traumático).
Analgesia Sistêmica Regular (Dipirona + Paracetamol ou Ibuprofeno)	Dipirona 15-25 mg/kg ou Ibuprofeno 10 mg/kg VO a cada 6h de horário fixo nos primeiros 3 a 5 dias.	Dose padrão	Garante alívio eficaz da dor pós-fratura.

2ª Linha / Resgate: Redução incruenta sob sedação/anestesia se angulação significativa em galho verde; Fixação percutânea com fios de Kirschner se instabilidade.

Medidas Não Farmacológicas: • Crioterapia local indireta (bolsa de gelo protegida por pano sobre a tala) por 15-20 min a cada 3h nas primeiras 48h. • Elevação do membro acima do nível do coração para reduzir o edema.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■■ SINAIS DE SÍNDROME COMPARTIMENTAL: dor intensa desproporcional e refratária a opioides, dor excruciante ao estiramento passivo dos dedos, palidez, parestesia, paralisia e pulso ausente. ■■■ Dedos arroxeados frios ou dormência sob a tala.

Retorno / Reavaliação: Revisão ortopédica com RX de controle em 7 a 10 dias para verificar consolidação e alinhamento.

Diagnóstico 121: Entorse Aguda de Tornozelo e Joelho na Infância

CID-10: S93.4 / S83.5 | Faixa Etária: Escolares e adolescentes

Crítérios Clínicos: Lesão ligamentar por mecanismo rotacional ou inversão/eversão súbita durante atividade esportiva ou recreativa. Dor aguda, edema periarticular, equimose e dificuldade para apoiar o peso. Aplicação das Regras de Ottawa para Tornozelo na indicação de radiografia.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Protocolo PRICE / POLICE Imediato	Proteção (imobilizador/órtese) + Carga Otimizada + Gelo (Crioterapia) + Compressão elástica + Elevação do membro.	Não farmacológico	Gelo por 15 a 20 minutos a cada 2 a 3 horas nas primeiras 48 a 72 horas.
Anti-inflamatório Não Esteroidal (Ibuprofeno ou Cetoprofeno oral)	Ibuprofeno 10 mg/kg/dose VO a cada 8h por no máximo 3 a 5 dias.	1.200 mg/dia	Uso por tempo curto para não prejudicar a cicatrização ligamentar precoce.
Dipirona gotas ou comprimido	15 a 25 mg/kg/dose VO a cada 6h se dor.	1 g/dose	Analgesia de suporte.

2ª Linha / Resgate: Imobilização com bota ortopédica tipo Robofoot ou tala gessada por 7 a 10 dias em entorses de grau II e III (ruptura ligamentar parcial ou total).

Medidas Não Farmacológicas: • Radiografia indicada se: dor óssea à palpação dos 6 cm distais dos maléolos lateral/medial, dor sobre a base do 5º metatarso ou osso navicular, ou incapacidade de dar 4 passos no PA. • Reabilitação fisioterapêutica e treino proprioceptivo precoce.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■■ Fratura da placa de crescimento fisária (Salter-Harris I ou II de fíbula/tíbia distal - muito mais comum em crianças menores que lesão ligamentar pura). ■■■ Instabilidade articular grosseira.

Retorno / Reavaliação: Reavaliação ortopédica em 5 a 7 dias.

Diagnóstico 122: Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) - Forma Sistêmica e Oligoarticular

CID-10: M08.0 / M08.2 | Faixa Etária: < 16 anos (início frequente entre 1 e 6 anos)

Critérios Clínicos: Artrite com duração >= 6 semanas em crianças < 16 anos após exclusão de outras causas. Forma Sistêmica (Doença de Still): febre alta diária em agulhas ('pico vespertino') por >= 2 semanas associada a exantema macular róseo-salmão evanescente (fugaz durante os picos febris), hepatoesplenomegalia, serosite e provas inflamatórias altíssimas; Forma Oligoarticular: artrite em <= 4 articulações (joelhos, tornozelos) com alto risco de UVEÍTE ANTERIOR CRÔNICA ASSINTOMÁTICA.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
AIJ Oligoarticular: Infiltração Articular com Corticoide (Hexacetonida de Triancinolona)	Infiltração intra-articular por reumatopediatra (procedimento de primeira linha).	Procedimento especializado	Alta taxa de remissão articular prolongada com baixíssima toxicidade sistêmica.
Metotrexato oral ou subcutâneo (DMARD Modificador de Doença)	10 a 15 mg/m²/semana (ou 0,3 a 0,5 mg/kg/semana) em DOSE ÚNICA SEMANAL associado a Ácido Fólico (1 a 5 mg/semana 24-48h após o MTX).	25 mg/semana	Pilar central para formas poliarticulares ou oligoarticulares estendidas. Monitorar hemograma e transaminases.
AIJ Sistêmica: Corticoterapia Sistêmica (Prednisolona oral ou Metilprednisolona IV)	Prednisolona: 1 a 2 mg/kg/dia VO (máx 60 mg/dia); OU Pulsoterapia com Metilprednisolona 30 mg/kg/dia IV por 3 dias se gravidade sistêmica.	Metilprednisolona 1 g/dia	Controle rápido das manifestações sistêmicas inflamatórias graves.

2ª Linha / Resgate: Biológicos Inibidores de Citocinas: Tocilizumabe (Anti-IL-6) ou Anacinra/Canaquinumabe (Anti-IL-1) na AIJ Sistêmica; Anti-TNF (Adalimumabe/Etanercepte) na AIJ Poliarticular/Oligoarticular.

Medidas Não Farmacológicas: • AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA PERIÓDICA COM LÂMPADA DE FENDA a cada 3 a 6 meses para rastreamento de Uveíte Anterior Crônica (a uveíte na AIJ é assintomática e indolor, mas causa cegueira se não tratada precocemente). • Fisioterapia motora e manutenção da atividade física.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■■ SÍNDROME DE ATIVAÇÃO MACROFÁGICA (SAM / HLH secundária): complicação gravíssima da AIJ sistêmica caracterizada por febre contínua sem picos, queda abrupta de VHS paradoxal com elevação astronômica de Ferritina (> 5.000-10.000 ng/mL), plaquetopenia, coagulopatia e disfunção hepática.

Retorno / Reavaliação: Acompanhamento estrito contínuo com reumatologista pediátrico.

Diagnóstico 123: Púrpura de Henoch-Schönlein (Vasculite por IgA)

CID-10: D69.0 | Faixa Etária: 3 a 10 anos (pico 4 a 6 anos)

Critérios Clínicos: Vasculite leucocitoclástica de pequenos vasos mediada por depósitos de IgA. TETRADE CLÁSSICA: 1) PÚRPURA PALPÁVEL NÃO TROMBOCITOPÊNICA OBRIGATÓRIA simétrica com predileção por nádegas e membros inferiores; 2) Artrite/artralgia transitória de grandes articulações (joelhos, tornozelos); 3) Dor abdominal em cólica (isquemia submucosa / risco de intussuscepção); 4) Nefrite por IgA (hematúria e proteinúria). Contagem de plaquetas e coagulograma RIGOROSAMENTE NORMAIS.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Tratamento de Suporte e Sintomático (Maioria dos Casos)	Dipirona 10-25 mg/kg ou Paracetamol 10-15 mg/kg VO a cada 6h se dor articular ou desconforto.	Dose padrão	A doença é autolimitada em 4 a 6 semanas na maioria dos pacientes. Evitar AINes se suspeita de sangramento digestivo ou nefrite ativa.
Prednisona ou Prednisolona oral (se dor abdominal intensa ou nefrite)	1 a 2 mg/kg/dia VO (máx 60 mg/dia) por 1 a 2 semanas com desmame rápido ao longo de 2 semanas.	60 mg/dia	Indicada EXCLUSIVAMENTE para dor abdominal moderada a grave, hemorragia gastrointestinal, orquite intensa ou nefrite significativa. O CORTICOIDE NÃO PREVINE O SURGIMENTO DA NEFRITE OU RECIDIVAS DA PÚRPURA.

2ª Linha / Resgate: Pulsoterapia com Metilprednisolona IV ou Imunossupressores (Ciclofosfamida/Azatioprina) em glomerulonefrite rapidamente progressiva com crescentes na biópsia renal.

Medidas Não Farmacológicas: • Repouso relativo na fase aguda para reduzir o edema purpúrico de membros inferiores. • EAS (urina tipo 1) e aferição da pressão arterial semanais no primeiro mês e mensais por até 6 meses (o prognóstico a longo prazo é determinado exclusivamente pelo grau de acometimento renal).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■■ Dor abdominal súbita em cólica violenta com fezes em geleia de morango (Intussuscepção Intestinal - ponto de partida é o hematoma submucoso intestinal). ■■■ Hipertensão arterial, proteinúria nefrótica ou hematúria macroscópica.

Retorno / Reavaliação: Monitorização de função renal e EAS por 6 meses com pediatra/nefropediatra.

Diagnóstico 124: Miosite Aguda Pós-Viral (Gastrocnêmios)

CID-10: M60.9 | Faixa Etária: 3 a 10 anos (predomínio masculino; clássica pós-Influenza B e A)

Critérios Clínicos: Início súbito de DOR INTENSA E SIMÉTRICA NAS PANTURRILHAS (músculos gastrocnêmio e sóleo) com hipersensibilidade extrema à palpação e MARCHA NA PONTA DOS PÉS (marcha em equino) ou recusa absoluta de marcha, surgindo na fase de desfervescência (2º a 5º dia) de uma infecção gripal (Influenza). Elevação marcante e isolada de Creatinoquinase sérica (CK total > 1.000 a 50.000 U/L), com força muscular proximal e reflexos profundos normais.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Hidratação Oral Vigorosa e Fracionada ou Hidratação Venosa	Ingestão hídrica abundante com água e soro para garantir diurese clara e copiosa.	Livre	Pilar fundamental para prevenir a precipitação de mioglobina nos túbulos renais e evitar Injúria Renal Aguda se CK > 5.000-10.000 U/L.
Analgesia com Dipirona ou Paracetamol oral	Dipirona 15-25 mg/kg ou Paracetamol 10-15 mg/kg VO a cada 6 horas.	Dose padrão	EVITAR o uso de AINES (Ibuprofeno/Cetoprofeno) devido ao risco sinérgico de toxicidade renal associada à mioglobinúria transitória.

2ª Linha / Resgate: Internação hospitalar e hidratação parenteral com SF 0,9% + Bicarbonato de sódio se CK > 10.000 U/L, urina escura ou desidratação associada.

Medidas Não Farmacológicas: • Repouso absoluto no leito até alívio da dor muscular. • Vigilância rigorosa da coloração da urina (urina cor de 'chá / coca-cola' sugere mioglobinúria por rabdomiólise intensa). • Tranquilização dos pais: recuperação clínica completa e espontânea em 3 a 7 dias sem sequelas musculares.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Urina avermelhada ou castanho-escura (mioglobinúria com risco de IRA). ■■ Oligúria ou anúria. ■■ Fraqueza muscular progressiva proximal ou reflexos abolidos (investigar Síndrome de Guillain-Barré).

Retorno / Reavaliação: Dosagem de CK total e função renal após 48-72h se sintomas persistentes.

MÓDULO 11: TOXICOLOGIA E ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS

Diagnóstico 125: Intoxicação Aguda por Paracetamol (Acetaminofeno)

CID-10: T39.1 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Ingestão aguda tóxica de Paracetamol (> 150 a 200 mg/kg em crianças ou > 7,5 g em adolescentes). Risco de necrose hepática centrolobular fulminante mediada pelo metabólito tóxico NAPQI após depleção das reservas de glutathione. Aplicação do Nomograma de Rumack-Matthew com nível sérico de paracetamol dosado entre 4 e 24 horas pós-ingestão.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Carvão Ativado a 20% solução oral / SNG	1 g/kg (máx 50 g) VO ou via SNG administrado se a ingestão ocorreu há MENOS DE 1 A 2 HORAS.	50 g	Garante adsorção precoce no TGI. Não atrasar o início do antídoto se indicado.
ACETILCISTEÍNA (N-ACETILCISTEÍNA - NAC) Antídoto Específico IV	Protocolo Intravenoso de 3 Bolsas (Dose Total 300 mg/kg em 21 horas): 1) Dose de Ataque: 150 mg/kg em SG 5% (ou SF 0,9%) infundidos em 60 minutos; 2) 2ª Bolsa: 50 mg/kg em SG 5% infundidos em 4 horas; 3) 3ª Bolsa: 100 mg/kg em SG 5% infundidos em 16 horas.	Conforme protocolo	ANTÍDOTO SALVADOR DE VIDAS DE PRIMEIRA LINHA. Precursor direto da síntese de glutathione hepática. Eficácia de quase 100% na prevenção de hepatotoxicidade se iniciado nas primeiras 8 horas pós-ingestão. Pode causar reações anafilactoides não alérgicas (rubor, prurido) durante a 1ª bolsa (tratar com anti-H1 e diminuir velocidade da infusão sem suspender o tratamento).

2ª Linha / Resgate: Protocolo Oral de Acetilcisteína (Ataque 140 mg/kg VO seguido de 70 mg/kg a cada 4h por 17 doses = 72 horas) como alternativa se indisponibilidade de apresentação IV.

Medidas Não Farmacológicas: • Coleta de paracetamolemia sérica exatamente após 4 horas da ingestão (amostras colhidas antes de 4h não têm correlação com o nomograma). • Monitorização de transaminases (ALT/AST), TAP/RNI, gasometria e função renal. • Contato com Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox 0800-722-6001).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Insuficiência hepática aguda fulminante (elevação maciça de transaminases > 1.000-10.000 U/L, coagulopatia com RNI > 2,0-3,0, hipoglicemia e encefalopatia hepática). ■■ Acidose láctica grave precoce.

Retorno / Reavaliação: Internação hospitalar e dosagem de transaminases e RNI até término do protocolo.

Diagnóstico 126: Intoxicação Aguda por Salicilatos (Ácido Acetilsalicílico - AAS)

CID-10: T39.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Ingestão de dose tóxica de AAS (> 150 mg/kg leve; > 300-500 mg/kg grave). Distúrbio ácido-básico misto característico: ALCALOSE RESPIRATÓRIA precoce (por hiperestimulação direta do centro respiratório bulbar com hiperventilação) associada a ACIDOSE METABÓLICA COM ÂNION-GAP ELEVADO (por desacoplamento da fosforilação oxidativa mitocondrial e acúmulo de lactato e cetoácidos). Zumbido / acúfenos, hipertermia, taquipneia profunda, vômitos e desidratação.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Carvão Ativado em Doses Múltiplas (CADM) oral / SNG	1 g/kg no ataque, seguido de 0,5 g/kg a cada 4 horas por 2 a 3 doses.	50 g no ataque	O salicilato forma bezoares gástricos e tem absorção retardada; as doses múltiplas aceleram a depuração gastrointestinal.
Alcalinização Urinária com Bicarbonato de Sódio a 8,4% IV	1 a 2 mEq/kg IV em bolus, seguido de infusão contínua (ex: 100-150 mEq de NaHCO3 em 1L de SG 5% + 20-40 mEq de KCl a 1,5 a 2x a taxa de manutenção).	Titulado pelo pH	META: Manter o pH URINÁRIO entre 7,5 e 8,0 (promove armadilha iônica com ionização do salicilato, impedindo sua reabsorção tubular e multiplicando a excreção renal por 10 a 20 vezes) e manter o pH SÉRICO entre 7,45 e 7,50 (não ultrapassar 7,55). CORRIGIR OBRIGATORIAMENTE A HIPOCALEMIA (a hipocalemia impede a alcalinização urinária devido à troca renal de K+/H+).

2ª Linha / Resgate: HEMODIÁLISE DE EMERGÊNCIA (Tratamento definitivo de escolha) se: Salicilemia > 90-100 mg/dL aguda (ou > 50-60 mg/dL crônica), acidose grave refratária, insuficiência renal, edema pulmonar não cardiogênico ou deterioração do SNC (coma/convulsões).

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização contínua de pH urinário com fita reagente a cada hora. • Monitorização gasométrica e ionograma seriados.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Neuroglicopenia cerebral com glicemia sérica normal (salicilatos deplecionam a glicose no SNC). ■■ Edema cerebral e convulsões.

Retorno / Reavaliação: Internação em UTI Pediátrica e dosagem seriada de salicilemia.

Diagnóstico 127: Intoxicação por Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs)

CID-10: T39.3 | Faixa Etária: Lactentes e crianças (muito frequente por ingestão acidental de Ibuprofeno/Cetoprofeno)

Critérios Clínicos: Ingestão aguda acidental de formulações pediátricas líquidas. Doses < 100 mg/kg de ibuprofeno são tipicamente atóxicas; 100 a 400 mg/kg causam sintomas gastrointestinais leves (náuseas, vômitos, dor epigástrica); > 400 mg/kg podem causar sonolência, acidose metabólica, coma, convulsões, hipotensão e IRA.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Carvão Ativado a 20% solução oral	1 g/kg (máx 50 g) VO se ingestão > 200-400 mg/kg ocorrida há menos de 1 a 2 horas em paciente consciente com via aérea protegida.	50 g	Não realizar lavagem gástrica em pequenas doses assintomáticas.
Inibidor de Bomba de Prótons (Omeprazol ou Esomeprazol IV/VO)	1 mg/kg/dia VO ou IV a cada 12-24 horas.	40 mg/dia	Proteção da mucosa gástrica contra gastrite erosiva e sangramento digestivo por inibição de COX-1.

2ª Linha / Resgate: Hidratação venosa vigorosa com SF 0,9% para garantir excelente fluxo tubular renal e prevenir necrose tubular aguda por isquemia renal (inibição de prostaglandinas vasodilatadoras).

Medidas Não Farmacológicas: • Tratamento predominantemente de suporte. • Observação clínica de 4 a 6 horas no pronto-atendimento em ingestões leves.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Hipotensão e acidose metabólica grave. ■■ Sangramento digestivo alto (hematêmese/melena). ■■ Oligúria e elevação de escórias renais.

Retorno / Reavaliação: Alta após 6 horas de observação se paciente totalmente assintomático com ingestão < 200 mg/kg.

Diagnóstico 128: Intoxicação por Opioides e Uso de Naloxona

CID-10: T40.2 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: TRIÁDE CLÁSSICA OPIOIDE (TOXÍDROME OPIOIDE): 1) DEPRESSÃO RESPIRATÓRIA MARCADA (bradipneia grave ou apneia); 2) REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA (sedação profunda, estupor ou coma); 3) PUPILAS PUNTIFORMES MIÓTICAS ('em cabeça de alfinete'). Associada a bradicardia, hipotensão, hiporreflexia e hipomotilidade intestinal.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Ventilação com Pressão Positiva com Bolsa-Válvula-Máscara e O2 a 100%	Iniciar ventilação assistida imediatamente antes ou concomitantemente à medicação.	Suporte básico	A hipóxia é a principal causa de parada cardíaca na intoxicação por opioides.
NALOXONA 0,4 mg/mL solução injetável IV / IO / IM / Intranasal (Antídoto Específico)	Dose Inicial: 0,01 a 0,1 mg/kg IV/IO/IM/nasal (máx 2 mg por dose). Em parada respiratória ou apneia franca: 0,1 mg/kg IV imediato. Se resposta parcial, repetir a cada 2 a 3 minutos até restauração da respiração espontânea eficaz.	2 mg por dose (pode repetir até 10 mg total)	ANTÍDOTO ESPECÍFICO DE PRIMEIRA LINHA. Antagonista competitivo puro dos receptores opioides mu. META TERAPÊUTICA: RESTAURAR A VENTILAÇÃO ESPONTÂNEA ADEQUADA (não é necessário acordar completamente o paciente se ele estiver ventilando bem). ALERTA DE SEGURANÇA: A meia-vida da naloxona é de 30 a 60 minutos, que é MUITO MAIS CURTA do que a maioria dos opioides (Metadona, Morfina, Fentanil) -> O PACIENTE PODE VOLTAR A ENTRAR EM DEPRESSÃO RESPIRATÓRIA E COMA APÓS 30-60 MINUTOS (necessidade frequente de doses repetidas ou infusão contínua).

2ª Linha / Resgate: Infusão contínua de Naloxona (calcular 2/3 da dose que reverteu o quadro por hora em SG 5%) se intoxicação por opioides de liberação prolongada ou metadona.

Medidas Não Farmacológicas: • Monitorização contínua de oximetria de pulso, capnografia e frequência respiratória. • Observação hospitalar obrigatória por no mínimo 12 a 24 horas.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Recidiva da apneia e depressão respiratória após término do efeito da naloxona. ■■ Edema pulmonar não cardiogênico induzido por opioides.

Retorno / Reavaliação: Internação em leito de monitorização contínua ou UTI Pediátrica.

Diagnóstico 129: Intoxicação por Benzodiazepínicos e Uso Cauteloso de Flumazenil

CID-10: T42.4 | Faixa Etária: Lactentes, pré-escolares e adolescentes (tentativa de autoextermínio)

Critérios Clínicos: Toxídrome Sedativo-Hipnótica: sonolência excessiva, ataxia, disartria, hipotonia muscular, pupilas normais ou discretamente mióticas e reflexos diminuídos. Depressão respiratória grave é RARA na ingestão isolada de benzodiazepínicos por via oral, ocorrendo principalmente em coingestão com álcool, opioides ou barbitúricos.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Tratamento de Suporte e Proteção de Via Aérea (Pilar Central de Escolha)	Posicionamento lateral de segurança, oxigenioterapia e suporte ventilatório conforme necessidade.	Suporte clínico	A imensa maioria dos casos pediátricos evolui favoravelmente apenas com suporte clínico expectante e observação até metabolização do fármaco.
Flumazenil 0,1 mg/mL injetável IV (Antídoto Específico - USO ALTAMENTE RESTRITO)	0,01 mg/kg IV lento ao longo de 15 segundos (máx 0,2 mg). Se sem resposta em 1 minuto, pode repetir 0,01 mg/kg (máx 0,2 mg) a cada minuto até dose máxima cumulativa de 1 mg (ou 0,05 mg/kg).	0,2 mg/dose única e 1 mg cumulativo	CONTRAINDICAÇÕES CRÍTICAS E RISCO DE MORTE: NUNCA ADMINISTRAR FLUMAZENIL SE: 1) Histórico de epilepsia ou uso crônico de benzodiazepínicos (risco de ESTADO DE MAL EPILEPTICO REFRACTÁRIO FATAL por abstinência aguda); 2) Suspeita de coingestão com Antidepressivos Tricíclicos (desencadeia arritmias ventriculares malignas e convulsões intratáveis); 3) Ingestões de substâncias desconhecidas. O flumazenil deve ser reservado estritamente para reversão de sedação iatrogênica em procedimentos ou depressão respiratória isolada pura comprovada.

2ª Linha / Resgate: Carvão Ativado oral (1 g/kg) apenas se ingestão maciça há menos de 1 hora em paciente com via aérea perfeitamente pérvia ou intubado.

Medidas Não Farmacológicas: • Observação clínica contínua em ambiente hospitalar por 6 a 12 horas. • Glicemia capilar imediata para descartar hipoglicemia como causa do rebaixamento de consciência.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Depressão respiratória com hipóxia. ■■ Convulsões após uso inadvertido de flumazenil.

Retorno / Reavaliação: Alta após recuperação completa da vigília e marcha normal.

Diagnóstico 130: Ingestão de Bateria Tipo Botão e Múltiplos Ímãs (Corpos Estranhos de Alto Risco)

CID-10: T18.9 | **Faixa Etária:** Lactentes e pré-escolares (pico 1 a 4 anos)

Crítérios Clínicos: Ingestão acidental de Bateria de Lítio Tipo Botão (Button Battery) ou Múltiplos Ímãs de neodímio. BATERIA NO ESÔFAGO: EMERGÊNCIA ENDOSCÓPICA/CIRÚRGICA ABSOLUTA. A corrente elétrica local gera hidróxido de sódio (necrose por liquefação cáustica alcalina), perfuração esofágica, fístula aortoesofágica e morte em MENOS DE 2 HORAS. MÚLTIPLOS ÍMÃS: atraem-se através das paredes de alças intestinais vizinhas, causando isquemia por pressão, necrose, perfuração e peritonite.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
BATERIA NO ESÔFAGO: Remoção Endoscópica de Emergência Imediata (< 2 horas)	Endoscopia Digestiva Alta de urgência sob anestesia geral.	Procedimento imediato	NÃO POSTERGAR para aguardar jejum. O dano tecidual esofágico grave ocorre a partir de 15 a 30 minutos da fixação da bateria.
Medida Pré-Hospitalar / no PA: Administração Imediata de MEL PURO (em > 1 ano de idade)	10 mL (2 colheres de chá) de mel puro por via oral a cada 10 minutos (até 6 doses) enquanto se organiza a endoscopia.	60 mL	O mel atua como barreira física viscosa e substância levemente ácida, neutralizando a geração de álcalis e REDUZINDO SIGNIFICATIVAMENTE A PROFUNDIDADE DA LESÃO ESOFÁGICA. Não administrar mel em < 1 ano (risco de botulismo) ou se suspeita de perfuração iminente.

2ª Linha / Resgate: Radiografia Simples de Pescoço, Tórax e Abdome em 2 incidências (AP e Perfil) IMEDIATA: a bateria apresenta sinal do 'duplo anel / halo duplo' no AP e aspecto em 'degrau' no perfil (diferencia da moeda).

Medidas Não Farmacológicas: • Se a bateria já ultrapassou o estômago e está no intestino em paciente assintomático: conduta expectante com radiografias seriadas e observação de eliminação nas fezes. • MÚLTIPLOS ÍMÃS no estômago: remoção endoscópica urgente; se no intestino: acompanhamento cirúrgico estrito pelo risco de obstrução/fístula.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Hematêmese ou sangramento sentinela em orofaringe (fístula aortoesofágica fatal). ■■ Dor torácica súbita, enfisema subcutâneo cervical ou choque.

Retorno / Reavaliação: Internação hospitalar obrigatória e vigilância pós-remoção por até 14 a 28 dias pelo risco de fístula tardia.

Diagnóstico 131: Ingestão de Substâncias Cáusticas (Ácidos e Álcalis Fortes)

CID-10: T54.9 | **Faixa Etária:** 1 a 5 anos (ingestão acidental de saneantes/limpeza doméstica)

Crítérios Clínicos: Ingestão de soda cáustica (NaOH - necrose por liquefação profunda), potassa, alvejantes concentrados ou ácidos fortes (HCl - necrose por coagulação). Odinofagia grave, sialorreia intensa com incapacidade de deglutir, dor retroesternal/epigástrica, estridor inspiratório e queimaduras/ulcerações na mucosa oral.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
CONDUTAS ESTRITAMENTE PROIBIDAS (NÃO FAZER):	1) NUNCA PROVOCAR VÔMITOS / NÃO USAR EMÉTICOS; 2) NUNCA REALIZAR LAVAGEM GÁSTRICA; 3) NUNCA ADMINISTRAR CARVÃO ATIVADO; 4) NUNCA ADMINISTRAR AGENTES NEUTRALIZANTES (ex: vinagre para soda ou bicarbonato para ácido).	Procedimentos proibidos	Provocar vômitos reexpõe o esôfago e a laringe ao cáustico, duplicando a lesão e causando broncoaspiração/asfixia. A neutralização química gera reação exotérmica violenta com calor extremo e perfuração térmica maciça.
Analgesia Venosa Potente + Hidratação Venosa Imediata	Morfina 0,05 a 0,1 mg/kg IV ou Dipirona IV + Jejum absoluto.	Dose padrão	Garantir conforto e estabilização hemodinâmica.

2ª Linha / Resgate: Endoscopia Digestiva Alta (EDA) diagnóstica e prognóstica indicada idealmente entre 12 e 24 horas pós-ingestão (evitar nas primeiras 6h por subestimar a lesão e após 48-72h pelo alto risco de perfuração iatrogênica no período de necrose). Classificação de Zargar.

Medidas Não Farmacológicas: • Avaliação imediata de via aérea (risco de edema de glote e necrose laringotraqueal -> intubação com visualização direta ou traqueostomia se estridor). • Radiografia de tórax e abdome em ortostase para descartar pneumomediastino ou pneumoperitônio.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Estridor e insuficiência respiratória por edema laríngeo. ■■ Sinais de Perfuração Esofágica ou Gástrica (dor torácica/abdominal atroz, febre, choque e enfisema subcutâneo cervical).

Retorno / Reavaliação: Internação hospitalar obrigatória e acompanhamento a longo prazo para estenose esofágica cicatricial.

Diagnóstico 132: Acidente Escorpiônico Pediátrico (Tityus serrulatus)

CID-10: T63.2 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas (altíssima gravidade e mortalidade em < 5 a 7 anos)

Critérios Clínicos: Picada por escorpião-amarelo (T. serrulatus). Classificação de Gravidade do Ministério da Saúde: LEVE: apenas dor local intensa e parestesia; MODERADO: dor local intensa associada a manifestações sistêmicas (vômitos ocasionais, sudorese, sialorreia, agitação, taquicardia ou hipertensão); GRAVE: VÔMITOS PROFUSOS E INCOERCÍVEIS, sudorese profusa, sialorreia maciça, choque cardiogênico, arritmias, edema agudo de pulmão e convulsões.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Bloqueio Anestésico Local com Lidocaína a 1% ou 2% SEM VASOCONSTRITOR	Infiltração local/troncular de 1 a 3 mL de Lidocaína sem vasoconstritor no ponto da picada (pode repetir conforme dor).	4,5 mg/kg de lidocaína	Alívio imediato da dor local excruciante. NUNCA USAR ANESTÉSICO COM VASOCONSTRITOR. Compressas mornas locais também auxiliam.
SORO ANTIESCORPIÔNICO (SAEsc) ou SORO ANTIARACNÍDICO IV (SOROTERAPIA IMEDIATA)	a) Acidente Leve: NÃO INDICADO soro (apenas analgesia e observação por 6h); b) Acidente Moderado: 2 a 3 AMPOLAS IV de SAEsc em dose única infundida em 20-30 min; c) Acidente Grave: 4 a 6 AMPOLAS IV de SAEsc em dose única IMEDIATAMENTE.	6 ampolas	A DOSE DE SORO É FIXA EM NÚMERO DE AMPOLAS (NÃO É CALCULADA POR KG DE PESO) POIS A QUANTIDADE DE VENENO INOCULADA PELO ESCORPIÃO É A MESMA. Crianças pequenas recebem a mesma dose de ampolas que adultos (a gravidade é maior pela menor massa corporal).

2ª Linha / Resgate: Suporte Cardiovascular em UTI Pediátrica: Dobutamina ou Milrinona IV contínuo se choque cardiogênico com disfunção miocárdica induzida por catecolaminas; VNI/CPAP ou intubação para Edema Agudo de Pulmão.

Medidas Não Farmacológicas: • Lavar o local da picada apenas com água e sabão. • NUNCA fazer torniquete, garrote, incisões ou sucção no local da picada. • Monitorização contínua de ECG (arritmias e sobrecarga de VE) e ecocardiograma.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Vômitos precoces e repetidos (sinal preditor maior de evolução para envenenamento grave sistêmico). ■■ Edema Agudo de Pulmão e Choque Cardiogênico (principais causas de morte em crianças).

Retorno / Reavaliação: Acidente leve: observação hospitalar mínima de 6 horas. Acidente moderado/grave: internação em UTI Pediátrica.

Diagnóstico 133: Acidente Ofídico Botrópico (Jararaca - Bothrops spp.)

CID-10: T63.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas (responsável por > 85-90% dos acidentes ofídicos no Brasil)

Critérios Clínicos: Ações do veneno: Proteolítica/Inflamatória, Coagulante e Hemorrágica. Manifestações Locais: dor intensa imediata, edema endurecido progressivo, calor, equimose, bolhas e necrose local; Manifestações Sistêmicas: gengivorragia, epistaxe, hematúria, sangramento em locais de punção e incoagulabilidade sanguínea (Tempo de Coagulação > 30 min ou incoagulável). Classificação: Leve (edema local discreto, hemorragia discreta); Moderado (edema evidente acometendo mais de um segmento do membro); Grave (edema acometendo todo o membro, choque, hemorragia grave ou anúria).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
SORO ANTIBOTRÓPICO (SAB) ou ANTIBOTRÓPICO-LAQUÉTICO (SABL) IV IMEDIATO	a) Acidente Leve: 2 a 4 AMPOLAS IV em dose única; b) Acidente Moderado: 5 a 8 AMPOLAS IV em dose única; c) Acidente Grave: 10 a 12 AMPOLAS IV em dose única diluídas em SF 0,9% ou SG 5% infundidas em 20 a 60 minutos.	12 ampolas	A DOSE DE ANTIVENENO É FIXA EM NÚMERO DE AMPOLAS (NÃO DEPENDE DO PESO DA CRIANÇA). Iniciar o mais precocemente possível para neutralizar o veneno circulante e prevenir necrose tecidual e amputação.
Analgesia Sistêmica Regular (Dipirona IV ou Opioides)	Dipirona 15-25 mg/kg IV a cada 6h; Tramadol ou Morfina se dor intensa.	Dose padrão	CONTRAINDICADOS AINEs e AAS devido ao distúrbio de coagulação e risco de hemorragia e IRA.

2ª Linha / Resgate: Antibioticoterapia de cobertura para flora bucal da serpente (Ciprofloxacino + Clindamicina ou Ampicilina + Sulbactam) se necrose extensa ou infecção secundária comprovada; Fasciotomia cirúrgica se Síndrome Compartimental confirmada por manometria intracompartimental.

Medidas Não Farmacológicas: • Manter o membro elevado em posição funcional confortável para reduzir o edema. • NUNCA fazer garrote ou torniquete (concentra o veneno e acelera a necrose e gangrena). • Hidratação venosa vigorosa com SF 0,9% para prevenção de Injúria Renal Aguda.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Síndrome Compartimental de extremidades (membro tenso em madeira, dor atroz, parestesia). ■■ Insuficiência Renal Aguda anúrica (necrose tubular aguda por microtrombos e mioglobina). ■■ Choque hemorrágico ou choque vasogênico.

Retorno / Reavaliação: Internação hospitalar obrigatória e controle do Tempo de Coagulação (TC) a cada 12 e 24 horas (se sangue continuar incoagulável após 24h, administrar nova dose de 2 a 4 ampolas de SAB).

Diagnóstico 134: Acidente Ofídico Crotálico (Cascavel - Crotalus durissus)

CID-10: T63.0 | Faixa Etária: Todas as idades pediátricas

Critérios Clínicos: Ações do veneno: Neurotóxica, Miotóxica (Rabdomiólise) e Coagulante. QUADRO LOCAL QUASE DESPROVIDO DE SINAIS INFLAMATÓRIOS (apenas dor discreta ou parestesia, sem edema ou eritema importante). Manifestações Sistêmicas Marcantes: 1) Fáscties Miotênica / Neurotóxica de Rosenfeld (ptose palpebral bilateral, diplopia, oftalmoplegia, midríase, fáscties de 'bêbado / sonolento'); 2) Rabdomiólise aguda maciça com mialgia generalizada e URINA COR DE CHÁ ESCURO / COCA-COLA (mioglobínúria intensa); 3) Incoagulabilidade sanguínea.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
SORO ANTICROTÁLICO (SAC) ou ANTIBOTRÓPICO-CROTÁLICO IV IMEDIATO	a) Acidente Leve (neurotoxicidade discreta, sem mioglobínúria): 5 AMPOLAS IV em dose única; b) Acidente Moderado (fáscties neurotóxica evidente, urina avermelhada/âmbar): 10 AMPOLAS IV em dose única; c) Acidente Grave (fáscties nítida, urina marrom-escura/preta, oligúria ou choque): 20 AMPOLAS IV em dose única infundidas em 30 a 60 minutos.	20 ampolas	DOSE FIXA DE AMPOLAS INDEPENDENTE DO PESO. Iniciar imediatamente para estancar o dano miotóxico e a paralisia muscular respiratória.
Hidratação Venosa Agressiva para Prevenção de IRA por Mioglobínúria	Expansão e infusão de cristaloides (SF 0,9% + SG 5% a 1,5 a 2x o volume basal de Holliday-Segar) associada a Bicarbonato de Sódio para ALCALINIZAÇÃO URINÁRIA (alvo de pH urinário > 6,5-7,0) e MANUTENÇÃO DE DÉBITO URINÁRIO ELEVADO (> 2 mL/kg/h).	Volume titulado	A mioglobina em urina ácida precipita-se com a proteína de Tamm-Horsfall formando cilindros intratubulares obstrutivos e necrose tubular aguda irreversível.

2ª Linha / Resgate: Manitol a 20% (0,25 a 0,5 g/kg IV) ou Furosemida (1 mg/kg IV) como diuréticos osmóticos se débito urinário inadequado apesar de hidratação adequada comprovada; Hemodiálise precoce se IRA oligúrica anúrica.

Medidas Não Farmacológicas: • Sondagem vesical de demora para controle horário rigoroso do débito e coloração urinária. • Dosagem seriada de Creatinoquinase (CK total), desidrogenase láctica (LDH), ureia, creatinina, potássio e coagulograma.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Insuficiência Renal Aguda oligoanúrica hipercatabólica com hipercalemia grave. ■■ Paralisia da musculatura respiratória (necessidade de intubação traqueal e ventilação mecânica).

Retorno / Reavaliação: Internação em UTI Pediátrica e monitorização até clareamento total da urina e normalização das enzimas musculares e renais.

MÓDULO 12: NEONATOLOGIA E CUIDADOS IMEDIATOS

Diagnóstico 135: Icterícia Neonatal Hiperbilirrubinemia Indireta / Fototerapia

CID-10: P59.9 | Faixa Etária: Recém-nascidos nos primeiros 28 dias de vida

Crítérios Clínicos: Icterícia com progressão craniocaudal (Zonas de Kramer: 1=cabeça/pescoço ~6mg/dL; 2=tronco até umbigo ~9mg/dL; 3=hipogástrio e coxas ~12mg/dL; 4=braços e pernas ~15mg/dL; 5=palmas e plantas >18-20mg/dL). Avaliação do risco de neurotoxicidade (Kernicterus) utilizando o Nomograma de Bhutani (bilirrubina sérica total vs. idade cronológica em horas de vida).

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
FOTOTERAPIA DE ALTA EFICÁCIA (Tratamento Físico de Primeira Escolha)	Fototerapia com LED azul de alta irradiância (irradiância mínima > 30 mcg/cm²/nm) contínua posicionada a 30-40 cm do recém-nascido.	Físico contínuo	Promove fotoisomerização estrutural da bilirrubina indireta lipossolúvel na pele em lumirrubina hidrossolúvel, excretada diretamente na bile e urina sem necessidade de conjugação hepática.
Proteção Ocular Radiopaca Estéril Contínua	Uso de máscara/óculos de proteção ocular opacos durante todo o tempo sob a fototerapia.	Contínuo	Previne lesão e degeneração fotoquímica da retina.

2ª Linha / Resgate: Suspensão temporária da fototerapia apenas para mamadas curtas (20-30 min) se níveis de bilirrubina estiverem bem abaixo da linha de exsanguinotransfusão; não interromper se níveis críticos.

Medidas Não Farmacológicas: • Manutenção e estímulo intensivo ao aleitamento materno (aumenta o trânsito intestinal e reduz a circulação êntero-hepática de bilirrubina). • Manter a maior área de superfície corporal exposta à luz (RN apenas de fralda). • Controle rigoroso da temperatura corporal e estado de hidratação.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ ICTERÍCIA PRECOCE NAS PRIMEIRAS 24 HORAS DE VIDA (Sempre patológica - investigar doença hemolítica por incompatibilidade sanguínea). ■■ Sinais de Encefalopatia Bilirrubínica Aguda: sucção débil, letargia, hipotonia seguida de hipertonia com opistótono, choro agudo estridente e convulsões.

Retorno / Reavaliação: Dosagem de Bilirrubinas Total e Frações a cada 6 a 12 horas conforme a faixa de risco de Bhutani.

Diagnóstico 136: Icterícia por Incompatibilidade Rh / ABO e Exsanguinotransfusão

CID-10: P55.0 / P55.1 | Faixa Etária: Recém-nascidos

Crítérios Clínicos: Doença hemolítica isoimune perinatal. Incompatibilidade Rh (Mãe Rh negativo, RN Rh positivo, Coombs Direto positivo - hemólise grave) ou Incompatibilidade ABO (Mãe O, RN A ou B - hemólise mais frequente, geralmente moderada). Icterícia precoce < 24h, anemia hemolítica com reticulocitose (> 8-10%), hepatoesplenomegalia e velocidade de ascensão de bilirrubina > 0,5 mg/dL/hora.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Imunoglobulina Humana Intravenosa (IGIV) 10%	0,5 a 1,0 g/kg IV infundidos em 2 a 4 horas (pode repetir em 12 horas se persistência de ascensão rápida da bilirrubina).	1 g/kg/dose	Bloqueia os receptores Fc dos macrófagos no baço e fígado do RN, reduzindo a destruição de hemácias sensibilizadas e diminuindo a necessidade de exsanguinotransfusão.
Fototerapia Intensiva Dupla ou Tripla Contínua	Irradiância máxima cobrindo 360° do RN (luz superior + colchão de LED inferior).	Contínuo	Iniciar imediatamente enquanto se prepara o sangue para eventual exsanguinotransfusão.

2ª Linha / Resgate: EXSANGUINOTRANSFUSÃO TOTAL DE EMERGÊNCIA (Procedimento de Resgate Definitivo): troca de duas volemiás (2 × 80 mL/kg = 160 mL/kg) através de cateter venoso umbilical com alíquotas de 5 mL/kg em circuito fechado, se bilirrubina atingir a curva de corte de exsanguinotransfusão da AAP/SBP ou se sinais de encefalopatia aguda.

Medidas Não Farmacológicas: • Sangue total reconstituído homólogo, irradiado, desleucocitado e compatibilizado com soro materno. • Monitorização contínua de cálcio iônico durante a exsanguinotransfusão (o citrato do anticoagulante da bolsa quebra o cálcio -> repor 1 mL de Gluconato de Cálcio 10% a cada 100 mL de sangue trocado).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Kernicterus / Encefalopatia crônica (paralisia cerebral coreoatetoide, perda auditiva neurossensorial e displasia do esmalte dentário). ■■ Arritmias, PCR ou embolia gasosa durante a exsanguinotransfusão.

Retorno / Reavaliação: Internação em UTI Neonatal e controle laboratorial estrito pós-procedimento.

Diagnóstico 137: Sepses Neonatal Precoce (< 72 Horas de Vida)

CID-10: P36.9 | Faixa Etária: Recém-nascidos nas primeiras 72 horas de vida

Crítérios Clínicos: Infecção sistêmica bacteriana adquirida por transmissão vertical intrauterina ou intraparto (*Streptococcus agalactiae* / GBS, *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*). Fatores de risco maternos: corioamnionite materna (febre materna >= 38°C + taquicardia/leucocitose), rotura prematura de membranas ovulares (RPMO) >= 18 horas, colonização por GBS sem profilaxia intraparto adequada. Sinais clínicos no RN: instabilidade térmica (hipotermia ou febre), desconforto respiratório (gemência, taquipneia, tiragens), má perfusão, sucção fraca, letargia, distensão abdominal e hipotensão.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Ampicilina sódica IV + Gentamicina IV (Esquema Padrão-Ouro de Primeira Escolha)	Ampicilina: 100 a 150 mg/kg/dia IV dividido a cada 12 horas (a cada 8h se meningite associada na dose de 200-300 mg/kg/dia); + Gentamicina: 4 a 5 mg/kg/dose IV em dose única a cada 24 a 36 horas (conforme idade gestacional e peso). Duração: 7 a 10 dias (ou 14 a 21 dias se meningite/GBS).	Ampicilina 300 mg/kg/dia; Gentamicina 5 mg/kg/dia	A associação Ampicilina + Aminoglicosídeo possui sinergismo bactericida comprovado e excelente cobertura para os patógenos verticais mais comuns. EVITAR CEFALOSPORINAS DE 3ª GERAÇÃO (Ceftriaxona/Cefotaxima) de rotina na sepsis precoce (risco de indução rápida de resistência bacteriana e enterocolite necrosante; a Ceftriaxona desloca a bilirrubina da albumina e precipita com o cálcio).

2ª Linha / Resgate: Cefotaxima IV (100 a 150 mg/kg/dia a cada 8-12h) como substituta da gentamicina se insuficiência renal neonatal aguda ou meningite por Gram-negativo.

Medidas Não Farmacológicas: • Coleta obrigatória de Hemocultura (mínimo 1 mL de sangue) e Punção Lombar para líquido antes do início dos antibióticos. • Controle térmico em incubadora aquecida de dupla parede e suporte respiratório imediato.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Choque séptico refratário com acidose metabólica grave e coagulação intravascular disseminada (CIVD). ■■ Apneias frequentes e falência respiratória.

Retorno / Reavaliação: Internação em UTI Neonatal e reavaliação clínica e laboratorial diária.

Diagnóstico 138: Sepses Neonatal Tardia (> 72 Horas de Vida)

CID-10: P36.9 | Faixa Etária: Neonatos com > 72 horas de vida (hospitalizados ou comunitários)

Crítérios Clínicos: Infecção sistêmica adquirida no ambiente nosocomial/hospitalar (UTIN) ou comunitário. Patógenos hospitalares: *Staphylococcus coagulase-negativa* (*S. epidermidis* em > 50%), *Staphylococcus aureus* (MSSA/MRSA), *Klebsiella pneumoniae* (KPC/ESBL), *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens* e *Candida* spp. Manifestações clínicas: instabilidade térmica súbita, aumento de apneias, piora do suporte ventilatório, intolerância alimentar com resíduos gástricos biliosos e letargia.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Esquema Hospitalar Empírico Inicial: Oxacilina IV (ou Vancomicina IV) + Amicacina IV (ou Cefepima IV)	Vancomicina: 10 a 15 mg/kg/dose IV a cada 8 a 18h (conforme idade gestacional corrigida e peso); + Amicacina: 15 mg/kg/dose IV a cada 24 a 36h; OU Oxacilina: 100 a 150 mg/kg/dia + Cefepima: 100 mg/kg/dia IV a cada 12h.	Doses ajustadas por peso/idade	Ajustar o esquema conforme o perfil de sensibilidade e microbiota prevalente da unidade neonatal (CCIH).

2ª Linha / Resgate: Meropenem IV (20 a 40 mg/kg/dose a cada 8-12h) se sepsis grave por Gram-negativos multirresistentes; Anfotericina B Lipossomal (3 a 5 mg/kg/dia IV) ou Fluconazol se suspeita de Sepsis Fúngica por *Candida* (fatores de risco: prematuridade extrema < 1.000g, uso prévio de cefalosporinas/carbapenênicos, NPT e cateter central).

Medidas Não Farmacológicas: • Remoção imediata ou troca de cateter venoso central suspeito de infecção de corrente sanguínea. • Coleta de culturas completas (sangue periférico, ponta de cateter, urina por sondagem de alívio e líquido).

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Enterocolite Necrosante fulminante associada (pneumatose intestinal e perfuração). ■■ Plaquetopenia severa (< 50.000/mm³) e sangramentos.

Retorno / Reavaliação: Ajuste diário em UTI Neonatal guiado pelos resultados de hemoculturas.

Diagnóstico 139: Síndrome do Desconforto Respiratório Neonatal (SDR / Doença da Membrana Hialina)

CID-10: P22.0 | **Faixa Etária:** Recém-nascidos prematuros (< 34-37 semanas de idade gestacional)

Critérios Clínicos: Deficiência primária de surfactante pulmonar alveolar endógeno decorrente da imaturidade anatômica e funcional. Manifesta-se nos primeiros minutos a horas de vida por taquipneia progressiva, gemência expiratória audível, retração intercostal/esternal importante, batimento de asa nasal e cianose. Radiografia de tórax clássica com infiltrado reticulogranular difuso homogêneo ('vidro fosco / vidro moído') e broncogramas aéreos com redução dos volumes pulmonares.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
CPAP Nasal Precoce em Sala de Parto (Estratégia Não Invasiva de Escolha)	Iniciar CPAP nasal com PEEP de 5 a 6 cmH2O e FiO2 de 0,21 a 0,30 imediatamente na sala de parto em prematuros com respiração espontânea.	Suporte ventilatório	Mantém a capacidade residual funcional, previne o colapso alveolar expiratório e reduz drasticamente a necessidade de intubação mecânica e lesão pulmonar induzida por ventilador.
SURFACTANTE PULMONAR EXÓGENO (Poractanto Alfa ou Beractanto) Endotraqueal	Poractanto Alfa (Curosurf): Dose inicial de 200 mg/kg (2,5 mL/kg) via endotraqueal; Beractanto (Survanta): 100 mg/kg (4 mL/kg). Administrado preferencialmente por técnicas minimamente invasivas (LISA / MIST - com cateter fino sob CPAP) ou método INSURE (Intubar-Surfactante-Extubar para CPAP).	200 mg/kg no ataque (doses adicionais de 100 mg/kg se FiO2 > 0,30)	TERAPÊUTICA SALVADORA DE VIDAS. Iniciar precocemente nas primeiras 2 a 3 horas de vida se o RN em CPAP apresentar FiO2 > 0,30 para manter SpO2 90-95%.

2ª Linha / Resgate: Segunda dose de surfactante (100 mg/kg) após 6 a 12 horas se persistência de necessidade ventilatória elevada (FiO2 > 0,30-0,40) e RX com doença da membrana hialina persistente.

Medidas Não Farmacológicas: • Alvo rigoroso de saturação de oxigênio em prematuros: SpO2 entre 90% e 94-95% (evitar hiperóxia com SpO2 > 95% pelo risco de Retinopatia da Prematuridade - ROP e Displasia Broncopulmonar - DBP). • Termorregulação estrita e umidificação de vias aéreas.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Pneumotórax hipertensivo agudo por barotrauma/volutrauma. ■■ Hemorragia pulmonar maciça pós-surfactante.

Retorno / Reavaliação: Monitorização contínua de mecânica pulmonar e gasometrias seriadas em UTI Neonatal.

Diagnóstico 140: Taquipneia Transitória do Recém-Nascido (TTRN / Pulmão Úmido)

CID-10: P22.1 | **Faixa Etária:** Recém-nascidos a termo ou pré-termos tardios nascidos de PARTO CESÁREO ELETIVO SEM TRABALHO DE PARTO

Critérios Clínicos: Retardo na reabsorção e depuração do líquido pulmonar fetal pelos canais epiteliais de sódio (ENaC). Início precoce nas primeiras 2 horas de vida com taquipneia (FR > 60-80 irpm), tiragem intercostal leve a moderada e gemência leve que melhoram com baixas frações de oxigênio. RX de tórax: congestão hilar, trama vascular proeminente, espessamento de cissuras interlobares ('líquido na cissura') e hiperinsuflação com diafragmas retificados.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Oxigenioterapia de Baixo Fluxo (Cânula Nasal ou Hood)	Oferta de O2 para manter SpO2 entre 92% e 96% (FiO2 baixa, geralmente < 0,30-0,40).	Titulado	Doença benigna e autolimitada; a grande maioria dos casos tem resolução espontânea e completa em 24 a 72 horas com a reabsorção fisiológica do líquido pulmonar pelos vasos linfáticos.
CPAP Nasal com Baixa Pressão (se taquipneia moderada)	PEEP de 4 a 5 cmH2O por 12 a 24 horas.	Suporte	Facilita a drenagem linfática do líquido alveolar residual.

2ª Linha / Resgate: DIURÉTICOS (Furosemda) E CORTICOIDES SÃO CONTRAINDICADOS E INEFICAZES na TTRN.

Medidas Não Farmacológicas: • Alimentação por sonda nasogástrica ou jejum com hidratação venosa transitória se FR > 70-80 irpm para prevenir broncoaspiração durante as mamadas. • Ambiente térmico neutro e manipulação mínima.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Piora progressiva do padrão respiratório com necessidade de FiO2 > 0,40-0,50 após 24h de vida (investigar infecção neonatal / pneumonia ou cardiopatia congênita). ■■ Pneumotórax.

Retorno / Reavaliação: Monitorização em leito de cuidados intermediários neonatais até desmame completo do suporte respiratório.

Diagnóstico 141: Apneia da Prematuridade e Citrato de Cafeína

CID-10: P28.4 | Faixa Etária: Recém-nascidos prematuros (< 34 semanas de gestação)

Critérios Clínicos: Pausa respiratória com duração >= 20 segundos OU pausa de menor duração acompanhada de BRADICARDIA (FC < 100 bpm) e/ou QUEDA DA SATURAÇÃO (cianose / SpO2 < 85%), decorrente da imaturidade intrínseca do centro respiratório bulbar e quimiorreceptores.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
CITRATO DE CAFEÍNA solução oral ou injetável IV (Dose Padrão CAP Trial)	Dose de Ataque: 20 mg/kg IV ou VO em dose única lenta (equivalente a 10 mg/kg de cafeína base); Dose de Manutenção: 5 a 10 mg/kg/dia IV ou VO em dose única diária iniciada 24 horas após o ataque.	20 mg/kg de ataque; 10 mg/kg/dia manutenção	FARMACOTERAPIA DE ESCOLHA ABSOLUTA. Metilxantina que estimula o centro respiratório bulbar, aumenta a sensibilidade ao CO2, melhora a contratilidade diafragmática e reduz a necessidade de ventilação mecânica e a incidência de Displasia Broncopulmonar (DBP). Ampla margem terapêutica; não exige monitorização de nível sérico de rotina.
CPAP Nasal ou Cânula Nasal de Alto Fluxo (CNAF)	Pressão contínua nas vias aéreas com PEEP de 4 a 6 cmH2O.	Suporte não invasivo	Mantém a patência da faringe e reduz o componente obstrutivo das apneias mistas.

2ª Linha / Resgate: Aminofilina IV (ataque 5-6 mg/kg e manutenção 1,5 a 3 mg/kg a cada 8-12h) apenas como alternativa de segunda linha se indisponibilidade de cafeína (exige monitorização sérica pelo risco de arritmias e toxicidade).

Medidas Não Farmacológicas: • Estimulação tátil suave durante os episódios agudos de apneia. • Posicionamento da cabeça em posição neutra (evitar flexão ou hiperextensão do pescoço que cause obstrução da via aérea). • Manter a cafeína até 34 a 36 semanas de idade gestacional corrigida e suspender quando o prematuro estiver sem apneias por pelo menos 5 a 7 dias.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Apneias graves que exigem ventilação com pressão positiva (BVM). ■■ Apneias de início tardio ou súbito em prematuro previamente estável (investigar Sepsis Tardia, Enterocolite Necrosante, hemorragia peri-intraventricular ou distúrbios hidroeletrólíticos).

Retorno / Reavaliação: Monitorização cardiorrespiratória contínua em UTI Neonatal.

Diagnóstico 142: Hipotermia Neonatal e Reaquecimento Controlado

CID-10: P80.9 | Faixa Etária: Recém-nascidos (maior suscetibilidade em prematuros e PIG)

Critérios Clínicos: Temperatura corporal axilar < 36,5°C (Leve / Estresse pelo frio: 36,0 a 36,4°C; Moderada: 32,0 a 35,9°C; Grave: < 32,0°C). Manifestações clínicas: extremidades frias, palidez, cianose periférica, sucção débil, letargia, bradicardia, taquipneia ou apneia, esclerema neonatal (endurecimento da pele e tecido celular subcutâneo) e acidose metabólica grave.

Medicamento / Apresentação	Posologia e Cálculo Ponderal	Dose Máxima	Alertas e Cuidados
Reaquecimento Lento e Gradual em Incubadora de Dupla Parede ou Berço Aquecido	Ajustar a temperatura da incubadora para 1,0 a 1,5°C acima da temperatura do RN, promovendo ELEVAÇÃO GRADUAL DA TEMPERATURA CORPORAL À TAXA DE 0,5 A 1,0°C POR HORA até atingir a faixa de normotermia (36,5 a 37,5°C).	Velocidade controlada	REGRA CRÍTICA: NUNCA REAQUECER O RECÉM-NASCIDO RAPIDAMENTE. O reaquecimento rápido provoca vasodilatação periférica maciça e súbita, desvio de fluxo sanguíneo do centro para a periferia, HIPOTENSÃO ARTERIAL SEVERA, CHOQUE E APNEIA FATAL.
Solução Glicosada a 10% IV (Prevenção e Correção de Hipoglicemia)	Infundir SG 10% com TIG de 4 a 6 mg/kg/min IV.	TIG de suporte	O recém-nascido hipotérmico consome rapidamente suas reservas de glicose e oxigênio na termogênese sem tremor (metabolização da gordura marrom).

2ª Linha / Resgate: Expansão volêmica com SF 0,9% (10 mL/kg IV em 30 min) se hipotensão refratária durante o processo de reaquecimento.

Medidas Não Farmacológicas: • Uso de saco plástico de polietileno transparente (sem secar o corpo) e touca de lã/algodão para prematuros < 32 semanas em sala de parto. • Contato pele a pele (Método Canguru) para hipotermia leve em recém-nascidos a termo estáveis. • Controle da temperatura axilar a cada 30 a 60 minutos durante todo o processo de reaquecimento.

Sinais de Alarme (Red Flags): ■■ Hipotermia grave (< 32°C) com hemorragia pulmonar maciça e coagulopatia de consumo. ■■ Acidose metabólica persistente e arritmias cardíacas.

Retorno / Reavaliação: Monitorização contínua de temperatura em leito de UTI Neonatal até estabilização térmica sustentada por > 24 horas.